

خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030
نحو إزالة الضرر الذي يمكن تجنبه في
قطاع الرعاية الصحية





خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030

نحو إزالة الضرر الذي يمكن تجنبه في
قطاع الرعاية الصحية

خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030: نحو إزالة الضرر الذي يمكن تجنبه في قطاع الرعاية الصحية

ISBN 978-92-4-006242-9 (نسخة إلكترونية)

ISBN 978-92-4-006243-6 (نسخة مطبوعة)

© منظمة الصحة العالمية 2022

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف - غير تجاري - المشاركة بالمثل 3.0" لفائدة المنظمات الحكومية الدولية

(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar>)

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه ولأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبين أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحويل هذا المصنف، فيجب عندئذ الحصول على ترخيص لمصنّفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: «هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية».

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules>).

الاقتباس المقترح. خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030: نحو إزالة الضرر الذي يمكن تجنبه في قطاع الرعاية الصحية
جنيف: منظمة الصحة العالمية: 2022. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط <http://apps.who.int/iris>

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط <http://apps.who.int/bookorders>. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط <https://www.who.int/ar/copyright>.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبت في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليك مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المنقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلاكية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحة كانت أم ضمنية. ويتحمل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

التصميم والتخطيط:

Macro Graphics Pvt. Ltd., India

المحتويات

v	ملخص تنفيذي
viii	أمانة عامة عن خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030
1	1 مقدمة
1-1	1-1 معلومات أساسية
1-1-1	1-1-1 نشأة التفكير في مسألة سلامة المرضى
2-1-1	2-1-1 العبء العالمي للرعاية غير المأمونة
3-1-1	3-1-1 تطور الحركة العالمية لسلامة المرضى
4-1-1	4-1-1 مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): مفهوم أوسع للأذى الذي يمكن تجنبه
2-1	2-1 الولاية
3-1	3-1 عملية التطوير
2	2 الرؤية والرسالة الهدف
3	3 المبادئ التوجيهية
1-3	1-3 إشراك المرضى والأسر كشركاء في الرعاية المأمونة
2-3	2-3 تحقيق النتائج من خلال العمل التعاوني
3-3	3-3 تحليل البيانات وتبادلها لتوليد التعلم
4-3	4-3 ترجمة البَيِّنَات إلى تحسينات قابلة للتطبيق والقياس
5-3	5-3 وضع السياسات والإجراءات على أساس طبيعة إطار الرعاية
6-3	6-3 الاستفادة من الخبرة العلمية وتجربة المرضى على حد سواء لتحسين سلامة المرضى
7-3	7-3 ترسيخ ثقافة السلامة لدى تصميم الرعاية الصحية وتقديمها
4	4 شركاء في العمل
1-4	1-4 الحكومات
2-4	2-4 مرافق الرعاية الصحية وخدماتها
3-4	3-4 أصحاب المصلحة
4-4	4-4 أمانة منظمة الصحة العالمية

5	إطار العمل	13
	الهدف الاستراتيجي 1 - السياسات الرامية إلى إزالة الأذى الذي يمكن تجنبه	16
	الهدف الاستراتيجي 2 - نظم عالية الموثوقية	23
	الهدف الاستراتيجي 3 - سلامة العمليات السريرية	31
	الهدف الاستراتيجي 4 - إشراك المرضى والأسر	40
	الهدف الاستراتيجي 5 - تثقيف العاملين الصحيين، ومهاراتهم وسلامتهم	48
	الهدف الاستراتيجي 6 - المعلومات والبحوث وإدارة المخاطر	54
	الهدف الاستراتيجي 7 - التأزر والشراكة والتضامن	63
6	لتنفيذ	69
	1.6 خيارات سياساتية لتنفيذ خطة العمل العالمية	69
	2.6 المعالم الرئيسية في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى	69
7	الرصد والإبلاغ	73
	1-7 المؤشرات الرئيسية	73
	2-7 المؤشرات المتقدمة	77
8	مواومة مجال سلامة المرضى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة	79
9	تخطيط قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 72-6 لخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030	83
	شكر وتقدير	88
	ببليوغرافيا	90
	مسرد	91
	المراجع	95

ملخص تنفيذي

عالمية بشأن سلامة المرضى بالتشاور مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

ووافقت جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين (في عام 2021) على القرار ج ص ع 74 (13) الذي ينص على اعتماد خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 ومطالبة المدير العام بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين في عام 2023 وبعد ذلك كل عامين حتى عام 2031.

ما هي سلامة المرضى؟

سلامة المرضى هي: "إطار للأنشطة المنظمة التي تولّد ثقافات وعمليات واجراءات وسلوكيات وتكنولوجيات وبيئات في مجال الرعاية الصحية التي تعمل على التقليل من المخاطر بشكل مستمر ومستدام، والحد من حدوث أذى يمكن تجنبه، وتجعل وقوع الخطأ أقل احتمالاً وتحد من تأثيره لدى حدوثه".

ما هو حجم مشكلة الرعاية غير المأمونة؟

تتعرض كل عام أعداد كبيرة من المرضى للأذى أو الموت بسبب الرعاية الصحية غير المأمونة، مما يتسبب في ارتفاع عبء الوفيات والإعاقة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي المتوسط، يتعرض مريض واحد من كل 10 مرضى لحدث ضائر أثناء تلقيه الرعاية في المستشفيات في البلدان المرتفعة الدخل. وتشير البَيِّنَات المتاحة إلى وقوع 134 مليون حدث ضائر بالمستشفيات في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، مما يساهم في حدوث حوالي 2,6 مليون حالة

لماذا نحتاج إلى خطة عمل عالمية بشأن سلامة المرضى؟

في وقتنا الراهن، يشكل الأذى الذي يلحق بالمرضى بسبب الرعاية غير المأمونة تحدياً كبيراً ومتزايداً يهدد الصحة العامة على الصعيد العالمي، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم. ويمكن تجنب معظم جوانب هذا الأذى الذي يلحق بالمرضى. وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان جاهدة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة، فقد تضعف الرعاية غير المأمونة مفعول الآثار المفيدة المترتبة على تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية. وقد تسبب الحوادث المتصلة بسلامة المرضى الوفاة والإعاقة والمعاناة للضحايا وأسرهم. وتكون التكاليف المالية والاقتصادية الناجمة عن أوجه قصور إجراءات السلامة مرتفعة. وغالباً ما يقل مستوى ثقة واطمئنان الجمهور إزاء النظم الصحية المحلية لدى الإعلان عن هذه الحوادث. وقد يعاني العاملون الصحيون الذي تسببوا في وقوع حوادث خطيرة أدت إلى موت أحد المرضى أو إلحاق أذى جسيم به من ضرر نفسي مستمر ومشاعر عميقة بالذنب والنقد الذاتي.

وقد أدرك واضعو السياسات والقادة السياسيون والصحيون في جميع أنحاء العالم الفوائد الناجمة عن اعتماد نهج استراتيجي ومنسق إزاء سلامة المرضى، ومعالجة الأسباب الشائعة للضرر، والنهج اللازمة لمنع وقوعه. وبلغت الدعوة العالمية ذروتها في السنوات الأخيرة باعتماد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين (في عام 2019) للقرار ج ص ع 72-6 بشأن "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى".

ويحث هذا القرار الدول الأعضاء - وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي - على أن تعترف بسلامة المرضى باعتبارها أولوية صحية في سياسات قطاع الصحة وبرامجه بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وطلبت جمعية الصحة العالمية أيضاً من منظمة الصحة العالمية أن تضع خطة عمل

وفاة سنوياً بسبب انعدام الرعاية المأمونة. ووفقاً للتقديرات الأخيرة، يمكن أن تقدر التكلفة الاجتماعية للضرر الذي يلحق بالمرضى بمبلغ يتراوح بين تريليون و2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.

كيف سيبدو النجاح؟

تسعى خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى إلى إزالة الأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية من خلال رؤية تتمثل في إيجاد "عالم لا يتعرض فيه أحد للأذى في مجال الرعاية الصحية، ويتلقى فيه كل مريض رعاية مأمونة ومحترمة في أي وقت ومكان.

وتتمثل الغاية النهائية في الحدّ بأقصى قدر ممكن من الأذى الناتج عن الرعاية الصحية غير المأمونة والذي يمكن تجنبه، على الصعيد العالمي.

وتتمثل رسالة خطة العمل العالمية في دفع السياسات والاستراتيجيات والإجراءات قُدماً، بالاستناد إلى العلم وخبرات المرضى وتصميم النظم والشراكات، من أجل إزالة جميع مصادر المخاطر والأذى التي قد يتعرض لها المرضى والعاملون الصحيون والتي يمكن تلافيها.

ما هي المبادئ التي ستوجّه عملية التنفيذ؟

ترسي سبعة مبادئ توجيهية القيم الأساسية اللازمة لصياغة عملية وضع خطة العمل وتنفيذها:

- إشراك المرضى والأسر كشركاء في الرعاية المأمونة؛
- تحقيق النتائج من خلال العمل التعاوني؛
- تحليل البيانات وتبادلها لتوليد التعلم؛
- ترجمة البَيِّنَات إلى تحسينات قابلة للتطبيق والقياس؛
- وضع السياسات والإجراءات على أساس طبيعة إطار الرعاية؛
- الاستفادة من الخبرة العلمية وتجربة المرضى على حد سواء لتحسين سلامة المرضى؛
- ترسيخ ثقافة السلامة لدى تصميم الرعاية الصحية وتقديمها.

من هم شركاء التنفيذ الرئيسيون؟

سلامة المرضى شأن يهم الجميع وهي تتطلب المشاركة النشطة للعديد من الشركاء الرئيسيين بدءاً من المرضى وأسرهم إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمهنية. وتشمل هذه الجهات الشريكة:

- **الحكومات.** وزارات الصحة ووكالاتها التنفيذية على المستويين الوطني ودون الوطني، والمؤسسات التشريعية، والوزارات المعنية الأخرى، والهيئات التنظيمية.
- **مرافق الرعاية الصحية وخدماتها.** جميع مرافق الرعاية الصحية بدءاً من مراكز الصحة الأولية إلى المستشفيات التعليمية الكبيرة، بغض النظر عن الملكية ونطاق الخدمات.
- **أصحاب المصلحة.** المنظمات غير الحكومية، والمرضى ومنظمات المرضى، والهيئات المهنية والرابطات والجمعيات العلمية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني.
- **أمانة منظمة الصحة العالمية.** منظمة الصحة العالمية على جميع المستويات - المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية والمقرات.

ما هو إطار العمل؟

توفر خطة العمل العالمية إطاراً للعمل من خلال سبعة أهداف استراتيجية وتوضّح بشكل أكبر من خلال 35 استراتيجية، خمس منها في إطار كل هدف من الأهداف الاستراتيجية، لإنشاء مصفوفة سباعيّة خماسيّة.

وجرى تفعيل كل استراتيجية من الاستراتيجيات بشكل أكبر لتصبح إجراءات مقترحة لأربع مجموعات أو فئات رئيسية من الشركاء، وهي: الحكومات، ومرافق الرعاية الصحية وخدماتها، وأصحاب المصلحة، وأمانة المنظمة.

وفيما يلي الأهداف الاستراتيجية السبعة لخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030:

- **الهدف الاستراتيجي 1:** جعل العمل على وقف الأذى الذي يمكن تجنب حدوثه للمرضى وفقاً نهائياً حالة ذهنية واعية وقاعدة للمشاركة في تخطيط وتقديم الرعاية الصحية في كل مكان
- **الهدف الاستراتيجي 2:** إقامة نُظم صحية عالية الموثوقية ومنظمات صحية تكفل حماية يومية للمرضى من الأذى
- **الهدف الاستراتيجي 3:** ضمان سلامة كل عملية سريرية
- **الهدف الاستراتيجي 4:** إشراك وتمكين المرضى وأسرهم من تقديم المساعدة والدعم لتحقيق رعاية صحية أكثر مأمونيّة
- **الهدف الاستراتيجي 5:** تحفيز جميع العاملين الصحيين وتنقيفهم وإكسابهم المهارات اللازمة وحمايتهم للمساهمة في تصميم وتنفيذ أنظمة للرعاية المأمونة
- **الهدف الاستراتيجي 6:** ضمان التدفق المستمر للمعلومات والمعرفة تجاه التخفيف من المخاطر وخفض مستويات الأذى الذي يمكن تجنبه وتحسين سلامة الرعاية

كيف سيقاس التقدم العام؟

سوف تقيّم آلية للرصد والإبلاغ التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية. وتستخدم في ذلك مجموعة مؤلفة من 10 مؤشرات أساسية وغايات عالمية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية. وستضطلع أمانة المنظمة بجمع البيانات اللازمة بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء وتحلّل بعد ذلك التقدم المحرز. وستساعد قائمة إضافية من المؤشرات المتقدمة البلدان على تصميم قياساتها المحددة السياق بشأن سلامة المرضى. وسوف تُبلّغ جمعية الصحة العالمية كل عامين بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030.

كيف ستدعم الخطة أهداف التنمية المستدامة؟

نظراً للطابع المتعدد التخصصات لمسألة سلامة المرضى، فإن خطة العمل العالمية لا تساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة 3 (الصحة الجيدة والرفاه) فحسب، بل تقيم أيضاً روابط مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك الهدف 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولين).

- الهدف الاستراتيجي 7: تطوير وتعزيز التآزر والتضامن والشراكات على مستوى متعدد القطاعات ومتعدد الجنسيات لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية

كيف سيسير التنفيذ على المستويين الوطني ودون الوطني؟

تأخذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 في الاعتبار أن البلدان تمر بمراحل مختلفة في عملية بناء القدرات والإمكانات التي تتيح لها الحد من الأذى الذي يمكن تجنب حدوثه للمرضى في إطار الرعاية الصحية وتعزيز نظمها الصحية الوطنية لتحقيق هذا الهدف. وتتباين أيضاً سياقات الرعاية الصحية الخاصة بها تبايناً كبيراً. ويطلب إلى الدول الأعضاء تقييم وتحليل أوضاعها الراهنة لتحديد المجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها.

والمعالم الرئيسية للتنفيذ على المستويين الوطني ودون الوطني هي على النحو التالي:

- إجراء تقييم لمشهد المخاطر الرئيسية التي تهدد السلامة والحوادث التي تحول دون تحسين سلامة المرضى؛
- ضمان التزام قوي من جانب القيادات السياسية والتنظيمية؛
- إنشاء آلية مستدامة لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بسلامة المرضى (في سياق الخطط الصحية الوطنية القائمة وسياسات السلامة والجودة)؛
- تواءم السياق والأولويات الوطنية واتساقها بشكل جيد مع سياق الرعاية الصحية في البلد؛
- موافقة جميع الشركاء على نموذج للتغيير لأغراض التنفيذ.

آمنة عامة عن خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2030-2021

الرؤية

عالم لا يتعرض فيه
أي أحد للأذى في إطار الرعاية
الصحية، ويحصل فيه كل مريض
على رعاية آمنة ومحترمة في أي وقت ومكان



الرسالة

دفع السياسات والإجراءات قُدماً، استناداً إلى الأسس العلمية وتجربة
المرضى وتصميم النظم والشركات، لإزالة كل مصادر الخطر والأذى التي
يمكن تجنب حدوثها للمرضى والعاملين الصحيين.

الغاية

الحد بأقصى قدر ممكن من الأذى الناتج عن الرعاية الصحية غير المأمونة والذي
يمكن تجنبه، على الصعيد العالمي



1- مقدمة

المبادرة الرائدة، من خلال معالمها السنوية، القوة المحركة لتنفيذ خطة العمل العالمية بنجاح.

وستوفر خطة العمل العالمية، المبينة في هذه الوثيقة، توجيهاً استراتيجياً للإجراءات الملموسة التي ستتخذها البلدان والمنظمات الشريكة ومرافق الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 6-72. ونتيجة لذلك، سوف تعزز النظم الصحية على مستوى العالم مجالات التشخيص والعلاج والتداوي والرعاية، في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة إلى تطبيق مبدأ: "عدم الإضرار أولاً"، وهو الحكمة الشهيرة التي قالها الطبيب اليوناني أبقرط (460-375 قبل الميلاد).

1-1 معلومات أساسية

قد تتطوي كل نقطة في عملية الرعاية على خطر متأصل. وتختلف طبيعة هذا الخطر وحجمه اختلافاً كبيراً، استناداً إلى سياق توفير الرعاية الصحية ومدى توافرها، والبيئة التحتية، والموارد المتاحة داخل البلدان وفيما بينها. ويتمثل التحدي الذي تواجهه جميع النظم الصحية وجميع المنظمات التي تقدم الرعاية الصحية في الحفاظ على وعي عالٍ للكشف عن المخاطر المتصلة بالسلامة، فضلاً عن التصدي لجميع مصادر الأذى المحتمل.

وسلامة المرضى هي إطار للأنشطة المنظمة التي تولد ثقافات وعمليات وإجراءات وسلوكيات وتكنولوجيات وبيئات في مجال الرعاية الصحية التي تعمل على التقليل من المخاطر بشكل مستمر ومستدام، والحد من حدوث أذى يمكن تجنبه، وتجعل وقوع الخطأ أقل احتمالاً وتحد من تأثيره لدى حدوثه.

وتتطوي ممارسة سلامة المرضى على إجراءات منسقة لمنع إلحاق الأذى بالمرضى بسبب عمليات الرعاية الصحية نفسها.

وتمثل سلامة المرضى أولوية استراتيجية للرعاية الصحية الحديثة، وهي عنصر أساسية في الجهود التي تبذلها البلدان في إطار العمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

على مدى السنوات العشر القادمة، ستعمل منظمة الصحة العالمية (المنظمة) وشركاؤها العالميون ودولها الأعضاء دون كلل على مساعدة جميع سكان العالم في الحصول على الخدمات الصحية.

وتمثل التغطية الصحية الشاملة هدفاً طموحاً يتاح في إطاره لجميع الأفراد والمجتمعات الحصول على خدمات صحية مأمونة وجيدة دون أن تواجههم صعوبات مالية. وهذا هو الهدف الذي يتعين بلوغه إذا ما أريد للعالم أن يظل على المسار الصحيح المفضي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايات "المليارات الثلاثة" المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، فلن تتحقق خطة التنمية المستدامة دون ضمان سلامة الخدمات الصحية. وفي غياب هذا الضمان، لا يمكن جني الفائدة المرجوة من زيادة التغطية جنياً كاملاً، وقد تنخفض ثقة الناس في الخدمات الصحية، وتقل رغبتهم في التماس الرعاية الصحية - حتى حينما يكونون في أمس الحاجة إليها.

ولهذا السبب اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون في أيار/مايو 2019 القرار ج ص ع ٧٢-٦ المتعلق بـ "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى" لإعطاء الأولوية لسلامة المرضى كخطوة أساسية في بناء جميع نظم الرعاية الصحية وتصميمها وتشغيلها وتقييم أدائها. وشكل اعتماد هذا القرار معلماً بارزاً في الجهود العالمية الرامية إلى اتخاذ إجراءات متضافرة بشأن سلامة المرضى والحد من عبء الضرر الذي يلحق بالمرضى بسبب الرعاية الصحية غير المأمونة.

وطلب القرار إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن يضع خطة عمل عالمية بشأن سلامة المرضى بالتشاور مع الدول الأعضاء ومجموعة واسعة من الشركاء والمنظمات الأخرى. ومن أجل الاستجابة للقرار ج ص ع ٧٢-6 والمضي قدماً من مرحلة الالتزام العالمي إلى العمل الملموس، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة رائدة في شباط/فبراير 2020 بعنوان "عقد سلامة المرضى للفترة 2020-2030". وتحدد هذه الخطوة الهامة مساهمة المنظمة في الحركة العالمية لسلامة المرضى. وسوف تشكل هذه

مثل الحادث، والحادث الضائر، والحادث الخطير غير المرغوب فيه، والحادث الذي لا يستحيل وقوعه، والحادث الوشيك، والحادث الأدنى وقوعاً.

وجاء تحول النموذج في التفكير بشأن السلامة في مجال الرعاية الصحية حينما جرى إدراك أنها لا تختلف تماماً عن غيرها من الصناعات العالية المخاطر، وأنه حينما تسوء الأمور، فنادراً ما يكون ذلك بسبب خطأ ارتكبه فرد واحد. وعوضاً عن ذلك، يرجع السبب الحقيقي لحادث في الطيران أو حادث ضائر في مجال الرعاية الصحية إلى خطأ بشري متأصل في مزيج معقد من الإجراءات والتفاعلات، والعمليات، والعلاقات الجماعية، والاتصالات، والسلوك البشري، والتكنولوجيا والثقافة التنظيمية، والقواعد والسياسات، فضلاً عن طبيعة بيئة العمل. وتسنى، في ظل هذا الإدراك، التوصل إلى فهم أعمق مفاده أن سوء تصميم النظم وتشغيلها قد يثير خطأ بشرياً أو يزيد من سوء تأثيره لدى حدوثه. (1)

ومن منظور هذا التفكير النظمي في مخاطر الرعاية الصحية، أصبح مصطلح "الخطأ الطبي" تسمية خاطئة إلى حد ما، لأن الخطأ لا يمثل في حد ذاته المشكلة الرئيسية. والواقع أن الأدنى الذي يلحق بالمرضى لا يمكن تصحيحه فقط من خلال حث العاملين الصحيين على توخي المزيد من الحذر. وقد بدأ استخدام مصطلح "سلامة المرضى"، وهو مفهوم أكثر شمولاً، لوصف المخاطر المتصلة بالسلامة في الرعاية الصحية والتدابير الرامية إلى التصدي لهذه المخاطر والأذى الذي يلحق بالمرضى في بداية القرن الحادي والعشرين. (2) وجرى الإقرار بحجم مشكلة الأدنى غير المقصود في تقديم الرعاية الصحية، والأسباب الشائعة التي تسمح بحدوث أنواع مماثلة من الأحداث الضائرة في جميع البلدان في شتى أنحاء العالم، وضرورة النظر إلى الخطأ البشري على أنه أمر ينبغي تخفيفه ومنعه عوض استبعاده تماماً، وأوجه الشبه القوية مع تجربة الصناعات الأخرى العالية المخاطر، مما يتيح فرصاً لنقل التعلم. ويركز أحد النهج الناشئة البديلة في مجال سلامة المرضى (سلامة المرضى ثانياً) على جعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية بشكل استباقي من خلال التركيز على الظروف التي ينجح فيها الناس في ظلها عوض التعرض للإخفاق. وينظر هذا المنظور إلى سلامة المرضى من حيث النتائج المقصودة والمقبولة على أعلى مستوى ممكن.

1-1-2 العبء العالمي للرعاية غير المأمونة

اجتذب حجم مشكلة الرعاية غير المأمونة قدراً أعظم من الاهتمام العام مع صدور التقرير التاريخي المعنون "الخطأ طبيعة إنسانية": بناء نظام صحي أكثر مأمونية عن معهد الطب في الولايات المتحدة في عام 1999. (3) واستتب مع معهد الطب معدل الوفيات من وقوع الأحداث الضائرة في مستشفيات الولايات المتحدة من دراستين سابقتين، وقدر أن ما لا يقل عن 44 000 شخص، وربما يصل هذا العدد إلى 98 000 شخص، يموتون في المستشفيات

وتستند مسألة سلامة المرضى، باعتبارها موضوعاً من مواضيع المنح الدراسية والبحوث، إلى مفاهيم وأساليب العديد من التخصصات، بما في ذلك البحوث المتعلقة بالخدمات الصحية، وعلم النفس التطبيقي، وعلم السلوك، وهندسة بيئة العمل، وعلوم الاتصالات، ونظرية الحوادث، والبحوث المتعلقة بالنظم.

1-1-1 نشأة التفكير في مسألة سلامة المرضى

في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة والتي كانت فيها العديد من البلدان بصدد وضع نظمها المتعلقة بالرعاية الصحية، اقتضت فكرة السلامة على مواجهة المخاطر التقليدية، مثل الحرائق، وتعطل المعدات، وسقوط المرضى، ومخاطر العدوى. وكان هناك أيضاً اعتقاد بأن العاملين الصحيين، مثل الموظفين المدربين تدريباً جيداً (أي الأطباء والممرضين)، سيتصرفون دائماً بحذر وضمير ويسعون إلى تجنب ما ينظر إليه على أنه "مضاعفات" حتمية للرعاية أو التقليل إلى أدنى حد منها. وفي ذلك الوقت، كان نزيف ما بعد الجراحة والضائقة الجينية أثناء الولادة والتهابات الجروح - وهي لا تزال كذلك إلى اليوم - تمثل أضراراً أو مضاعفات ثابتة مرتبطة بالرعاية. وهناك الكثير غيرها.

وبالمثل، يشهد مجال الرعاية الصحية منذ فترة طويلة أحداثاً تعتبر مضاعفات غير متوقعة - وكمثال على ذلك نقل الدم من فصيلة الدم الخطأ، وإعطاء جرعة عالية للغاية من الدواء لأحد الأطفال، وإجراء عملية جراحية في الجانب الخطأ من الجسم، والكثير من غير ذلك، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المرضى.

وطيلة معظم فترات القرن العشرين، تصدرت هذه الأحداث عناوين الصحف من حين لآخر، وتسببت في حدوث قلق عام لحظي، وكانت مصدر انشغال لمحامي التقاضي الطبي، ولكنها لم تسترع اهتماماً كبيراً بين الأطباء وقادة الرعاية الصحية. فما هو يا ترى سبب ذلك؟ والجواب أنه كان ينظر إلى هذه الأحداث، في الأساس، على أنها ضريبة حتمية لمزاولة الأعمال في بيئة مضغوطة وسريعة الحركة في إطار الرعاية الصحية الحديثة التي تنفذ الأرواح وتعالج بنجاح العديد من الأمراض الأخرى. وكانت الحجة في ذلك أن الأخطاء قد تحدث. وكان ينظر إليها بشكل أساسي أيضاً على أنها أحداث محلية يجري التعامل معها على أفضل وجه من خلال التحقيقات الداخلية.

وشرعت الدراسات التي أجريت في تسعينات القرن الماضي في النظر إلى سلامة الرعاية من منظور مختلف. وأظهرت أن تواتر النتائج الضائرة بين مرضى المستشفيات كانت كبيرة ولم يعترف إلا بالقليل منها حتى الآن. وأدخلت مصطلح "الخطأ الطبي" لوصف هذه الظاهرة وأصبح معتمداً على نطاق واسع لدى صانعي السياسات والباحثين والأطباء السريريين ومجموعات المرضى ووسائل الإعلام. ودخلت أيضاً مصطلحات أخرى حيز الاستخدام الشائع لوصف إخفاقات السلامة في الرعاية الصحية،

وتقدر البيانات المتاحة التكاليف المباشرة للأذى، مثل الاختبارات الإضافية، والعلاجات، والرعاية الصحية، في مؤسسات الرعاية الأولية والإسعافية بنحو 2,5٪ من مجموع الإنفاق الصحي، على الرغم من أن ذلك قد يقلل من حجم الرقم الحقيقي. (12) وكثيراً ما يؤدي الأذى الذي يحدث في الرعاية الأولية والإسعافية إلى دخول المستشفيات. وفي كل عام، قد يمثل ذلك أكثر من 6٪ من أيام الإقامة في المستشفيات وأكثر من 7 ملايين حالة دخول إلى المستشفيات في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويضاف ذلك إلى نسبة 15٪ من نشاط الرعاية الحرجة الناجم عن الأذى الذي يحدث في المستشفيات وحدها. (6)

ووفقاً للتقديرات الأخيرة، قد تصل قيمة التكلفة الاجتماعية للأذى الذي يلحق بالمرضى إلى مبلغ يتراوح ما بين تريليون (واحد) و2 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنوياً. ويشير نهج رأس المال البشري إلى أن إزالة الأذى قد يعزز النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من 0,7٪ سنوياً. (13)

1-1-3 تطور الحركة العالمية لسلامة المرضى

في أيار/مايو 2002، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والخمسون القرار ج ص ع 55-18. وقد حث هذا القرار الدول الأعضاء على إيلاء أقصى اهتمام ممكن لمشكلة سلامة المرضى وإقامة وتعزيز النظم التي تستند إلى البيانات والالتزام لتحسين سلامة المرضى ونوعية الرعاية الصحية.

التحالف العالمي لسلامة المرضى (2004-2014)

في وقت لاحق، أيدت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون في أيار/مايو 2004 إنشاء تحالف دولي لتيسير وضع السياسات وتحديد الممارسات في مجال سلامة المرضى في جميع الدول الأعضاء باعتباره قوة رئيسية لإدخال تحسينات على المستوى العالمي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أطلق التحالف العالمي لسلامة المرضى كشراكة عمل بين منظمة الصحة العالمية وخبراء خارجيين وقادة في مجال الرعاية الصحية وهيئات مهنية. وشكل إنشاء التحالف العالمي لسلامة المرضى خطوة هامة للغاية في الكفاح من أجل تحسين سلامة الرعاية الصحية في جميع الدول الأعضاء. ومن خلال العمل بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، تولى التحالف العالمي لسلامة المرضى هذه المهمة وشرع بسرعة في تنفيذ برنامج عمل كان مدعوماً بتخصيص مبلغ كبير من تمويل مؤسسي مقدم من حكومة المملكة المتحدة. (14)

وقد هيا التحالف العالمي لسلامة المرضى بيئة فريدة ظهرت فيها مبادرات جديدة رئيسية لم يكن الشركاء الأفراد قادرين على

كل عام نتيجة للأخطاء الطبية. وفي عام 2002، نشر كبير المستشارين الطبيين في حكومة المملكة المتحدة تقريراً بعنوان منظمة ذات ذاكرة. (4) وتناول كلا التقريرين موضوع السلامة والأذى في الرعاية الصحية، وحددا أوجه التشابه مع الصناعات الأخرى العالية المخاطر، وقدموا أيضاً التقديرات الأولى لعبء الأذى الذي يلحق بالمرضى لما أصبح يشكل أولوية صحية جديدة ومجالاً جديداً من مجالات بحوث الخدمات الصحية.

وفي السنوات الأخيرة، انصب التركيز أيضاً على الخسائر الاقتصادية ومشاكل الوصول الناجمة عن الرعاية غير المأمونة التي قد تصبح عوائق رئيسية تحول دون تحقيق الرعاية الصحية الشاملة. (5) وقد أظهرت الدراسات البحثية أن مريضاً واحداً من كل عشرة مرضى في المتوسط يتعرض لحدث ضائر أثناء تلقيه الرعاية في المستشفيات في البلدان المرتفعة الدخل. (6) وتشير التقديرات الخاصة بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى تعرض ما يصل إلى مريض واحد من بين كل أربعة مرضى للأذى، مع وقوع 134 مليون حدثاً ضائراً سنوياً بسبب الرعاية غير المأمونة في المستشفيات، مما يساهم في وقوع حوالي 2,6 مليون حالة وفاة. (7) وبوجه عام، تُعزى 60٪ من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب حالات قابلة للرعاية الصحية، إلى الرعاية غير المأمونة والرديئة من حيث الجودة. (8) ويربط الناس في الغالب سلامة المرضى بالرعاية القائمة على المستشفيات؛ ومع ذلك، تمثل الرعاية غير المأمونة مشكلة على مستوى النظام. وينشأ نصف عبء المرض العالمي الناجم عن الأذى الذي يلحق بالمرضى من الرعاية الأولية والإسعافية. (9)

ويمكن فهم التكلفة الاقتصادية للرعاية غير المأمونة بطريقتين اثنتين، هما التكلفة المباشرة الناجمة عن إهدار الموارد والتكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان الإنتاجية في أوساط السكان. وفي البلدان المرتفعة الدخل، يمكن أن يُعزى ما يصل إلى 15٪ من نفقات المستشفيات إلى الهدر الناجم عن الإخفاقات في مجال السلامة. وعلى سبيل المثال، دفعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا 1,63 مليار جنيه إسترليني كتكاليف للتقاضي بسبب الهفوات في مجال السلامة في الفترة 2017-2018. (10)

وتشكل الممارسات والأخطاء الدوائية غير المأمونة - مثل الجرعات أو الحقن غير الصحيحة، والتعليمات غير الواضحة، واستخدام الاختصارات والوصفات الطبية غير الملائمة أو غير المقروءة - سبباً رئيسياً للأذى الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وعلى الصعيد العالمي، قدرت التكلفة المرتبطة بأخطاء الأدوية بمبلغ 42 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة سنوياً، (11) دون احتساب الأجور والإنتاجية المفقودة أو تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة. ويمثل هذا المبلغ ما يقرب من 1٪ من الإنفاق العالمي على الصحة. وتؤدي الرعاية غير المأمونة والرديئة إلى خسارة تتراوح ما بين 1,4 و1,6 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في الإنتاجية كل عام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. (2)

- برنامج المرضى الملتمزمون بسلامة المرضى بقيادة أفراد عانوا من الأذى من الرعاية الصحية أو أفراد أسرهم.
- مبادرة تصنيف سلامة المرضى لضمان الاتساق في المعايير والمصطلحات المستخدمة في العمل المتعلق بسلامة المرضى، فضلاً عن إطار التصنيف - /التصنيف الدولي لسلامة المرضى.
- مبادرة بحوث سلامة المرضى لتحديد أولويات البحوث المتعلقة بسلامة المرضى في البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل، فضلاً عن وضع المشاريع وبناء القدرات.
- برنامج الحلول المتعلقة بسلامة المرضى لتحديد التدخلات ووضعها وتعزيزها في جميع أنحاء العالم لتحسين سلامة المرضى.
- الإبلاغ والتعلم مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات للمساعدة في تصميم النظم القائمة والجديدة للإبلاغ عن الحوادث وإعدادها.
- دليل مناهج سلامة المرضى (طبعان - الأولى لكليات الطب وطبعة أخرى متعددة التخصصات) للمساعدة في تعليم سلامة المرضى في الجامعات والمدارس والمؤسسات المهنية في مجالات طب الأسنان والطب والقبالة والتمريض والصيدلة.
- الشراكات الأفريقية من أجل سلامة المرضى لبناء شراكات مستدامة بين المستشفيات بشأن سلامة المرضى.

مبادرات منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى (2015-2020)

في عام 2016، أتاحت مشاورات عالمية أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن تحديد الأولويات في مجال سلامة المرضى على مستوى العالم منبراً للاعتراف بأن حجم الأذى الذي يمكن تجنبه في نظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم مرتفع بشكل غير مقبول مع وجود علامات قليلة تدل على حدوث تحسن. (17) وبلاستناد إلى العمل الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بالاشتراك مع التحالف العالمي لسلامة المرضى، أدت الجهود المبذولة إلى تعزيز المرحلة الثانية من برنامج منظمة الصحة العالمية العالمي لسلامة المرضى ومواصلة تطويرها.

ووضعت منظمة الصحة العالمية مبادرات عالمية رئيسية بشأن سلامة المرضى، واشتركت مع عدد كبير من أصحاب المصلحة والشركاء، وأجرت مشاورات واسعة النطاق وعلى مستوى رفيع، بما في ذلك ما يلي:

- التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: **أبوية بلا أذى**، والذي أطلق كمبادرة متعددة السنوات بهدف الحد من الأذى الشديد الذي يمكن

تنفيذها أو راغبين في الاضطلاع بها بمفردهم. وأصبح أداة لتبادل المعارف والموارد الرامية إلى تحسين سلامة الرعاية الصحية. وكان من المتوخى أن يجري تكييف حلول مفيدة لسلامة المرضى، وهي الحلول التي يحددها ويُقيّمها نظام أو نظامان صحيان أو مجموعات من المستشفيات الرئيسية، من أجل التنفيذ على الصعيدين العالمي أو المتعدد الأقطار. وكان من المتوقع أيضاً أن يؤدي التنسيق والتيسير الإضافيين للخبرات والتعلم على الصعيد الدولي إلى الحد من ازدواجية الجهود والتقليل إلى أدنى حد من إهدار الموارد القيمة.

ويتمثل أحد الأهداف الأساسية للتحالف العالمي لسلامة المرضى في تيسير وضع السياسات والممارسات المتعلقة بسلامة المرضى في الدول الأعضاء. ومن المقرر إنجاز ذلك من خلال الاضطلاع بعدد من المهام الأساسية وغيرها من المبادرات القصيرة الأجل على النحو الذي حدده التحالف في أحد برامج العمل السنوية.

التحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى

أدخل برنامج العمل الأول الذي أعده التحالف العالمي لسلامة المرضى مفهوم التحدي العالمي بشأن سلامة المرضى. وتحدد هذه المبادرة عبء سلامة المرضى الذي يشكل خطراً كبيراً على الصحة، ثم تضع تدخلات وشراكات ميدانية مع البلدان لنشر وتنفيذ التدخلات. ويركز كل تحدٍ من التحديات على موضوع من المواضيع التي تشكل خطراً رئيسياً وكبيراً على صحة المرضى وسلامتهم.

وكان الموضوع الذي اختير لأول تحدٍ عالمي لسلامة المرضى في عام 2005 و2006 هو **الرعاية النظيفة** هي الرعاية الأكثر مأمونية (15) للحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وقد أصبح هذا الموضوع يشكل عنصراً رئيسياً في العمل المبكر الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية. وأعقب ذلك بعد بضع سنوات موضوع **الجراحة المأمونة** تتخذ الأرواح، وهو التحدي العالمي الثاني بشأن سلامة المرضى. (16) وسعى كلا التحديين العالميين إلى الحصول على التزام عالمي وتحفيز العمل الرامي إلى الحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية والمخاطر المرتبطة بالجراحة، على التوالي.

ويظل نطاق وسرعة مواجهة هذين التحديين أمراً غير مسبوق. وقد تمكنا من الحصول على التزام قوي وسريع بشأنهما من وزراء الصحة والهيئات المهنية والجهات التنظيمية وقادة النظم الصحية ومنظمات المجتمع المدني وممارسي الرعاية الصحية.

مبادرات أخرى للتحالف العالمي لسلامة المرضى

بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ التحديين العالميين المتعلقين بسلامة المرضى، أنشأ التحالف العالمي لسلامة المرضى المجموعة التالية من المبادرات البارزة في برنامج عمله الأولي، والتي استمرت خلال فترة حياة التحالف.

والتعاون، وإشراك المرضى والأسر، وتبادل المعارف، والعمل التقني بشأن بناء النظم والممارسات المتعلقة بسلامة المرضى وتعزيزها.

1-1-4 مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): مفهوم أوسع للأذى الذي يمكن تجنبه

في عام 2020، أدت حصيلة جائحة كوفيد-19 العالمية إلى تزايد الاعتراف بالمخاطر التي يتعرض لها المرضى. وسيصبح التأثير المستمر على نظم تقديم الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم أكثر وضوحاً وقابلية للقياس الكمي الكامل بمرور الوقت. ومع ذلك، فقد ظهرت آثار هامة على سلامة المرضى، مما أعطى زخماً أكبر للجهود الرامية إلى تعزيز الرعاية الأكثر مأمونية على جميع المستويات. وأدت المعرفة السريرية المتنامية لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم وبمظاهره إلى الحد من حالة عدم اليقين، ولكن المرض الجديد وعلاجاته المستجدة أسفر عن تزايد خطر حدوث الأذى الذي يمكن تجنبه. وقد تعرضت السلامة البدنية والنفسية للعاملين الصحيين للخطر الشديد، كما هو الحال بالنسبة إلى قدرات نظم تقديم الرعاية الصحية واستقرارها المالي. وقد أدت عوامل ظرفية، مثل نقص ملاك الموظفين، وإعادة توزيع الموظفين للاضطلاع بأدوار غير مألوفة، و"الحلول الوقتية"، إلى تعطيل عمليات الرعاية القائمة في معظم النظم الصحية في شتى أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، انتقلت الآثار غير المباشرة للفيروس على إمكانية الوصول إلى مجالات لا صلة بالرعاية كشكل آخر من أشكال الأذى الجسيم. ونشأت حالات التأخير عن عدم التماس المرضى للرعاية بسبب الخوف، أو عدم قدرة الأشخاص على ارتياد المرافق الصحية بسبب عمليات الإغلاق، أو عدم تلقي المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومعقدة للعناية الإسعافية أو الوقائية الروتينية بسبب العبء الثقيل الذي يتحمله النظام الصحي، أو إعطاء الأولوية للقبول بالمستشفيات للمصابين بكوفيد-19. وبالإضافة إلى ذلك، فقد عانى المرضى من أنواع جديدة من الأخطاء التشخيصية، بعضها يتعلق بالفيروس ولا يتعلق البعض الآخر منها بهذا الفيروس بالقدر نفسه. (18)

وعلى الرغم من هذه الآثار والمخاطر السلبية، فقد أتاحت جائحة كوفيد-19 بعض الفوائد القصيرة الأجل في مجالات رئيسية يمكن أن تكون محفزاً لاستراتيجيات التحسين اللاحقة. وقد وُحِدَ الالتزام والمسؤولية المشتركين أصحاب المصلحة في مجال الرعاية الصحية على نحو لم يسبق له مثيل. واعتمد العديد منهم تلقائياً سمات السلامة الرئيسية مثل الشفافية، والتواصل النشط، والتعاون، والاعتماد السريع لممارسات سلامة المرضى. وقد يحدث ذلك بصورة مؤقتة فقط وفي سياقات وبلدان مختارة، ولكنه يوضح كيف يمكن للنهج الانعزالية التقليدية والمجالات السريرية أن تتلاشى بسرعة من أجل محاربة عدو مشترك.

تجنبه فيما يتصل بالأدوية على مستوى العالم بنسبة 50٪ على مدى فترة خمس سنوات؛

- **الشبكة العالمية المعنية بسلامة المرضى**، وهي شبكة تفاعلية للغاية أنشئت بالتعاون مع الدول الأعضاء وقادة الرعاية الصحية وخبراء دوليين وهيئات مهنية؛
- **مؤتمرات القمة الوزارية العالمية بشأن سلامة المرضى**، التي شرع فيها بمبادرة من حكومتي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية منذ عام 2016، بوصفها سلسلة من مؤتمرات القمة السنوية؛
- **قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 72-6 بشأن "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى"**، الذي اعتمد في مايو/ أيار 2019، وحدد استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه بشأن سلامة المرضى؛
- **المبادرة التعاونية العالمية بشأن سلامة المرضى**، التي أطلقت بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة للتعاون مع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للحد من خطر الأذى الذي يلحق بالمرضى والذي يمكن تجنبه؛
- **اليوم العالمي لسلامة المرضى**، الذي كرس بموجب قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 72-6، والذي احتفل به لأول مرة في 17 أيلول/سبتمبر 2019؛ وخصص هذا الحدث لعام 2020 لموضوع سلامة العاملين الصحيين، وأطلق ميثاقاً تاريخياً بعنوان *سلامة العاملين الصحيين: الأولوية لسلامة المرضى*، ضمن جملة أمور أخرى تتعلق بالدعوة والمنتجات التقنية؛
- **نشر توجيهات وأدوات معيارية بشأن سلامة المرضى**، بما في ذلك السلسلة التقنية بشأن الرعاية الأولية الأكثر مأمونية، والقائمة المرجعية للولادة المأمونة، ودليل التنفيذ المصاحب لها، ونموذج الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بسلامة المرضى، ونظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها (التقرير التقني والتوجيه)، والتقارير التقنية المتعلقة بسلامة الأدوية، من بين توجيهات وأدوات أخرى نشرتها منظمة الصحة العالمية؛
- **المبادرة الأفريقية لسلامة المرضى**، وهي منتدى رفيع المستوى نُظِمَ بالاشتراك مع شركاء رئيسيين للعمل مع بلدان أفريقية لتحسين سلامة المرضى؛
- **المبادرة الرائدة لمنظمة الصحة العالمية "عقد سلامة المرضى 2020-2030"**، أطلقت لتوجيه العمل الاستراتيجي بشأن سلامة المرضى ودعمه على المستويات العالمية والإقليمي والوطني. ويتضمن العمل الأساسي للمبادرة الرائدة صياغة خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى ودعم تنفيذها على جميع المستويات من خلال الدعوة، والتوجيه والأدوات المعيارية، والشراكات الاستراتيجية، والحملات،

ومن المؤسف إدراك أن أزمة الصحة العامة المزمنة والواسعة النطاق المتمثلة في الأذى الذي يمكن تجنبه بالنسبة للمرضى والقوى العاملة ستظل تشكل تحدياً مثلما كان عليه الحال من قبل وذلك بعد زوال جائحة كوفيد-19. وستكون السنوات الخمس القادمة فترة تتعلم فيها الحركة العالمية لسلامة المرضى من الآثار السلبية والإيجابية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وسيتاح حينها الوقت الكافي لبناء نظم رعاية صحية تكون أكثر مأمونية وتقلل إلى أدنى حد من الأذى الذي يلحق بالمرضى والعاملين الصحيين. وتستند خطة العمل العالمية هذه إلى فهم عميق لطبيعة الأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية وللطريقة التي يهدد بها سلامة المرضى في سياقات متنوعة ومعقدة في شتى أنحاء العالم. وسيساعد التفكير في سبل إضافة كوفيد-19 إلى هذا السياق في استخلاص الدروس المتعلقة بسلامة المرضى من حالات الإخفاق التي سببتها الجائحة والتحويلات الوبائية على حد سواء. وبشكل هذا كله جزءاً من الحاجة الملحة إلى "الربط" بين التغييرات الإيجابية، وتعزيز انتشار الاستراتيجيات والابتكارات المتعلقة بالسلامة، وجعل نظم الرعاية الصحية أكثر قدرة على التصدي لتأثير الأذى من أي وقت مضى.

2-1 التفويض

تستمد خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 ولايتها من قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع6-72 "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى". وقد طلب القرار إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "أن يضع خطة عمل عالمية بشأن سلامة المرضى بالتشاور مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنتمون منهم إلى القطاع الخاص". ويجب أن تقدم هذه الخطة إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين التي تتعقد في عام 2021 من خلال الدورة الثامنة والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. وتحدد فقرات منطوق القرار ج ص ع6-72 الحدود الاستراتيجية والتنفيذية لخطة العمل هذه. (19، 20)

3-1 عملية التطوير

أعدت خطة العمل العالمية هذه بصورة مشتركة من خلال عملية تشاركية ساهم فيها خبراء دوليون بارزون في مجال سلامة المرضى. ومرت المسودة بمراحل متعددة من المشاورات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية ومجموعات المرضى والمنظمات الحكومية الدولية والمكاتب العالمية والإقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية. وقد وضعت أمانة المبادرة الرائدة لسلامة المرضى في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف المخطط الأولي لخطة العمل ومسار تطويرها، بتوجيه ودعم من مبعوث

منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة المرضى، وبالتشاور مع البرامج والوحدات والإدارات التقنية ذات الصلة داخل نظام منظمة الصحة العالمية. وعقدت مشاورة عالمية لمنظمة الصحة العالمية في شباط/فبراير 2020 في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف لتجميع المسودة الأولى لخطة العمل. وقدم خبراء وممارسون بارزون في مجال سلامة المرضى من 44 بلداً توصيات قيمة ولملموسة بشأن ما ينبغي أن يكون عليه المسار المستقبلي للعمل العالمي بشأن سلامة المرضى. ووردت إسهامات رئيسية من الخبراء وأصحاب المصلحة من 140 بلداً من خلال الشبكة العالمية المعنية بسلامة المرضى والتابعة للمنظمة.

وشكلت "فرقة عمل معنية بالصياغة والاستعراض" وكلفت بولاية متابعة التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات وإعداد مسودة خطة العمل. ونوقشت أيضاً المسودة الأولى مع الدول الأعضاء من خلال اللجان الإقليمية والمشاورات. ونظمت إحاطات تقنية إضافية مع البعثات القطرية الدائمة في جنيف. وقد أتيحت مسودة خطة العمل على الإنترنت للتشاور العام على الموقع الشبكي لمنظمة الصحة العالمية لمدة شهر واحد. وتولت "فرقة العمل المعنية بالصياغة والاستعراض" استعراض التعليقات والتعليقات والإسهامات التقنية الواردة من الدول الأعضاء ومن حصيلة المشاورات العامة ومعالجتها على النحو المناسب. وقدمت مسودة أولية لخطة العمل إلى الدورة الثامنة والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2021 لاستعراضها ومناقشتها وإقرارها. وعدل المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة، قراراً للتوصية بعرض خطة العمل العالمية على جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين بغرض إقرارها.

المراجع: الفصل الأول

- 1- Mannion R, Braithwaite J. False dawns and new horizons in patient safety research and practice. Int https://dx.doi.org/10.1186/1745-6215-6-685;2017. J Health Policy Manag March 25 accessed ,2017.115.2Fijhpm%10.15171/org (2021).
- 2- Institute of Medicine. 2001. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington (DC): National Academies Press (https://www.nap.edu/read/10027, accessed 28 March 2021).
- 3- Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. Institute of Medicine. To err is human: building a safer health system. Washington (DC): National Academies Press; 2000 (https://www.nap.edu/read/9728/chapter/1, accessed 25 March 2021).
- 4- Department of Health. An organisation with a memory: report of an expert group on learning from adverse events in the NHS chaired by the Chief Medical Officer. London: The Stationery Office; 2000 (https://qi.elft.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/08/r_02-an-organisation-with-a-memory-l-donaldson.pdf, accessed 25 March 2021).

- Slawomirski L, Klazinga N. Economics of patient safety: from analysis to action. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2020 ([http://www.oecd.org/health/health-systems/Economics-of-Patient-Safety-\(October-2020\).pdf](http://www.oecd.org/health/health-systems/Economics-of-Patient-Safety-(October-2020).pdf), accessed 25 March 2021).
- التحالف العالمي لسلامة المرضى: برنامج أولي [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2004 (https://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- التحالف العالمي لسلامة المرضى. التحدي العالمي بشأن سلامة المرضى للفترة 2005-2006. الرعاية النظيفية هي الرعاية الأكثر مأمونية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2005 (https://www.who.int/patientsafety/events/05/GPSC_Launch_ENGLISH_FINAL.pdf?ua=1، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- التحالف العالمي لسلامة المرضى. التحدي العالمي الثاني لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2008 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70080/WHO_IER_PSP_2008.07_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- المشاور العالمية لمنظمة الصحة العالمية: ترتيب الأولويات بشأن سلامة المرضى على الصعيد العالمي. موجز تنفيذي [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 (https://www.who.int/patientsafety/executive-summary_florence.pdf، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- ضمان بيئة آمنة للمرضى والموظفين في مرافق الرعاية الصحية المعنية بعلاج المصابين بكوفيد-19 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- القرار ج ص ع 6-72. العمل العالمي بشأن سلامة المرضى. في: جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون، جنيف 20-24 أيار/مايو 2019. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-ar.pdf، اطلع عليه في 11 كانون الثاني/يناير 2021).
- سلامة المرضى: العمل العالمي بشأن سلامة المرضى: تقرير من المدير العام. في: جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون، جنيف 20-24 أيار/مايو 2019. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_26-ar.pdf، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- تقديم خدمات صحية عالية الجودة: ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي؛ 2018 (<https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage/publication/delivering-quality-health-services-a-global-imperative-for-universal-health-coverage>، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).
- Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The economics of patient safety: strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level. OECD Health Working Papers No. 96. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2017 (<https://doi.org/10.1787/5a9858cd-en>, accessed 25 March 2021).
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Health Care Services; Board on Global Health; Committee on Improving the Quality of Health Care Globally. Crossing the global quality chasm: improving health care worldwide. Washington (DC): National Academies Press; 2018.
- Kruk ME, Gage AD, Arsenault C, Jordan K, Leslie HH, Roder-DeWan S et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. Lancet Glob Health. 2018;6(11):e1196-e1252. doi:10.1016/S2214-109X(18)30386-3t.
- Woods D, Thomas EJ, Holl JL, Weiss KB, Brennan TA. Ambulatory care adverse events and preventable adverse events leading to a hospital admission. Qual Saf Health Care. 2007;16:127-31. doi:10.1136/qshc.2006.021147.
- NHS Litigation Authority. Annual report and accounts 2017/18. London: Her Majesty's Stationery Office; 2018 (<https://resolution.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/08/NHS-Resolution-Annual-Report-2017-2018.pdf>, accessed 25 March 2021).
- Aitken M, Gorokhovich L. Advancing the responsible use of medicines: applying levers for change. Parsippany (NJ), United States of America: IMS Institute for Healthcare Informatics; 2012 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2222541, accessed 25 March 2021).
- Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. The economics of patient safety in primary and ambulatory care: flying blind. OECD Health Working Papers No. 106. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2018 (<https://doi.org/10.1787/baf425ad-en>, accessed 25 March 2021).

-2

الرؤية والرسالة الهدف



الرؤية

عالم لا يتعرض فيه أحد للأذى في الرعاية الصحية، ويتلقى فيه كل مريض رعاية مأمونة ومحترمة في أي وقت ومكان.



الرسالة

دفع السياسات والاستراتيجيات والإجراءات قُدماً، استناداً إلى الأسس العلمية وخبرات المرضى وتصميم النظم والشراكات، من أجل الحدّ من جميع مصادر المخاطر والأذى التي يمكن تجنب حدوثها للمرضى والعاملين الصحيين.



الغاية

الحدّ بأقصى قدر ممكن من الأذى الناتج عن الرعاية الصحية غير المأمونة والذي يمكن تجنبه، على الصعيد العالمي.

3- المبادئ التوجيهية

2-3 تحقيق النتائج من خلال العمل التعاوني

ستوفر منظمة الصحة العالمية، من خلال مبادرة عقد سلامة المرضى للفترة 2020-2030 بوصفها ولاية عالمية، توجيهات سياساتية وأدوات تنفيذ للبلدان لجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية في نقطة تقديم هذه الرعاية. وستكون هناك حتماً ابتكارات معطلة ونماذج أحدث للرعاية الأكثر مأمونية والتي تتطور على المستوى المحلي. وينبغي أن تصب في نظم التعلم العالمية من أجل إعادة تصميم الهيكل السياساتي وتعزيز الخطاب العالمي المتعلق بسلامة المرضى. وعوضاً عن التدفق الأحادي الاتجاه للتدخلات، فستكون هناك حاجة إلى نظام إيكولوجي تعاوني يساهم فيه الجميع (من صانعي السياسات العالميين إلى مقدمي الرعاية في الخطوط الأمامية) ويتبادلون فيه ما لديهم ويتعلمون. ويتعين تصميم جميع التدخلات المتعلقة بسلامة المرضى وتكييفها بعناية لتلبية أولويات البلدان والمجتمعات المحلية، فضلاً عن احتياجاتها المحددة في مجال التنفيذ. وستحضر منظمة الصحة العالمية أثر الحد من الأذى في كل بلد من خلال الحوار السياساتي، والدعم الاستراتيجي، والمساعدة التقنية و/أو تقديم الخدمات. ويمكن أن يكون للعمل العالمي دور مساعد، ولكن قوة الخطة تكمن في الحرص الشديد على سلامة المرضى والالتزام بذلك على المستويات الوطني ودون الوطني والمحلي.

3-3 تحليل البيانات وتبادلها لتوليد التعلم

تنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم نظم الإبلاغ التي تجمع البيانات عن الأحداث والحوادث الضائرة من نقطة الرعاية. وفي عام 2020، أصدرت منظمة الصحة العالمية الوثيقة المعنونة *نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: التقرير التقني والتوجيه*. وهناك مصادر أخرى لهذه البيانات،

يشكل إنشاء نظام للمضي قدماً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يكون فيه المرضى أكثر مأمونية مما هم عليه اليوم، وخاصة في النقطة التي يتلقون فيها الرعاية في أي مكان في العالم، تحدياً من التحديات الكبرى. وهذا التحدي هو ما تعالجه خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030. وترسي المبادئ التوجيهية السبعة التالية مجموعة أساسية من القيم اللازمة لتوجيه وضع إطار العمل المقترح في خطة العمل العالمية وتنفيذه. ويتضمن الإطار سبعة أهداف استراتيجية و 35 استراتيجية تشكل أساس خطة العمل العالمية.

1-3 إشراك المرضى والأسر كشركاء في الرعاية المأمونة

ينبغي النظر إلى الرعاية الصحية المأمونة على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان. وبما أن الرعاية الصحية تشكل في معظم جوانبها خدمة من الخدمات، فهي تُنتج دائماً بشكل مشترك مع المستخدمين. ويتطلب تحقيق الرعاية المأمونة إبلاغ المرضى وإشراكهم ومعاملتهم كشركاء كاملين في الرعاية التي يتلقونها. وفي أجزاء كثيرة من العالم، يحدث هذا بدرجة أقل بكثير مما يلزم. ويؤدي المرضى والأسر ومقدمو الرعاية اهتماماً شديداً بصحتهم وصحة مجتمعاتهم المحلية. وتعتمد سلامة المرضى على مشاركتهم الكاملة كمستخدمين لنظام الرعاية الصحية وعلى الأشخاص الأكثر دراية بتجربة المريض بأكملها. وينبغي إشراك المرضى وأسرها في كل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، بدءاً من وضع السياسات والتخطيط، ومروراً بمراقبة الأداء، وانتهاءً بالموافقة المستنيرة تماماً واتخاذ القرارات المشتركة في مرحلة الرعاية. ولدى المرضى والأسر والمجتمعات المحلية مساهمات أساسية يقدمونها في مجال سلامة المرضى.

يشكل التعلم مجرد تدفق أحادي الاتجاه. وقد تكون الخبرة المكتسبة في إيجاد حلول مفيدة لسلامة المرضى في البيانات المحدودة الموارد ذات قيمة بالنسبة للجهات التي تدير برامج في نظم الرعاية الصحية المزودة بالموارد الكافية، بالإضافة إلى مسار "الشمال والجنوب" المفضل عادة للدعوة إلى اعتماد أفضل الممارسات.

6-3 الاستفادة من الخبرة العلمية وتجربة المرضى على حد سواء لتحسين سلامة المرضى

في الوقت الراهن، لا يقتصر تطوير خدمات مأمونة للمرضى على مهارات التخطيط، والتصميم، والاستثمار الاستراتيجي فحسب، بل يتضمن أيضاً الدعوة، والتوعية، والالتزام السياسي، والإقناع، والخاصية المحلية. وعلى نحو تقليدي، تأتي الخبرة العلمية و/أو التقنية من صانعي السياسات، وقادة النظم الصحية، ومهنيي الرعاية الصحية، والأكاديميين، والمديرين، في حين يأتي التعاطف من المواطنين، والمجتمع المدني، والمنظمات، والمدافعين عن المرضى. وتتطلب صياغة الخطط وتنفيذها خبرة علمية و/أو تقنية، ولكن يجب أن تتطوّر أيضاً على الالتزام والدافع العاطفي الإيجابي الذي يحرك الأشخاص الذين يتذكرون ما عاناه الكثير من المرضى والأسر في الماضي من خسارة وأذى جسيم بسبب الرعاية الصحية المعيبة. وإذا تسنى الجمع بين هذه العنصرين - العلم والخبرة الشخصية - دائماً في مجال التحسين، فسيكون ذلك توليفة ناجحة.

7-3 ترسيخ ثقافة السلامة لدى تصميم الرعاية الصحية وتقديمها

يشكل تطوير ثقافة للسلامة عنصراً أساسياً لأي جهود مستدامة ترمي إلى تحسين سلامة المرضى. ويمكن للتدخلات السياساتية والتشريعية أن توفر بيئة مواتية لازدهار ثقافة السلامة. ومع ذلك، يجب أن تتغلغل ثقافة السلامة وتغرس في نهاية المطاف في مواقف العاملين الصحيين والمديرين وفي معتقداتهم وقيمهم ومماراتهم وممارساتهم. يجب أن تتداخل ثقافة السلامة مع الفلسفات والثقافات التنظيمية عموماً. ويمكن للبلدان والمنظمات أن تحدد سبلها المثلى لتحقيق ثقافة السلامة، على الرغم من أن بعض العناصر لا تزال ضرورية للغاية في هذا الشأن. ومن المكونات التي لا غنى عنها لثقافة السلامة التزام القيادة، والشفافية، والانفتاح في مجال التواصل، والتعلم من الأخطاء وأفضل الممارسات، والتوازن الحكيم بين سياسة عدم اللوم والمساءلة. ولا تشكل ثقافة السلامة عنصراً أساسياً للحد من الأذى الذي يلحق بالمرضى فحسب، بل هي ضرورية أيضاً لتوفير بيئة عمل مأمونة للعاملين الصحيين. ويشمل ذلك تهيئة بيئة عمل مأمونة من الناحية النفسية، حيث يمكن للعاملين الصحيين أن يتحدثوا عن سلامة المرضى وغير ذلك من الشواغل دون خوف من العواقب السلبية.

مثل الدعاوى المتعلقة بسوء الممارسة، والتجارب التي يبلغ عنها المرضى ومقاييس النتائج، وعمليات التحقق من الرعاية السريرية، واستعراضات السجلات الطبية، والاستقصاءات، وعمليات التحقق من الأحداث الهامة، وبيانات ترصد السلامة لمنتجات الدم والأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية. ويتيح جمع البيانات من هذه المصادر المختلفة فرصة ثمينة لزيادة فهم أسباب وقوع حوادث السلامة وابتكار حلول لمنع حدوثها. ومع ذلك، تُجمع في الكثير من الأحيان كميات هائلة من البيانات ويُنفق معظم الوقت والموارد المتاحة لتخزينها. ويُصرف وقت أقل لتحليلها بطريقة تتيح استخدامها للتعلم ويمكن أن تساهم بشكل موثوق ومستمر في تحسين سلامة المرضى. وهناك أيضاً مسائل تتعلق بجودة البيانات وموثوقيتها، ويمكن معالجتها على أحسن وجه من خلال بناء ثقافة الثقة في الإبلاغ. ومن المهم دائماً استخدام هذه البيانات لتوفير معلومات عن أنماط واتجاهات أنواع الأذى التي تحدث، ولكن يجب أن ينصب التركيز بشدة على قدرتها على جعل الرعاية التي تقدم في المستقبل أكثر مأمونية.

4-3 ترجمة البيانات إلى تحسينات قابلة للتطبيق والقياس

تتمثل إحدى مواطن الضعف في العديد من جوانب الرعاية الصحية، بما في ذلك سلامة المرضى، في بطء ترجمة البيانات التي تدل على الفعالية إلى ممارسة روتينية، وهو ما يطلق عليه أحياناً اسم الفجوة بين "المعرفة والممارسة". وهناك أيضاً وفرة في خبرة مقدمي الخدمات والمرضى والمعرفة التكتيكية المتاحة لتصميم الحلول واختبارها لتحسين سلامة المرضى. وخلال عملية تحديد إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين سلامة المرضى، سيكون من المهم فهم عملية التغيير فهماً كاملاً واستخدام مجموعة المعارف المحددة بشأن علوم التحسين لتحقيق النتيجة المرجوة. ويعني ذلك أيضاً العمل بشكل وثيق مع القادة، والمديرين، والموظفين المهنيين، وممثلي المرضى في المرافق الصحية والخدمات السريرية. ومن المهم أيضاً تعهد المراكز المتميزة والتعلم منها، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات التي أثبتت جدواها.

5-3 وضع السياسات والإجراءات على أساس طبيعة إطار الرعاية

انصب معظم الاهتمام والبحوث في مجال سلامة المرضى على تجربة نظم الرعاية الصحية العالية الموارد ومجموعات المستشفيات الكبيرة. ومع ذلك، يجري إنجاز قدر كبير من العمل الجيد في البيانات المنخفضة الموارد. وأولاً، فقد أصبح من الواضح أنه يجب تكييف السياسات والحلول المتعلقة بسلامة المرضى مع السياق المحلي. وهي لا تترجم ببساطة من سياق إلى آخر، لا سيما حينما تكون الثقافة، والتقاليد، وتصميم نظام الرعاية الصحية، ومستوى البنية التحتية على درجة كبيرة من الاختلاف. وثانياً، لا

4- شركاء في العمل

يمثل العمل الشامل بشأن سلامة المرضى في جميع البلدان في شتى أنحاء العالم مسعى معقداً ويتطلب جهوداً جماعية يبذلها العديد من أصحاب المصلحة بدءاً من صانعي السياسات إلى العاملين الصحيين. ولتحقيق غاية خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 وأهدافها الاستراتيجية، فمن المهم أن تتطور الشراكات على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي. ومن شأن التعاون بهذه الطريقة أن يضيف قيمة خاصة إلى المساعي المبذولة من أجل سلامة المرضى ويعزز جهود فرادى المنظمات.

ومن خلال العمل معاً لتحقيق رؤية خطة العمل وتحسين سلامة الرعاية للجميع، يمكن للشركاء أيضاً تسريع التقدم لتحقيق أهداف كل واحد منهم. وعلى النحو المبين أدناه، حُدِّدت أربع فئات عريضة من الشركاء لدعم تنفيذ خطة العمل العالمية. وتتوخى خطة العمل هذه أيضاً أن يكون المرضى والأسر والمجتمعات المحلية شركاء رئيسيين على جميع مستويات العمل.

4-2 مرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- ▶ مرافق الرعاية الثالثة والثانوية ومنظمات الرعاية الصحية
- ▶ مرافق الرعاية الصحية الأولية ومقدمو الخدمات
- ▶ مرافق الرعاية الطويلة الأجل ومقدمو الخدمات
- ▶ مقدمو خدمات الرعاية الملطّفة
- ▶ مرافق الصحة النفسية ومقدمو الخدمات
- ▶ مقدمو خدمات الرعاية قبل دخول المستشفى
- ▶ العيادات المتخصصة ومقدمو خدمات التشخيص
- ▶ المرافق المعنية بتعاطي مواد الإدمان ومرافق رعاية الخرف
- ▶ مقدمو خدمات التوعية الصحية
- ▶ مقدمو خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والمنزلية
- ▶ أفرقة إدارة الخدمات الصحية دون الوطنية والمحلية.

4-1 الحكومات

- ▶ الحكومات الوطنية ودون الوطنية.
- ▶ البرلمان والهيئات التشريعية دون الوطنية.
- ▶ وزارات الصحة.
- ▶ الوكالات المتخصصة الوطنية ودون الوطنية والهيئات المساعدة، مثل المعاهد أو المراكز أو الوكالات الوطنية المعنية بسلامة المرضى والجودة، بما في ذلك وكالات التخطيط، وهيئات تنفيذ المخططات، ومؤسسات الصحة العامة، ووكالات الصحة المهنية.
- ▶ وزارات أخرى معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالصحة، بما في ذلك وزارات التعليم، والمالية، والعمل والشؤون الاجتماعية، وشؤون المستهلك، والعدل، والإدارة الإقليمية.
- ▶ الهيئات التنظيمية الوطنية ودون الوطنية، بما في ذلك وكالات وضع المعايير، ووكالات الترخيص والاعتماد، وهيئات التحقيق في سلامة الرعاية الصحية.

3-4 أصحاب المصلحة

- ▶ المنظمات الحكومية الدولية، على سبيل المثال، المفوضية الأوروبية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
- ▶ المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية
- ▶ المنظمات الإنمائية الدولية
- ▶ الهيئات المعنية بوضع المعايير ووكالات الاعتماد الدولية والمستقلة
- ▶ الهيئات المهنية الدولية والوطنية والرابطات والجمعيات العلمية
- ▶ الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز التعليمية وغيرها من مؤسسات التدريب وبناء القدرات الدولية والوطنية
- ▶ المؤسسات البحثية
- ▶ الاتحادات الدولية والوطنية ورابطات مقدمي الخدمات الصحية
- ▶ النقابات العمالية والمنظمات العمالية الأخرى التي تمثل العاملين الصحيين
- ▶ منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية، بما في ذلك منظمات المرضى
- ▶ المجموعات والمنظمات المجتمعية
- ▶ وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي
- ▶ الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى
- ▶ الشركاء في التنمية والجهات المانحة ووكالات التمويل
- ▶ الصناعة الصيدلانية وصناعة الأجهزة الطبية
- ▶ صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية
- ▶ كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات التجارية (الصناعة) ومنظمات مقدمي الرعاية الصحية
- ▶ مؤسسات التأمين الصحي والصيانة الصحية

4-4 أمانة منظمة الصحة العالمية

- ▶ منظمة الصحة العالمية على جميع المستويات - المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية والمقر
- ▶ المكاتب الموزعة جغرافياً التابعة لمنظمة الصحة العالمية

5- إطار العمل

جعل العمل على وقف الأذى الذي يمكن تجنب حدوثه للمرضى وفقاً نهائياً حالة ذهنية واعية وقاعدة للمشاركة في تخطيط وتقديم الرعاية الصحية في كل مكان

يتضمن الإطار سبعة أهداف استراتيجية يمكن تحقيقها من خلال 35 استراتيجية محددة.

إقامة نظم صحية عالية الموثوقية ومنظمات صحية تكفل حماية يومية للمرضى من الأذى

ضمان سلامة كل عملية سريرية

إشراك وتمكين المرضى وأسرهم من تقديم المساعدة والدعم لتحقيق رعاية صحية أكثر مأمونية

تحفيز العاملين الصحيين وتنقيفهم وإكسابهم المهارات اللازمة وحمايتهم للمساهمة في تصميم وتنفيذ نظم للرعاية المأمونة

ضمان التدفق المستمر للمعلومات والمعرفة تجاه التخفيف من المخاطر وخفض مستويات الأذى الذي يمكن تجنبه وتحسين سلامة الرعاية

تطوير وتعزيز التآزر والتضامن والشراكات على مستوى متعدد القطاعات ومتعدد الجنسيات لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية

إطار العمل – المصفوفة 5 × 7

5-1 اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى	4-1 معايير السلامة والتنظيم والاعتماد المتعلقين بها	3-1 تدابير تشريعية وقائية	2-1 تعبئة الموارد وتخصيصها	1-1 سياسة عامة واستراتيجية لسلامة المرضى وإطار للتنفيذ	سياسات ترمي إلى إزالة الأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية	 1
5-2 إدراج سلامة المرضى في حالات الطوارئ وفي الظروف الشديدة القسوة	4-2 العوامل البشرية/بيئة العمل من أجل قدرة النظم الصحية على الصمود	3-2 القدرة القيادية على أداء الوظائف السريية والإدارية	2-2 الحكمة الرشيدة لنظام الرعاية الصحية	1-2 ثقافة الانفتاح والشفافية و"عدم اللوم"	نظم عالية الموثوقية	 2
5-3 سلامة المرضى في سياق الرعاية الأولية ومراحل الرعاية الانتقالية	4-3 سلامة الأجهزة الطبية والأدوية والدم واللقاحات	3-3 الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات	2-3 التحدي العالمي الثالث بشأن سلامة المرضى: أدوية بلا أذى	1-3 سلامة الإجراءات السريية المعرضة للخطر	سلامة العمليات السريية	 3
5-4 إبلاغ المرضى وتثقيفهم	4-4 الإفصاح عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى للضحايا	3-4 المدافعون عن المرضى والمناصرين لهم	2-4 التعلم من تجربة المرضى لتحسين السلامة	1-4 المشاركة في وضع السياسات والبرامج مع المرضى	إشراك المرضى والأسر	 4
5-5 بيئة عمل آمنة للعاملين الصحيين	4-5 ربط سلامة المرضى بنظم تقييم العاملين الصحيين	3-5 الكفاءات في مجال سلامة المرضى بوصفها متطلبات تنظيمية	2-5 المراكز المتميزة المختصة بالتثقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى	1-5 سلامة المرضى في التعليم والتدريب المهنيين	تثقيف العاملين الصحيين ومهاراتهم وسلامتهم	 5
5-6 التكنولوجيا الرقمية المتعلقة بسلامة المرضى	4-6 برامج بحثية بشأن سلامة المرضى	3-6 نظام ترصد سلامة المرضى	2-6 ترصد سلامة المرضى ونظام المعلومات المتعلق بها	1-6 نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها	المعلومات والبحوث وإدارة المخاطر	 6
5-7 التوافق مع البرامج والمبادرات التقنية	4-7 مبادرات شاملة لعدة قطاعات وفيما بين المناطق الجغرافية بشأن سلامة المرضى	3-7 الشبكات والتعاون في مجال سلامة المرضى	2-7 الفهم الموحد والالتزام المشترك	1-7 إشراك أصحاب المصلحة	التآزر والشراكة والتضامن	 7

الأهداف الإستراتيجية واستراتيجيات التنفيذ

يعمل عدد قليل من المنظمات الكبيرة القائمة في أي قطاع من القطاعات القائمة في شتى أنحاء العالم بفعالية دون الاستناد إلى مجموعة واضحة وبسيطة من الأهداف التي تحكم الأنشطة الاستراتيجية والتنفيذية ويفهمها ويمتلكها جميع الموظفين. ويساعد وضع هذه الأهداف على مستوى عال في نظام من النظم على أن ينصب تركيز جميع السياسات والأنشطة القائمة لنظام الرعاية الصحية على تحقيق هدف مشترك. وقد تتيح هذه الأهداف، حينما يكون عددها قليلاً وصياغتها مناسبة، استعراض التقدم المحرز على المستوى الاستراتيجي وكذلك على مستوى الفريق السريري. وينبغي ألا تشكل هذه الأهداف عبئاً إضافياً أو تحل محل مقاييس الأداء القائمة داخل البلدان أو في نظمها ومرافقها. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تعمل على توحيد عمل القيادة، ومساعي المديرين، والرعاية التي يقدمها الأطباء والممرضون وغيرهم من العاملين الصحيين. وينبغي لها أن تتيح اختبار كل شيء بدءاً من العمل السريري اليومي وصولاً إلى القرارات الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بتصميم نظم الرعاية الصحية. وينبغي لها أن توفر أيضاً إطاراً بسيطاً للمساءلة العامة.

وهذا هو الغرض من الأهداف الاستراتيجية السبعة التي يوفرها هذا الإطار لخطة العمل العالمية. وهي واسعة بما يكفي لفهم عدد لا يحصى من المهام المطلوبة للحد من المخاطر وتحسين سلامة رعاية المرضى في كل جزء من العالم. وهي مفصلة بحيث يكون من المسموح به تماماً أن توضع في نطاقها برامج عمل تتناسب

مع الاحتياجات والأولويات المحلية التي يشكلها السياق المحدد. وهي تفعل ذلك على وجه التحديد لأنها ترمي إلى التمكين وليس إلى وضع القيود. وعليه، ينطوي الهدف 2، على سبيل المثال، على معنى يتعلق بمعرفة ما إذا كان تطوير "الموثوقية العالية" يجري في مستشفى تعليمي أوروبي مجهز تجهيزاً جيداً أو في مركز صحي ريفي في بلد منخفض الموارد في غرب أفريقيا. ويرمي كل واحد منها إلى بذل أقصى ما يمكن بذله في سياقه التشغيلي وفي إطار توافر الموارد.

وفي المقابل، ينطبق الهدف 3، الذي يتناول المجال الهام المتعلق بتصميم وتشغيل عمليات وممارسات الرعاية المأمونة، بنفس القدر على خدمة رعاية الأمومة التي تستخدم التكنولوجيا العالية في مدينة كندية كبيرة وعلى خدمة تقدم في منطقة نائية من سيراليون وتحاول الحد من الوفيات النفاسية الناجمة عن نزيف ما بعد الولادة.

ويقصد أيضاً أن تكون الأهداف الاستراتيجية سهلة الفهم والتصور، وأن يجري إيصالها بسهولة على نحو مشجع وتحفيزي، فضلاً عن تكون قليلة العدد حتى لا يثبت أنها شاقة للغاية وتضيف حملاً زائداً لدى التنفيذ. ويتجلى إطار العمل بمزيد من الوضوح من خلال 35 استراتيجية، تتدرج كل خمس منها في إطار كل هدف من الأهداف الاستراتيجية، لوضع مصفوفة مضاعفة سباعية خماسية (7 × 5). وتُرجمت كل استراتيجية بعد ذلك إلى إجراءات مقترحة لأربع مجموعات من الشركاء وهي: الحكومات، ومرافق الرعاية الصحية، وأصحاب المصلحة، وأمانة منظمة الصحة العالمية.

الهدف الاستراتيجي 1-

السياسات الرامية إلى إزالة الضرر الذي يمكن تجنبه

جعل العمل على وقف الأذى الذي يمكن تجنب حدوثه للمرضى وقفاً نهائياً حالة ذهنية واعية وقاعدة للمشاركة في تخطيط وتقديم الرعاية الصحية في كل مكان



البلدان، وبين الأقاليم، والمناطق المحلية، وفي جميع مجالات الرعاية، وحتى ضمن فترات الرعاية الفردية. وتشجع الأخطاء التي تنبئها النظم المعيبة وتستمر في إلحاق الأذى بالناس. ولا تقتصر هذه المشاكل على نظام صحي بعينه، غير أنها أثبتت على مر السنين أنها مستعصية على الحل في معظمها.

ومع ذلك، فقد أصبح الحد من المستويات غير المقبولة حالياً للأذى الذي يمكن تجنبه في متناول اليد تماماً. وبالتأكيد، فإن من غير المرجح أن يحدث أي أذى ضمن أي نطاق زمني متوقع. ولكن لا يوجد هناك من يذهب إلى إمكانية التسامح مع أي أذى يلحق بمتلقي الرعاية الصحية. ولن يكون خفض الأرقام وصولاً إلى الصفر ممكناً في الوقت الراهن. ومع ذلك، سيحدث مفهوم عدم إلحاق الأذى مطلقاً والإطار المرجعي للتخطيط للرعاية الصحية وتقديمها تحولاً جذرياً عن الوضع الراهن الذي يتسم بمستويات عالية من الأذى الذي يمكن تجنبه. وسيؤدي الاستناد إلى هذه الفلسفة في كل فكرة من الأفكار التي تنطوي عليها كل خطوة، وكل خطوة من خطوات تصميم كل برنامج، وكل قرار في أي لقاء سريري، وكل فرصة للتعليم حينما يحدث خطأ ما، إلى استحداث نموذج جديد في مجال الرعاية الصحية. وسيكون لهذا الإجراء أثر تحويلي حقيقي، وسيكون بإمكانه، بغض النظر عن كونه مثالياً وغير ملموس تماماً، إحداث تخفيضات هائلة في أعداد الوفيات والإعاقات والإصابات البدنية والنفسية الناجمة عن الرعاية غير المأمونة.

فيم هذا الهدف الأول، الذي يتناول فكرة عدم الأذى، بعناية فائقة. ويحتدم الجدل في دوائر الصحة العالمية بشأن الحكمة من تحديد هدف مركزي أو شامل. ومن ناحية، يذهب البعض إلى أنه لن تتاح للبرنامج، دون وجود رؤية مقنعة، فرصة الاعتماد من بين العديد من البرامج الصحية العالمية التي تحدد توجهاتها على أساس تحقيق نتيجة مرغوبة للغاية وبالغة الفائدة للبشرية. ومن ناحية أخرى، يزعم آخرون أن تحديد هدف لا سبيل إلى تحقيقه هو إجراء محبط ومثبط للعزيمة ولن يجتذب الناس للوقوف في صفه. وتضع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 رؤية وفلسفة تقوم على عدم إلحاق الأذى إطلاقاً عوض تحديد غاية ملموسة.

وتتبع الحاجة إلى هدف شامل وجريء للتصدي لوجود الأذى ذاته من الحاجة إلى قبول المساءلة الكاملة لحل المشاكل التي تكمن وراء السلامة والمخاطر والأذى في الرعاية الصحية بشكل نهائي. ولم يكن الخطاب المتعلق بسلامة المرضى وبطبيعتها المتعددة الأوجه على مدى السنوات العشرين الماضية كافياً لتفعيل تركيز القادة والأطباء والمديرين والتزامهم بإدخال التحسينات الرئيسية في مجال سلامة المرضى. ولم تكن لديهم الأرقام الصادمة التي ترسم الصورة الصارخة. وحتى يومنا هذا، توفر نظم ومرافق الرعاية الصحية مستويات مختلفة للغاية من الأداء في مجال سلامة المرضى. ويمكن رؤية ذلك في جميع أنحاء العالم، وداخل

الهدف الاستراتيجي 1

جعل العمل على وقف الأذى الذي يمكن تجنب حدوثه للمرضى وفقاً نهائياً حالة ذهنية واعية وقاعدة للمشاركة في تخطيط وتقديم الرعاية الصحية في كل مكان

الاستراتيجية 1-1:

وضع سياسة واستراتيجية وإطار مؤسسي شامل لسلامة المرضى وخطة لتنفيذ النظام الصحي في البلد وجميع مكوناته كأولوية رئيسية في العمل من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

إجراءات للحكومات

- الاعتراف بسلامة المرضى باعتبارها أولوية صحية في سياسات قطاع الصحة وبرامجه، مما يجعلها مكوناً أساسياً لتعزيز نظم الرعاية الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
- وضع برنامج وطني بشأن سلامة المرضى تدعمه سياسات واستراتيجية وإطار مؤسسي وخطة تنفيذ بشأن سلامة المرضى في سياق الرعاية الصحية داخل البلد، بما في ذلك الأولويات والغايات الصحية العامة؛ والمستويات والمصادر الحالية للمخاطر وأوجه الأذى التي يمكن تجنبها؛ والموارد المتاحة؛ ومقدمو الخدمات من القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- العمل بالتعاون مع البلدان الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات المرضى، والهيئات المهنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقطاع الصناعة، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة على تعزيز سلامة المرضى ومنحها الأولوية وإدماجها في جميع السياسات والاستراتيجيات الصحية.
- تحديد ملامح السياسة والاستراتيجية الصحية الوطنية القائمة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية، والقوة العاملة الصحية، من أجل إيجاد أقصى قدر من فرص التآزر مع إطار سياسة سلامة المرضى.
- إدماج التنفيذ مع البرامج التقنية ذات الأهمية البالغة في مجال السلامة، مثل السلامة الجراحية، وسلامة الأدوية، وسلامة الدم، والأمان من الإشعاعي، وسلامة التحصين، وسلامة الأجهزة الطبية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، ومقاومة مضادات الميكروبات، مع وضع برنامج وطني لسلامة المرضى.
- تكييف التوجيهات التقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى واستراتيجيات وأدوات التنفيذ مع السياق الوطني وبناء القدرات في مجال سلامة المرضى.
- وضع ميثاق وطني بشأن سلامة المرضى يتضمن المعايير المؤسسية وحقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية ومسؤولياتهم.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إعلان التزام عام واضح بأن المنظمة تعمل على توجيه الثقافة والممارسات نحو عدم إلحاق أي أذى يمكن تجنبه.
- مواءمة وتنفيذ العمليات والممارسات على مستوى المرافق مع المبادئ التوجيهية والبروتوكولات وإجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بسلامة المرضى.
- استعراض التقدم المحرز في أداء سلامة المرضى في اجتماعات اللجان الإدارية الرئيسية للمنظمة وجميع الاجتماعات الرئيسية الأخرى لمجلس الإدارة.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الدعوة إلى أن تكون سلامة المرضى أولوية استراتيجية للدول الأعضاء ومنظمات الرعاية الصحية.
- التعاون مع المنظمات المهنية ومنظمات المرضى لوضع وتنفيذ الأهداف والغايات والقيم المتعلقة بسلامة المرضى.
- المشاركة في البرامج المعنية بسلامة المرضى ودعمها وتيسيرها على المستويات المحلي والوطني والعالمية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تقديم الدعم في مجال الدعوة والتوجيه على مستوى عالٍ على المستويات العالمي والإقليمي والوطني لوضع رؤية لإزالة الأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية.
- تحديد سلامة المرضى كأولوية استراتيجية رئيسية في عمل منظمة الصحة العالمية على صعيد التغطية الصحية الشاملة، وفي الاستراتيجيات والتدخلات العالمية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
- وضع ونشر التوجيهات والأدوات لصياغة السياسات والاستراتيجيات والإطار وخطط التنفيذ الوطنية في مجال سلامة المرضى.
- تجميع ونشر أفضل الممارسات بشأن وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بسلامة المرضى وتنفيذها.

إجراءات للحكومات

- تخصيص الموارد البشرية الكافية، والتمويل المستدام لتنفيذ خطة وطنية بشأن سلامة المرضى تكون مدمجة ضمن الهيكل المالي للنظام الصحي من خلال آليات مثل الميزانية المحددة، والتأمين الصحي وآليات أخرى.
- وضع ميزانية سنوية وخطة للموارد البشرية لوضع خطة عمل وطنية لسلامة المرضى.
- اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الاكتظاظ في المستشفيات من خلال التخطيط الأمثل للموارد، وحراسة أبواب الرعاية الأولية، والتخطيط العلمي وتصميم العمليات، وغير ذلك من التدخلات القائمة على البيانات.
- ضمان التمويل الكافي لتوفير موظفين في مجال السلامة على أساس الاحتياجات ووضع تخطيط فعال للموارد البشرية لضمان توفير إمدادات كافية من العاملين الصحيين لتلبية احتياجات المرضى والسكان.
- استكشاف ما إذا كان يمكن تعديل نظام تمويل الرعاية الصحية في البلد لمكافأة المنظمات الصحية التي تحقق أداءً جيداً في مجال سلامة المرضى.

الاستراتيجية 2-1:

تعبئة وتخصيص موارد كافية لتنفيذ سلامة المرضى في جميع مستويات نظام الرعاية الصحية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- دمج الأنشطة المتعلقة بتنفيذ سلامة المرضى في الخطة التشغيلية الشاملة للمنظمة، بما في ذلك الميزانية السنوية وخطة الموارد البشرية.
- تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذ سلامة المرضى على مستوى المنظمة.
- توفير ملاك وظيفي كاف مع مزيج مناسب من المهارات؛ ووضع نظم معلومات تستند إلى بيانات موثوق بها في الوقت الحقيقي، ومقاييس متفق عليها، ووضع مقاييس، وأفضل الممارسات للاسترشاد بها في التخطيط القائم على الأدلة.
- ضمان التوظيف الأمثل والهيكل الأساسية والتخطيط وتدقيق العمليات للحد من الاكتظاظ في مرافق الرعاية الصحية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الدعوة إلى توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لمعالجة أخطر المشاكل المتعلقة بسلامة المرضى.
- إشراك القطاع الخاص لمساعدته على تحديد دوره في تحسين سلامة المرضى.
- الترويج لحلول مفيدة في مجال سلامة المرضى لحشد دعم الجمهور.
- الدعوة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة الاكتظاظ في مرافق الرعاية الصحية على المستويات المحلي والوطني والعالمي.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- مناصرة الدول الأعضاء والشركاء من أجل إنشاء آليات مالية مستدامة وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ سلامة المرضى، ودعم تعبئة الموارد.
- إنشاء هياكل تنظيمية تضم أفرقة متخصصة وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية على صعيد منظمة الصحة العالمية للأنشطة المتعلقة بسلامة المرضى.
- تعبئة وتخصيص وتوفير التوجيهات بشأن تقييم وتحصيل الموارد الكافية للحملات والمبادرات والبرامج والمشاورات المتعلقة بسلامة المرضى، والتعاون القطري والدعم التقني.
- تقديم التوجيهات والتوصيات بشأن السياسات والأدوات الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في مرافق الرعاية الصحية.

إجراءات للحكومات

- استعراض ووضع التشريعات التي تحكم النظام الصحي القطري لتيسير صياغة السياسات والممارسات والمعايير السلوكية المتعلقة بسلامة المرضى وتنفيذها.
- وضع تشريعات لحماية العاملين الصحيين من أعمال الانتقام أو الإجراءات العقابية في حالة الإبلاغ عن حدث ضائر؛ وإدخال خطط ترخيص إلزامية لمقدمي الرعاية الصحية تتضمن الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى؛ والاعتراف بسلامة المرضى كحق من حقوق الإنسان التي تتضمن الحصول على الأدوية المأمونة والأجهزة الطبية ومنتجات الدم والخدمات الصحية الأساسية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التشريعات الوطنية القائمة لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية المرضى والعاملين الصحيين من الأذى الذي يمكن تجنبه وتحسين سلامة المرضى بشكل منهجي.
- تحديد المتطلبات التنظيمية والقانونية المنطبقة على مرافق الرعاية الصحية وضمان الامتثال الكامل لها، بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص وتجديدها في الوقت المناسب.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- التنسيق بين المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات المرضى والمجتمعات المحلية والهيئات الأخرى التي تهتم بسلامة المرضى لتحديد نطاق التشريعات الجديدة، ومن ثم دعوة المشرعين والحكومة الوطنية لسن هذه التدابير.
- المشاركة مع المنظمات التي يقودها المرضى لإذكاء الوعي العام بأثر الملاك الوظيفي الكافي على المرضى والأسر والمجتمعات المحلية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- مناصرة الدول الأعضاء وتقديم الدعم التقني لها لوضع وتعديل التشريعات الرامية إلى تحسين سلامة المرضى وسلامة العاملين الصحيين.
- تجميع ونشر أفضل الممارسات في التشريعات لحماية المرضى والعاملين الصحيين من الأذى الذي يمكن تجنبه.

إجراءات للحكومات

- تحديد ودمج معايير السلامة الدنيا في المتطلبات التنظيمية لمرافق الرعاية الصحية.
- إدراج أو تعزيز سلامة المرضى كعنصر رئيسي في قواعد الاعتماد الطوعي ومعايير إرساء العقود إدراج متطلبات سلامة المرضى في تقييم أداء النظام الصحي.
- فرض متطلبات سلامة المرضى في خطط الترخيص وإعادة الترخيص لمهنيي الرعاية الصحية.

الاستراتيجية 1-3:

استخدام تشريعات انتقائية لتيسير تقديم الرعاية المأمونة للمرضى وحماية المرضى والعاملين الصحيين من الأذى الذي يمكن تجنبه.

الاستراتيجية 1-4:

مواءمة أنشطة تنظيم الرعاية الصحية وأنشطة الرقابة والاعتماد مع هدف تحسين الأداء بشأن سلامة المرضى.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تنفيذ متطلبات الترخيص والتنظيم والاعتماد المتعلقة بسلامة المرضى في جميع مجالات الخدمة.
- إبلاغ جميع الموظفين على أساس منتظم بنظم الترخيص والتنظيم والاعتماد المتعلقة بسلامة المرضى والتي وقعت عليها المنظمة.
- دمج ثقافة التحسين المستمر لسلامة المرضى باستخدام مبادئ تحسين الجودة.
- تقديم معلومات إلى الحكومة الوطنية بشأن الطرق التي يمكن من خلالها تحسين نظم الترخيص والتنظيم والاعتماد لتيسير تحقيق معايير أعلى لسلامة المرضى على نحو أفضل.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الوفاء بمتطلبات سلامة المرضى بشكل كاف في معايير وبرامج الاعتماد الدولية.
- دعوة الباحثين والهيئات البحثية إلى إنشاء قاعدة بيانات (بما في ذلك التكليف بإجراء بحوث جديدة عند الضرورة) بشأن مدى فعالية نظم الترخيص والتنظيم والاعتماد في تحسين سلامة المرضى.
- جمع الخبراء وقادة النظم الصحية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد سبل تفسير واستخدام المعلومات المتعلقة بأداء المرضى في مجال السلامة والنتائج عن عمليات الترخيص والتنظيم والاعتماد لمرافق الرعاية الصحية ومهنيي هذه الرعاية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تقديم الدعم التقني والتوجيهات المتخصصة للدول الأعضاء لبناء تدابير تعزيز سلامة المرضى في نظمها الوطنية لترخيص الرعاية الصحية وتنظيمها واعتمادها.
- وضع توجيهات معيارية بشأن المعايير الدنيا لسلامة المرضى.

إجراءات للحكومات

- المشاركة في تصميم الحملة العالمية لليوم العالمي بشأن سلامة المرضى سنوياً.
- تكييف حملات وطنية وتنظيمها وإطلاقها بما يتماشى مع موضوع اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى كل عام.
- الاحتفال باليوم العالمي بشأن سلامة المرضى سنوياً في 71 أيلول/سبتمبر من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات (إضاءة المعالم الشهيرة باللون البرتقالي، على سبيل المثال) وتنشيط الجمهور بشأن أهمية موضوع سلامة المرضى.
- إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين والشروع في اتخاذ إجراءات مستدامة بشأن موضوع اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى.
- إعادة تأكيد التزام الحكومة بسلامة المرضى وعرض إنجازاتها والتقدم الذي أحرزته نحو بلوغ المعالم الوطنية في اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى.
- اعتماد وتنفيذ الأهداف السنوية لليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والمنتجات التقنية الأخرى الخاصة بالموضوع.
- رصد وتقييم نتائج وتأثير اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى.
- الالتزام بترتيب الأولويات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الغايات المتصلة بالتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى بما يلزم من قيادة وتنسيق وهياكل استشارية متخصصة ورصد وتقييم.

الاستراتيجية 5-1:

تحقيق أقصى قدر من الوعي باليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى، كوسيلة للحفاظ على ارتفاع المكانة العامة والسياسية التي تحتلها سلامة المرضى.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- الاعتراف باليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والاحتفال به كل عام.
- تكييف وتنظيم حملات محلية تتماشى مع الحملة الوطنية وموضوع اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى كل عام.
- عرض الأعمال والإنجازات التي نفذت في مجال سلامة المرضى في نقطة الرعاية خلال العام السابق في إطار الاتصالات الخاصة باليوم العالمي بشأن سلامة المرضى.
- تنفيذ غايات اليوم العالمي السنوي بشأن سلامة المرضى.
- تنفيذ الإجراءات التي تتطلبها التحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى على مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- المساعدة في تشكيل رسائل اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والترويج لها كل عام من خلال الشبكات والشركاء.
- دعم تنفيذ غايات اليوم العالمي السنوي بشأن سلامة المرضى.
- التعاون في تنفيذ التحديات العالمية الحالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى.
- المشاركة في تصميم التحديات العالمية الجديدة بشأن سلامة المرضى.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تنظيم حملة عالمية كل عام بمناسبة اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى، بما في ذلك اختيار موضوع من المواضيع، ورسائل رئيسية، وإنتاج مواد إعلامية، فضلاً عن تجميع قصص النجاح ونشرها.
- إطلاق مجموعة من غايات اليوم العالمي السنوي المتعلقة بسلامة المرضى والمرتبطة بالموضوع السنوي للعمل المركز.
- إطلاق فعاليات في اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى وتنسيق العمل من خلال أقاليم منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
- تقييم نتائج وتأثير اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى.
- تصميم التحديات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى استناداً إلى الدروس المستفادة من التحديات السابقة.
- إعداد أدوات التنفيذ وتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لتحقيق غايات وأنشطة التحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى.
- إعداد أدوات الرصد والتقييم لتقييم التقدم المحرز والتحسينات الممكن إدخالها بشأن التحديات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى واليوم العالمي بشأن سلامة المرضى.

Pan American Health Organization. Strategy and plan of action to improve quality of care in health service delivery 2020–2025. 2019. 71st Session of the Regional Committee of WHO for the Americas. Washington (DC): Pan American Health Organization (<https://iris.paho.org/handle/10665.2/51621>, accessed 16 July 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2008. مذكره لصانعي السياسات الصحية الوطنية: عملية سياسية جيدة بشأن سلامة الدم وتوافره [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/docs/default-source/searo/bt/aide-memoiregoodpolicyprocessen.pdf?sfvrsn=3f0032f4_2، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2018. دليل السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجودة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf?ua=1>، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. 2014. دليل لوضع سياسة وخطة استراتيجية وطنية لسلامة المرضى [بالإنكليزية]. برازافيل: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا (https://www.who.int/patientsafety/policies/2014_guidenationalpolicy.pdf?ua=1، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. 2015. مجموعة أدوات سلامة المريض [بالإنكليزية]. القاهرة: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/195709/EMROPUB_2015_EN_1856.pdf?sequence=1&isAllowed=y، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا. 2008. توجيهات بشأن وضع استراتيجيات الجودة والسلامة باتباع نهج النظام الصحي [بالإنكليزية]. كوبنهاغن: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/96473/E91317.pdf، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا. 2015. الاستراتيجية الإقليمية لسلامة المرضى في إقليم منظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا (2016–2025) [بالإنكليزية]. نيودلهي: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/205839>، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ. 2020. مسودة إطار عمل لإجراء جراحة مأمونة وميسورة التكلفة في إقليم غرب المحيط الهادئ (2021–2030). 7/WPR/RC71 [بالإنكليزية]. مانيتا: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ (<https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/regional-committee/session-71/rc71-7-safe-and-affordable-surgery-annex.pdf>، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

Canadian Patient Safety Institute. 2019. Strengthening commitment for improvement together: a policy framework for patient safety. Edmonton, Alberta; CPSI/ICSP (<https://www.patientsafetyinstitute.ca/en/toolsResources/PolicyFrameworkforPatientSafetyCanada/Documents/PolicyFramework%20Document%20ENG%20FINAL.pdf>, accessed 16 July 2021).

Government of India. 2018. National patient safety implementation framework (2018–2025) India. New Delhi: Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/national%20patient%20safety%20implimentation_for%20web.pdf, accessed 16 July 2021).

Government of South Africa. 2016. National policy for patient safety incident reporting and learning in the public health sector of South Africa. Government of South Africa, Department of Health (<http://www.kznhealth.gov.za/family/National-Policy-Patient-Safety-Incident-Reporting-Learning-South-Africa-July-2016.pdf>, accessed 16 July 2021).

Government of Spain. 2015. Patient safety strategy for the National Health System 2015–2020. Government of Spain, Ministry of Health, Social Services and Equality (<https://www.seguridaddelpaciente.es/recursos/documentos/2015/Spanish-Patient-Safety-Strategy-2015-2020.pdf>, accessed 16 July 2021).

Health Service Executive, Ireland. 2019. Patient safety strategy 2019–2024: building a better health service. HSE, Ireland (<https://www.hse.ie/eng/about/qavd/patient-safety/hse-patient-safety-strategy-2019-2024.pdf>, accessed 16 July 2021).

Institute for Healthcare Improvement. 2020. Safer together: a national action plan to advance patient safety. Boston (MA), United States of America: Institute for Healthcare Improvement (<http://www.ihl.org/Engage/Initiatives/National-Steering-Committee-Patient-Safety/Pages/National-Action-Plan-to-Advance-Patient-Safety.aspx>, accessed 16 July 2021).

International Organization for Standardization. 2015. Quality management principles. Geneva: ISO for Standardization (<https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100080.pdf>, accessed 16 July 2021).

National Health Service. 2019. The NHS patient safety strategy: safer culture, safer systems, safer patients. London: NHS England and NHS Improvement (https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/08/190708_Patient_Safety_Strategy_for_website_v4.pdf, accessed 16 July 2021).

الهدف الاستراتيجي 2-

نظم عالية الموثوقية

إقامة نُظم صحية عالية
الموثوقية ومنظمات صحية
تكفل حماية يومية للمرضى
من الأذى

وأطلق على هاتين المدرستين الفكريتين مدرسة سلامة المرضى الأولى ومدرسة سلامة المرضى الثانية. وفي الواقع، فكلاهما مطلوب إذا أُريد إحداث تغيير تحويلي في مجال سلامة المرضى. وينبغي أن يكون بالإمكان التعلم من الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى التي يمكن تجنبها ومن أسبابها بقدر ما يمكن التعلم من حالات التميز المبلغ عنها من قبل الأقران أو من الانحراف الإيجابي. ويستفيد الانضباط العلمي في مجال سلامة المرضى والأدوات والنهج التي وضعت للتعلم من الحوادث من أنطولوجيا مصحوبة بمفاهيم موحدة وتعريف متفق عليها ومصطلحات مفضلة لإجراء دراسة موثوق بها. وتتسم النظم الاجتماعية والتقنية بالتعقيد. وقد تكون العوامل المساهمة التي يُعتقد أن لها دوراً في أصل حادثة من الحوادث التي تقع في أحد سياقات الرعاية هي نفس العوامل التي تسمح للتمييز بالانتشار في سياق آخر. ويجب على المسؤولين عن تحسين السلامة واستدامتها في المنظمات الاستثمار في آليات التعلم التي تستجيب للإشارات الواردة من الممارسات الجيدة والسيئة. ومع ذلك، فمن الإنصاف القول بأنه قد جري إيلاء اهتمام استراتيجي أقل لطرق بناء منظمات عالية الموثوقية في مجال الرعاية الصحية. ولهذا السبب من المهم أن يكون ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية السبعة في خطة العمل العالمية هذه.

يتمثل أحد عوامل النجاح الرئيسية في الصناعات العالية المخاطر، باستثناء الرعاية الصحية، في التركيز على منع الحوادث والأذى والأخطاء التي تنجر عنها عواقب وخيمة. ويتمثل المفهوم الذي انبثق عن هذا النهج في القدرة على التكيف، وهي قدرة المنظمة وإمكاناتها في الحفاظ باستمرار على حالة مأمونة من التشغيل والانتعاش بسرعة واستعادة هذه الحالة المأمونة لدى حدوث خطأ ما. ولدى هذه المنظمات القدرة على توقع المشاكل، واستخدام البيانات لرصد العمليات وظروف العمل، والاستجابة للإشارات تحسباً لما يعترضها من تحديات، والتعلم باستمرار من النجاحات والإخفاقات.

ويشكل تعزيز القدرة على التكيف إلى تطبيقه عملياً في مفهوم المنظمات عالية الموثوقية. ويتميز العمل الأكاديمي في هذا المجال بسعة نطاقه، وقد سعى إلى تحديد المنظمات التي لا يخلو أداؤها في مجال السلامة من أي عيب، ولا سيما في المجالات المعقدة التي قد يؤدي الفشل فيها إلى نتائج كارثية. وقد أجريت معظم الدراسات في الصناعات وحالات التشغيل خارج نطاق الرعاية الصحية. ومع ذلك، فقد أثار هذا المفهوم نقاشاً في إطار حركة سلامة المرضى لمعرفة ما إذا كان يجري إيلاء الكثير من الثقة في التعلم من الفشل وعدم التركيز بما فيه الكفاية على فهم ما يهيئ سبل النجاح.

خصائص المنظمات عالية الموثوقية

اجتذب عمل كارل ويك وكاثلين ساتكليف قدراً كبيراً من الاهتمام من مجتمع سلامة المرضى. واستناداً إلى دراسة أجريت على العديد من المنظمات والحالات، استخلص هذان الباحثان خمس خصائص تميز المنظمة عالية الموثوقية، وهي على النحو التالي:

• **الانشغال بالفشل.** تبرز المنظمات عالية الموثوقية لأنها تتعامل مع كل هفوة صغيرة كعرض محتمل لضعف هام يعترى النظام الهام ويمكن أن تكون له عواقب كبيرة على المسار الصحيح.

• **العزوف عن التبسيط.** تتمثل إحدى السمات الأخرى التي تتميز بها المنظمات عالية الموثوقية في عدم الرغبة في التصدي لتعقيدات العمليات والتكنولوجيات وبيئات تقديم الخدمات من خلال اعتماد نظرة مبسطة لها من أجل مواصلة التركيز على عدد قليل من المهام الرئيسية. ويمكن تبسيط بعض جوانب فهم إحدى العمليات المعقدة، ولكن القبول على نحو أكثر دقة وشمولاً للعناصر المعقدة وكيفية ترابطها يشكل عنصراً ضرورياً للبقاء في مأمن.

• **الحساسية للعمليات.** في المنظمات عالية الموثوقية، هناك تركيز شديد على إيلاء الاهتمام لكيفية تأثير التغييرات الصغيرة على بقية النظام. وينطوي ذلك على منظور موسع بحيث لا يكون للتركيز على أمر ما له تداعيات سلبية على أمر آخر. وتتعلق الحساسية للعمليات بالعمل نفسه، وبرؤية ما نضطلع به في الواقع، بغض النظر عن النوايا والتصاميم والخطط.

• **الالتزام بالمرونة.** لا تكمن السمة المميزة للمنظمة عالية الموثوقية في خلو أنشطتها من الأخطاء، ولكنها تتلخص في أن الأخطاء لا تؤدي إلى تعطيلها. والمرونة هي مزيج من الإبقاء على الأخطاء صغيرة وإتاحة مواصلة العمل الآمن.

• **مراعاة الخبرة.** تتمثل السمة الثابتة الخامسة والأخيرة للمنظمات عالية الموثوقية في سياساتها الرامية إلى ترسيخ التنوع حتى يفهم المرء كل جانب من الجوانب المعقدة للنظام. وستنتقل السلطة إلى الشخص الذي يتمتع بأكثر قدر من الخبرة، بغض النظر عن المركز الذي يشغله داخل المنظمة. وتكون التسلسلات الهرمية سيئة عموماً للحفاظ على نظم مأمونة، مثلما هو عليه الحال لدى مراعاة السلطة عوضاً عن الخبرة.

ثقافة السلامة والقيادة

حينما تُذكر الثقافة فيما يتعلق بسلامة المرضى، ستتجه أفكار معظم الناس إلى مفهوم ثقافة عدم اللوم الذي كثيراً ما ينصب النقاش حوله. وبما أن معظم الأخطاء هي إخفاقات تتسم بالصدق

وتتجم عن نظم سيئة التصميم، فإن إلقاء اللوم على الفرد ومعاقبته تصرف غير منصف وخاطئ. وستكون الثقافة التي تقوم على اللوم والانتقام في نهاية المطاف ثقافة غير مأمونة العواقب لأنها تجعل الأفراد يخشون الاعتراف بأخطائهم ويسعون إلى إخفائها عوضاً عن ذلك. وإذا هيمنت ثقافة اللوم والخوف في منظمة صحية، فمن شبه المستحيل أن يكون هناك برنامج ذو مغزى بشأن سلامة المرضى.

ولم تكن فكرة اتخاذ موقف عدم اللوم رداً على الأحداث الخطيرة التي يمكن تجنبها والتي تؤدي المرضى منطقيّة للجمهور ووسائل الإعلام، على الرغم من نجاحها كسياسة في قطاعات أخرى، مثل قطاع الطيران. ويُعزى ذلك إلى أنها ترفض، فيما يبدو، أي شكل من أشكال مساءلة الأفراد. وقد بذلت محاولات لمعالجة الجانب المتعلق بالمصطلحات في هذا الصدد باعتماد مصطلح "ثقافة عادلة". وتعترف الثقافة العادلة بتعقيد الحالات والأحداث وتقر بأنه على الرغم من أن معظم الإخفاقات في مجال سلامة المرضى تتجم عن ضعف النظم، فهناك عدد قليل من الحالات التي ينبغي فيها مساءلة الفرد. ومن الأمثلة على ذلك الحالات التي يحدث فيها سلوك مستهتر أو سوء تصرف متعمد.

وينص أحد التعاريف غير الرسمية للثقافة على أنها تمثل: "الطريقة التي تؤدي بها الأشياء هنا". ويضاف إليه في بعض الأحيان ما يلي: "... حينما لا يكون هناك رقيب". وبالتالي، فسوف تتطوي ثقافة سلامة المرضى الحقيقية على عادات حسنة أخرى مثل استخدام البيانات، والانفتاح، والعمل الجماعي، والشفافية، والرغبة في التعلم والتغيير، والتركيز على المريض بشكل كامل. ولتعزيز القيادة وثقافة سلامة المرضى، سيكون من المطلوب إتاحة شفافية حقيقية إزاء كل من مقدمي الخدمات والمرضى على كل مستوى من مستويات النظام - وتكرس الشفافية إزاء تبادل المعلومات، وتكرس أيضاً من أجل الحد من أثر النهج الهرمي.

ويتطلب تطوير ثقافة قوية موجهة نحو سلامة المرضى ودعمها قيادة قوية على جميع المستويات - في وزارات الصحة، ومرافق الرعاية الصحية، وفي كل فريق سريري. وهناك حاجة لجيل جديد من القادة في مجال سلامة المرضى ممن يمتلكون المهارة والحماس اللازمين لتهيئة الظروف والثقافات التنظيمية والجماعية، وتوفير رعاية أكثر مأمونية، وضمان امتثال جميع النظم والإجراءات لأعلى المعايير، وتوجيه الموظفين وتحفيزهم.

العوامل البشرية أو هندسة بيئة العمل

العوامل البشرية أو هندسة بيئة العمل هي العنصر الرئيسي لإنشاء نظم ومنظمات رعاية صحية عالية الموثوقية وقادرة على التكيف. ويتمثل أحد أكبر التناقضات القائمة بين الرعاية الصحية وغيرها من الصناعات العالية المخاطر في التركيز الذي توليه هذه الأخيرة للعوامل البشرية في معرفة كيفية تطور مشاكل السلامة وسبل تطبيق هذه المعرفة من أجل بناء دفاعات النظام لجعله أكثر قدرة على التكيف في وجه الحوادث والأحداث الضائرة.

نهج العوامل البشرية إلى التخصصات ذات الصلة المطلوبة والتي تدمج المعارف والنتائج من أجل التوصل إلى حل.

- **نهج النظم** الذي ينظر في مستويات متعددة: المستوى الجزئي للمريض؛ والمستوى الكلي للمؤسسة؛ والمستوى المتوسط، وهو التفاعل بين الأفراد والمنظمات والنظم الاجتماعية والتقنية. ولا يأخذ نهج العوامل البشرية في الاعتبار الأشخاص المدرجين في النظام فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً البيئة، والوسط المحيط، والسياق المادي، فضلاً عن الإجراءات، والمشغولات الحرفية، وفحوصات السلامة، والعمل الجماعي، والمخاطر، والثقافة والهيكل التنظيميين، واللوائح والسياسات الوطنية. ويلزم النظر في جميع هذه العوامل وإدماجها من أجل وضع نظام قادر على التكيف وبإمكانه تعزيز السلامة.

- **التعلم المستمر والصلق**، تحسين نظم العمل بشكل متكرر من خلال الرصد والإبلاغ والتقييم والتدريب وصل الممارسات وإعادة التصميم.

القيادة التحويلية

تتسم الإجراءات المطلوبة في خطة العمل العالمية بطابعها التحويلي. ويجب أن يقود التغيير التحويلي قادة رفيعو المستوى. وتتضمن المجالات الرئيسية لهذه القيادة التي ستحدد فعالية الأهداف الاستراتيجية ما يلي:

- **التبليغ المنتظم والمتسق** لرؤية تقديم الخدمات المأمونة التي تركز على المريض والخالية من الأذى، باعتبارها الهدف الرئيسي لجميع أشكال الرعاية الصحية؛
- **تحويل الرؤية والمبادئ التوجيهية والأهداف الاستراتيجية** والاستراتيجيات المبينة هنا إلى العملة المتداولة لإدارة أعمال سلامة المرضى في جميع أنحاء العالم؛
- **تحديد وإبراز المسائل المتعلقة بتصميم وتنظيم وتقديم الخدمات** التي سيكون لها أكبر الأثر على سلامة الخدمات ومرونتها؛
- **إيجاد إحساس بالانتماء إلى "فريق" مع القادة السريريين** (تجنب "نحن وهم")، فضلاً عن الإنصات إلى مخاوفهم وأفكارهم والتصرف بناءً عليها.

وينبغي ألا تقتصر خطط التأهب والاستجابة للطوارئ على توضيح الأدوار والمسؤوليات أثناء إحدى حالات الطوارئ لضمان استجابة منسقة، بل ينبغي أن تتضمن أيضاً توقعات أساسية للسلع والخدمات اللازمة للاستجابة التي يتعين تنفيذها، وضمان سلامة المرضى، وتأمين سلامة العاملين الصحيين.

ويستخدم وصف "العوامل البشرية" في الوقت الراهن بالتبادل مع المصطلح الأقدم عهداً "هندسة بيئة العمل" وغالباً ما يُستخدمان معاً - "العوامل البشرية/هندسة بيئة العمل". ويستخدم في هذا التقرير مصطلح "العوامل البشرية".

ويُعنى هذا التخصص الهام في مجال العلم والممارسة بفهم التفاعلات فيما بين البشر وعناصر أخرى من النظام. ويطبق نهج العوامل البشرية النظرية والمبادئ والبيانات والأساليب المستمدة من المجالات ذات الصلة لتصميم سبل رفاهية الإنسان والأداء العام للنظام. وقد شهد تطبيقه العملي نمواً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية، وقدم مساهمات كبيرة لمسألة السلامة في ميدان الطيران وفي غيره من الميادين. وفي مجال الطيران، أدت إعادة التصميم الموحد لقمرات القيادة، وتعزيز الاتصالات، والأخذ ببروتوكولات صارمة للتعامل مع حالات الطوارئ أثناء الطيران، والاستثمار في التدريب على المحاكاة، إلى تحسين مستوى السلامة إلى حد بعيد، وكانت هذه العمليات مدفوعة بمنظورات العوامل البشرية.

وبالمثل، تشكل العوامل البشرية عنصراً بالغ الأهمية في تصميم نظم الرعاية الصحية وسلامة المرضى المأمونة والقادرة على التكيف. ويتناول نهج العوامل البشرية المتعدد التخصصات والتكاملي الشخص الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من أحد السياقات الاجتماعية والتقنية، مع مراعاة العاملين الصحيين في بيئة العمل والمريض في مسار الرعاية. ويتجلى الاهتمام بالعوامل البشرية في نظم الرعاية الصحية القادرة على التكيف والمنصفة. ومن ناحية أخرى، تكون العوامل البشرية الضعيفة واضحة في نظم الرعاية الصحية غير المرنة أو المعرضة للخطأ، وهي عوامل ثابتة في أحداث الرعاية الصحية الضائرة. وعلى مدى عدة سنوات، أبدى قادة الرعاية الصحية ومديروها اهتماماً بالفوائد التي تعود على نظمهم الصحية ومنظمتهم من نهج العوامل البشرية والمكاسب المحتملة من تحسين الأداء في مجال سلامة المرضى، ولكن نطاق تنفيذ النهج لا يزال حتى الآن محدوداً للغاية. ومع ذلك، يشكل إدماج العناصر الأساسية التالية للعوامل البشرية في جميع سياقات الرعاية الصحية أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل العالمية هذه.

- **النهج الذي يركز على الأشخاص** والذي ينصب فيه الاهتمام على دعم الأداء البشري والفعالية والرفاهية في سياق الرعاية الصحية. ويحمي ذلك المرضى فضلاً عن مقدمي الرعاية.

- **النهج التشاركي** من أجل تصميم نظام الرعاية الصحية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة (مثل مقدمي الرعاية والمرضى والمديرين) في عملية التصميم واتخاذ القرار لضمان حلول مناسبة وقابلة للتطبيق.

- **النهج القائم على التصميم** والذي يركز على تصميم النظام لجميع أحجام منظمات الرعاية الصحية وأنواعها في جميع فترات الرعاية ويحدد الثغرات القائمة في النظام. ويستند

الهدف الاستراتيجي 2

إقامة نظم صحية عالية الموثوقية ومنظمات صحية تكفل حماية يومية للمرضى من الأذى

الاستراتيجية 1-2:

تطوير وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية التي تشجع التعلم، وليس اللوم والعقاب، داخل كل منظمة تقدم الرعاية للمرضى.

إجراءات للحكومات

- استحداث آلية حماية إدارية وقانونية وتنفيذها، حسب الاقتضاء، لمن يبلغون عن وقوع أحداث ضائرة أو يثيرون شواغل بشأن سلامة الخدمات.
- ضمان أن تستند آلية الحماية إلى التعلم من الإخفاقات في مجال سلامة المرضى، وأن تتمحور حول تحسين نظام العمل، عوضاً عن معاقبة الأفراد، وأن تكون متاحة على نطاق واسع ومعروفة لجميع أصحاب المصلحة.
- تعيين منظمة مستقلة لتلقي المعلومات المتعلقة بسلامة الرعاية الصحية في البلد وتحليل وتجميعها والإبلاغ علناً عنها والتعليق على التقدم المحرز، حسب الاقتضاء.
- رسم حدود واضحة المعالم بين الأخطاء الطبية والإهمال الطبي وتحديد الفروق القائمة في هذا الشأن من أجل ترسيخ ثقافة عادلة وتيسير الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- اعتماد نهج عالمية لإرساء ثقافة السلامة على صعيد النظام الصحي، بما في ذلك بناء الكفاءات في مجال أساليب تغيير الثقافة.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- وضع وتعزيز سياسة غير عقابية للاستجابة للأحداث والأخطاء الضائرة والتعلم منها، وكذلك من الأمور التي تسير على ما يرام، مع توضيح الظروف التي ستطبق فيها المساءلة الفردية.
- وضع نظام للتنفيذ السريع للتوصيات المنبثقة من تحليلات الأحداث الضائرة ومن خلال الإدارة الاستباقية للمخاطر.
- إجراء استقصاء دوري لثقافة السلامة في المنظمة، وتحديد الثغرات، والأخذ بنهج ابتكارية لبناء ثقافة السلامة، بما يتماشى مع الخبرة الدولية وأفضل الممارسات.
- الحد من الهياكل والمواقف والسلوكيات ذات الطابع الهرمي على صعيد المنظمة، وتعزيز ثقافة الإعراب عن الرأي.
- تعزيز الشفافية مع المرضى؛ وضمان حصولهم على سجلاتهم الطبية وإبداء الموافقة المستنيرة الكاملة.
- تكريس ثقافات تنظيمية منفتحة ومحترمة وقائمة على الحقوق.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- العمل مع الهيئات المهنية لتعزيز الانفتاح والتعلم في ثقافة السلامة.
- تشجيع أفراد الجمهور على المساهمة في إرساء ثقافة السلامة في النظام الصحي وإبلاغ نظم سلامة المرضى والتعلم من البيانات المتعلقة بالسلامة والمعلن عنها للعموم.
- إشراك المرضى والأسر والتماس مشورتهم في بناء ثقافة السلامة والثقافة العادلة في مجال الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تأييد مفاهيم الثقافة العادلة وثقافة السلامة وتعزيز أهميتها من أجل تحسين سلامة المرضى داخل نظم الرعاية الصحية.
- وضع ونشر توجيهات بشأن ترسيخ ثقافة السلامة، بما في ذلك الاستقصاءات المتعلقة بثقافة سلامة المرضى، وغيرها من الموارد والأدوات التقنية.
- تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء من أجل إرساء ثقافة سلامة مكيفة مع السياق المحلي، في جميع منظمات الرعاية الصحية وعلى جميع المستويات.

وضع وتنفيذ إطار للحكومة الرشيدة في نطاق كل عنصر من عناصر نظام الرعاية الصحية.

إجراءات للحكومات

- تعيين موظف أو فريق أو وكالة أو مركز يعنى بسلامة المرضى على الصعيد الوطني ويكون متناسباً مع السياق الوطني ومسؤولاً عن تنسيق تنفيذ سلامة المرضى داخل البلد.
- إنشاء لجنة توجيهية وطنية لسلامة المرضى، وتضم ممثلين متعددي التخصصات من العاملين الصحيين والمرضى والجمهور، لإسداء المشورة بشأن تنفيذ خطة التنفيذ ورصدها، بما في ذلك تخصيص الموارد.
- وضع ترتيبات لتعزيز الهياكل التنظيمية لسلامة المرضى على المستويات الوطني ودون الوطني والمحلي لتخطيط الرعاية الصحية وتوفيرها.
- تحديد الهياكل التنظيمية القائمة المتعلقة بسلامة المرضى، بما في ذلك جميع ما يرتبط بها من مجالات سريرية، وبرامج صحية، ومشاريع تحسين الجودة في النظام الصحي، ووضع هيكل حوكمة أمثل يعنى بسلامة المرضى ويلتزم بمبادئ إدارة الجودة.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات ضمن الإطار المؤسسي، مع تحديد واضح للسلطة والمسؤوليات، وقنوات الإبلاغ والاتصال، وتسوية المنازعات من أجل تفعيل هياكل وعمليات سلامة المرضى على المستويين الوطني ودون الوطني.
- وضع متطلبات قانونية وآلية للمساءلة لجميع منظمات الرعاية الصحية للعمل بصورة شفافة وضمان الحد الأدنى من معايير السلامة، ونشر تقرير سنوي عن سلامة المرضى.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تعيين موظف أو فريق مسؤول عن سلامة المرضى وإدارة المخاطر السريرية في كل مرافق من مرافق الرعاية الصحية لتقليل الأذى الذي يلحق بالمرضى وإدارة المخاطر وتحسين سلامة المرضى.
- إنشاء لجنة تُعنى بسلامة المرضى على المستوى التنظيمي، بما في ذلك سلامة المرضى والقيادة السريرية لتكثيف الأولويات الوطنية لسلامة المرضى وتنفيذها بما يتماشى مع الأولويات المحلية.
- وضع مواصفات واضحة للأدوار والمسؤوليات لتحديد المخاطر التي يتعرض لها المرضى والموظفون، والتخفيف منها والقضاء عليها (حيثما أمكن).
- تصميم وتنفيذ هيكل حوكمة سريري فعال لإشراك مقدمي الرعاية بشكل كامل في سياسات وبرامج المنظمة المتعلقة بسلامة المرضى.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الجمع بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين (بما في ذلك الجمعيات المهنية الوطنية، والخبراء الأكاديميون، والباحثون، ومنظمات المجتمع المدني) لتجميع الخبرات والمعارف، وترشيح ممثلي المرضى، وتوليد أفكار بشأن طرق بناء آليات الحوكمة المؤسسية في مجال سلامة المرضى داخل نظم الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- إنشاء لجنة استشارية عالمية لسلامة المرضى للتوجيه وتقديم المشورة بشأن التنفيذ العالمي للقرار ج ص ع 6-72.
- إنشاء آلية عالمية لحوكمة سلامة المرضى بمشاركة الدول الأعضاء، والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، والرابطات المهنية الدولية، والوكالات المعنية بوضع المعايير، ومنظمات المرضى، ومعاهد البحوث، وتتضمن عناصر المساءلة والإبلاغ الإلزامي عن المسائل الحيوية المتعلقة بسلامة المرضى على الصعيد الدولي.
- تعيين أو تسمية منسق معني بسلامة المرضى في جميع مستويات عمل المنظمة.

الاستراتيجية 2-3:

تطوير الإمكانيات والقدرات القيادية السريرية والإدارية على جميع المستويات لضمان تركيز قوي وواضح على إزالة الأذى الذي يمكن تجنبه في قطاع الرعاية الصحية.

إجراءات للحكومات

- تعيين مركز أو أكثر في البلد لتنمية القدرات المتعلقة بالقيادة والبحث والابتكار في مجال سلامة المرضى.
- وضع برنامج لتنمية القدرات القيادية في مجال سلامة المرضى للقادة السريريين والإداريين وصعد متعددة المستويات من التعليم والتدريب الذي يتيح للقوى العاملة ويمكن أن يؤثر على القرارات والتشكيلات في المؤسسات.
- إنشاء مجموعة رائدة في مجال سلامة المرضى للمهنيين الذين هم في بداية مشوارهم الوظيفي في مناصب الرعاية الصحية الحالية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تعيين أو تسمية مسؤول كبير في المنظمة في منصب قيادي في مجال سلامة المرضى.
- منح مناصب قيادية في مجال سلامة المرضى على مستوى كل خدمة سريرية وتدريب الموظفين الحاليين وإعدادهم ودعمهم لشغلها.
- وضع خطة لتعاقب القادة لضمان استمرارية برامج سلامة المرضى واستدامتها واتساقها الثقافي في كل خدمة سريرية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- عقد مناقشات واسعة النطاق بين أصحاب المصلحة لترتيب الأولويات المتعلقة بإعداد القيادات في مجال سلامة المرضى.
- المشاركة في وضع برامج للتدريب على القيادة في مجال سلامة المرضى من خلال عرض وجهات نظر مختلف أصحاب المصلحة.
- تعزيز تنفيذ برامج التدريب على المستويين الوطني ودون الوطني.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- وضع إطار للكفاءات القيادية، والتوجيهات المتعلقة بتنفيذه والأدوات المصاحبة له، وتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء في تنفيذه.
- تصميم دورات وبرامج تدريبية، بما في ذلك في شكل تعلم إلكتروني، لبناء القدرات القيادية في مجال سلامة المرضى لمختلف فئات المهنيين الصحيين.

الاستراتيجية 2-4:

تقديم منظور قوي للعوامل البشرية/بيئية العمل ومداخلات لتعزيز قدرة المنظمات الصحية والممارسات السريرية على الصمود.

إجراءات للحكومات

- إنشاء فريق خبراء للإبلاغ عن الطرق التي يمكن أن تؤدي بها المبادئ المتعلقة بالعوامل البشرية والتدريب إلى إدخال تحسينات مستدامة في مجال سلامة المرضى.
- دمج الخبرات في مجال العوامل البشرية في تصميم المعدات والأجهزة وتكنولوجيا المعلومات وشرائها ونشرها واستخدامها وتقييمها، وكذلك في تصميم المهام والإجراءات.
- ضمان أن جميع متطلبات الترخيص والتنظيم والاعتماد الخاصة بسلامة المرضى تتضمن المبادئ المتعلقة بالعوامل البشرية والتدريب.
- وضع أو تيسير إتاحة برامج تدريبية بشأن العوامل البشرية لمقدمي الرعاية الصحية ومديريها.
- وضع وإنفاذ معايير السلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية والسلامة الهيكلية في مرافق الرعاية الصحية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تقييم الثغرات فيما يتعلق بالعوامل البشرية في عمليات تقديم الخدمات وتصاميم أماكن العمل وبيئات الرعاية.
- بناء قدرات القادة المعنيين بسلامة المرضى في مجال العوامل البشرية.
- تزويد جميع موظفي الرعاية الصحية بالتدريب في مجال العوامل البشرية.
- ضمان الامتثال لمعايير السلامة البدنية مثل السلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية والسلامة الهيكلية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تشجيع الباحثين والهيئات البحثية على إجراء دراسات عالية الجودة حول تطبيق العوامل البشرية لتحسين سلامة الرعاية الصحية والحد من مستوى الأذى الذي يمكن تجنبه.
- تعزيز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال العوامل البشرية ودعمها.
- حشد الخبرات والدراية العملية للعاملين في الصناعات الأخرى العالية المخاطر لتوجيه تصميم برامج العمل من أجل تحسين سلامة المرضى وبناء منظمات رعاية صحية قادرة على التكيف.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تشجيع إنشاء شبكة عالمية من الأفراد والمنظمات ذوي الخبرة والمعرفة الأكاديمية والتجربة في مجال العوامل البشرية لتركيز اهتمامهم على تحسين مجال سلامة المرضى والرعاية الصحية القادرة على التكيف.
- دمج المبادئ المتعلقة بالعوامل البشرية في المعايير العالمية لسلامة المرضى وغيرها من التوجيهات ذات الصلة.

إجراءات للحكومات

- ضمان تمثيل نقاط الاتصال المعنية بسلامة المرضى في آليات التنسيق التي تشمل جميع الجهات الفاعلة في النظام الصحي (القيادة، تقديم الخدمات، التمويل، إدارة سلسلة التوريد، القوى العاملة الصحية، نظام المعلومات الصحية) من القطاعات ذات الصلة (الإنمائية أو الإنسانية).
- ضمان إدراج عناصر سلامة المرضى في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية (التأهب، الاستجابة، الانتعاش، الروتين).
- الاحتفاظ بسجل للمخاطر يتضمن جميع التهديدات المعروفة والمحتملة التي تهدد سير العمل الآمن والفعال لنظم الرعاية الصحية.
- وضع استراتيجيات التخفيف من المخاطر المحددة.
- اختبار مدى مرونة الخطة من خلال تمارين محاكاة منتظمة وتعزيزها وفقاً لذلك.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تحديد المخاطر المرتبطة في سياق حالات الطوارئ وتغشي الأمراض والظروف الشديدة القسوة التي يمكن أن تسبب أذى للمرضى والعاملين الصحيين.
- إعداد خطة للتخفيف من المخاطر بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.
- اختبار قدرة الخطة على التكيف من خلال تمارين محاكاة منتظمة وتعزيزها وفقاً لذلك.

الاستراتيجية 2-5:

إدراج عناصر سلامة المرضى ضمن سياق حالات الطوارئ وتغشي الأمراض وفي الظروف الشديدة القسوة.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تقديم الدعم والخبرة في إدماج عناصر سلامة المرضى في السياسات والاستراتيجيات والخطط والتوجيهات المعيارية الوطنية.
- العمل مع منظمات المجتمع المدني لتعبئة الجمهور، وإذكاء الوعي، وإشراك المجتمعات المحلية بشأن أهمية سلامة المرضى والعاملين الصحيين وبيئة العمل الآمنة.
- تحديد وتيسير فرص توسيع نطاق التعاون المتعدد القطاعات ودعم وترتيب أولويات السلامة في مجال الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- العمل مع الشركاء داخل منظمة الصحة العالمية وخارجها لإدراج عناصر سلامة المرضى في وثائق التوجيه والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل (التأهب، الاستجابة، الانتعاش، الروتين).
- توفير توجيهات معيارية لضمان الأداء المأمون والفعال لنظم الرعاية الصحية من حيث سلامة المرضى وسلامة العاملين الصحيين وبيئة العمل الآمنة.
- تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء بشأن إدراج عناصر سلامة المرضى في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

مصادر تقنية:

منظمة الصحة العالمية. 2018. الوظائف الأساسية للصحة العامة والنظم الصحية والأمن الصحي: تطوير الوضوح المفاهيمي وخارطة طريق منظمة الصحة العالمية للعمل [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241514088>)، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2020. جودة الرعاية في السياقات الهشة والمتضررة من النزاعات والضعيفة: اتخاذ الإجراءات. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337842/9789240015203-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2020. جودة الرعاية في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات والضعيفة: خلاصة الأدوات والموارد. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338035/9789240018006-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

Auraen A, Saar K, Klazinga N. 2020. System governance towards improved patient safety: key functions, approaches and pathways to implementation. OECD Health Working Papers No. 120. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (<https://doi.org/10.1787/2abdd834-en>, accessed 16 July 2021).

Weick K, Sutcliffe K. 2007. Managing the unexpected: resilient performance in an age of uncertainty. San Francisco (CA), United States of America: John Wiley & Sons.

منظمة الصحة العالمية. 2016. العوامل البشرية: سلسلة تقنية بشأن الرعاية الأولية الأكثر مأمونية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021. (<https://www.who.int/publications/i/item/human-factors>)

منظمة الصحة العالمية. 2016. مجموعة أدوات الإنعاش: دعم البلدان لجعل الخدمات الصحية قادرة على التكيف: مكتبة من الأدوات والموارد المتاحة خلال فترة الإنعاش في حالة طوارئ صحية عامة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/>) WHO-HIS-SDS-2016.2، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

الهدف الاستراتيجي 3-

سلامة العمليات السريرية

ضمان سلامة كل عملية سريرية



الأسباب عدم التواصل بصورة جيدة مع المريض. وفي الخدمات الجراحية التي تقدم في أجزاء مختلفة من العالم، يحدث تنفيذ الإجراء الخاطئ، أو نقل فصيلة الدم أو المكون الخطأ، أو تركيب الطرف الاصطناعي الخاطئ، أو حتى إجراء عملية جراحية للمريض الخطأ. ويموت المرضى أو يتعرضون للأذى بسبب عدم تقديم الرعاية بطريقة تحميهم من الإصابة بعدوى خطيرة. وتموت الأمهات والأطفال أثناء الولادة أو بعدها بسبب ممارسات غير مأمونة، أو عدم اتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب، أو بسبب نقص الموظفين أو المعدات. وتقع أعداد كبيرة من الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى بسبب أخطاء تحدث في وصف الأدوية وفي طلبها وتخزينها وتوزيعها وإعدادها وإعطائها أو عدم رصد العمليات المتصلة بالأدوية واستخدامها.

وفي العديد من البلدان المنخفضة الدخل وبعض البلدان المتوسطة الدخل، يتباين سياق توفير الرعاية الصحية تبايناً شديداً. وفي بعض الأحيان، قد لا تتمكن هذه المرافق من توفير الحد الأدنى لإكمال العمل السريري وفقاً لمعيار أساسي، ناهيك عن تنفيذ المهام مع مراعاة السلامة المطلوبة. وعلى سبيل المثال، فقد لا يتوافر الماء الجاري أو الصابون؛ ولا الأدوات المعقمة؛ ولا كامات العمل؛ ولا يقدم أي دعم لإصلاح البنية التحتية أو صيانتها، بما

لما كان المرضى يلتمسون المساعدة من نظام الرعاية الصحية لأغراض المشورة والتحقق والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، فإنهم يدخلون في سلسلة من عمليات الرعاية التي غالباً ما تكون مترابطة بشكل واسع. ويكون عدد ونطاق العمليات والإجراءات السريرية ضخماً وهو يختلف من المستوى البسيط نسبياً، مثل وصف أحد الأدوية، إلى مستوى أشد تعقيداً بكثير، مثل العملية الجراحية في القلب. وفي هذه العملية، يشمل كل جزء من مرحلة التحضير، والإجراء نفسه، والرعاية اللاحقة العديد من العمليات التي تتضمن كل واحدة منها خطوات ومراحل منفصلة، حتى أنها تشمل بشكل روتيني 60 شخصاً بل وعدداً أكبر في بعض الأحيان.

وتعزى نسبة عالية من الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتي تقع في نظم الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم إلى نقائص في تصميم العمليات السريرية أو في تشغيلها. وعلى سبيل المثال، تظهر البحوث وتقارير الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى أن الحالات الصحية للمرضى تشخص في أغلب الأحيان تشخيصاً خاطئاً لأسباب منها سوء التقدير السريري، أو نظراً لعدم إجراء الاختبار الصحيح أو فقدان نتائج الاختبار، أو سوء الاتصال بين مختلف أجزاء نظام الرعاية الصحية نفسه. ومن أبرز هذه

وتنتشر يومياً حوالي 7 000 ورقة ويجري إدراجها في قاعدة بيانات العلوم السريرية الرئيسية. وبالتالي، فمن الصعب للغاية بالنسبة للطبيب الفرد المشغول مواكبة أحدث وأفضل البيانات.

وهناك عدد من السمات العامة للعمليات السريرية التي تحدد ما إذا كانت قد تقضي إلى نتائج غير مأمونة. وعلى سبيل المثال، يكون تحديد الهوية بشكل غير صحيح هو المسؤول عن الأخطاء الدوائية والموقع الخطأ، والجراحة الخاطئة للمريض. ويشكل تحسين التواصل الضروري بين العاملين الصحيين والمرضى عنصراً بالغ الأهمية ومن شأنه الحيلولة دون وقوع ملايين الأحداث الضائرة. ويساهم تصميم أغلفة الأدوية ووسمها في حدوث أخطاء دوائية ووفيات.

ثم إن هناك مجالات سريرية رئيسية تحدث فيها نتائج ضائرة باستمرار بسبب الإخفاقات المسجلة في سلامة الرعاية. وعلى سبيل المثال، تظهر بيانات الإبلاغ والدراسات البحثية أن سقوط المريض يمثل نسبة كبيرة من الأذى الذي يمكن تجنبه. ويحدث هذا السقوط في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ولكن 80٪ منه يحدث في البلدان المنخفضة والمتوسط الدخل. وقد تتجم عن حالات السقوط عواقب وخيمة، مثل كسر الوركين ونزيف الدماغ والموت في بعض الأحيان. وتشمل الإخفاقات الكامنة وراء العملية في ضعف الإشراف على المرضى المسنين، وإهمال إجراء تقييم لعملية السير، والبيئات الخطرة. وتتضمن الحلول الناجحة العمل الجماعي الأكثر اتساقاً، وبيانات الرصد الجيدة، وتركيز الثقافة الصحية، والاستعراض النقدي للمخاطر البيئية، وتطبيق بروتوكولات أفضل الممارسات بصرامة لجعل الوقاية من السقوط أولوية من الأولويات.

وثمة أيضاً مجموعة من البرامج السريرية الأخرى التي تتضمن أطراً تنظيمية، وطرائق قيادية، وآليات لتقديم الخدمات على المستويات العالمي والإقليمي والقطري وعلى مستوى المرافق الصحية والمجتمعات المحلية. وقد لا يكون لمعظمها تفاعل أو ارتباط مباشر بالبرنامج المعني بسلامة المرضى. وتشمل هذه البرامج التحصين، ونقل الدم، والعلاج الإشعاعي، والحقن، والولادة، والجراحة، والصحة النفسية، وشيخوخة السكان، والرعاية الأولية، والوقاية من الإصابات، والأمراض غير السارية والسارية. ولسلامة المرضى دور مركزي في جميع هذه المجالات، ولكن إمكانية تحديد مصادر الخطر والأذى وتصميم سبل التصدي لها لم تستكشف بشكل كافٍ.

في ذلك الكهرباء؛ وتتسم نظم التخلص من النفايات السريرية بعدم الفعالية؛ ولا توجد سلاسل إمداد قوية وتكون ظروف تخزين الأدوية غير ملائمة؛ ولا يوجد دعم تقني لصيانة الأجهزة؛ ولا توجد تدابير بشأن السلامة من الحرائق؛ وتكون خدمات التنظيف والأمن سيئة، ولا تتوفر تكنولوجيا للمعلومات أو مصادر للبيانات. وإذا لم يعالج هذا النقص في مصادر الأذى في البنية التحتية الأساسية، فلن ترجى أي فائدة تذكر من تطبيق القوائم المرجعية أو التدخلات المعقدة المتعلقة بسلامة المرضى والمستمدة من السياقات المرتفعة الدخل.

ويلزم اتباع نهج أوسع من ذلك بكثير إزاء سلامة المرضى بالنسبة للبلدان ذات الموارد المحدودة التي تتلقى زيارات من خبراء سريريين من البلدان الأكثر ثراء. ويمثل ذلك شكلاً هاماً من أشكال الدعم، ولكنه قد لا يحتاج، في بعض الأحيان، إلى المشورة أو التدريب على التقنية الجراحية، بل يُحتاج من زوار أحد المستشفيات في بلد منخفض الدخل أن يكون بينهم شخص يعرف كيفية إقامة مرفق آمن للنفايات السريرية، أو قادر على تعليم كيفية صيانة حاضنة للأطفال حديثي الولادة، أو معالجة الحالة التغذوية للمرضى.

وهذا التفكير الأشمل بشأن كل ما يشكل الرعاية السريرية المأمونة مطلوب أيضاً في البلدان التي تشهد نزاعاً وعدم استقرار سياسي. وسيكون هناك بالفعل نقص في الموارد، ولكن وجود نظم صحية ضعيفة سيزيد إلى حد بعيد من الحاجة إلى الرعاية الصحية. ويشكل وجود عدد كبير من اللاجئين أو المهاجرين والمخيمات عبر الحدود، فضلاً عن انتشار الأمراض الوبائية، تحديات هائلة. وتمتلك الوكالات الإنسانية الكثير من الحكمة والخبرة للمساهمة في هذا الصدد.

وتبرز هذه الأمثلة الحاجة إلى نهج النظم في تصميم العمليات السريرية. وستختلف متطلبات التصميم المأمون حسب الظروف والحالات، ولذلك يجب تصميم العمليات وفقاً لذلك. ويجب مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على العملية السريرية لدى تصميم العملية، أي البيئة، والوسط المحيط، والسياق المادي، والإجراءات، والمشغولات الحرفية، وفحوصات السلامة، والعمل الجماعي، والمخاطر، والثقافة والهيكل التنظيميان، وكذلك اللوائح والسياسات الوطنية. وفي نهاية المطاف، يعني تصميم العمليات السريرية المأمونة وتنفيذها التغلب على التحديات المتعلقة بتنوعها وتعقيدها. وهناك أكثر من 4 000 عملية طبية وجراحية يمكن إجراؤها. وبالنسبة للأطباء والمرضى الذين يديرون العمليات السريرية، تتزايد كمية المعلومات الضرورية لتوجيههم طوال الوقت.

الهدف الاستراتيجي 3

ضمان سلامة كل عملية سريرية

الاستراتيجية 1-3

تحديد جميع الإجراءات السريرية المعرضة للخطر والتخفيف من مخاطرها، مع مراعاة الأولويات الوطنية والمحلية.

إجراءات للحكومات

- إنشاء أفرقة خبراء لتحديد المعلومات المتعلقة بالمجالات والمصادر الرئيسية للخطر والأذى اللذين يمكن تجنبهما وتقييم ومسح وتبليغ هذه المعلومات في كل مجال من مجالات الممارسة السريرية.
- إنشاء قاعدة بيانات للمعارف والأدوات وتحديثها بانتظام لتمكين المنظمات ومهنيي الرعاية الصحية من التخفيف من المخاطر والتحكم في الأذى المرتبط بالعمليات السريرية.
- وضع مجموعة من برامج تحسين سلامة المرضى بقيادة سريرية كل عام بما يتفق مع الخطة والاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى (انظر الاستراتيجية 1-1) التي تستهدف المواضيع المنهجية (تحديد هوية المرضى، سلامة التشخيص)؛ ومجموعات المرضى (مرضى الخرف، المرضى من الأطفال)؛ وأماكن الرعاية الصحية (الرعاية الأولية، دور التمريض)؛ ومصادر الأذى (الجلطات الدموية الوريدية، الإنتان، سقوط المريض)؛ ومجالات الممارسة السريرية (الرعاية الجراحية، الرعاية الحرجة، الخدمات الطبية الطارئة، العلاج الإشعاعي؛ وبرامج الصحة النفسية والصحة العامة (التحصين، الصحة الإنجابية، صحة الأم).
- تقديم التوجيه والدعم القيادي للبرامج السنوية لتحسين سلامة المرضى وتقييمها ونشر الدروس المستفادة من البرامج العامة تحسين السلامة والجودة في القطاع الصحي.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تعيين أو تسمية موظفين في مجال سلامة المرضى أو مديرين في مجال المخاطر السريرية في مرافق الرعاية الصحية الكبيرة.
- إنشاء مجموعة قيادية سريرية داخل المنظمة لتكييف الأولويات الوطنية السنوية لتحسين سلامة المرضى والدفع بها قدماً جنباً إلى جنب مع الأولويات المحلية للخدمات السريرية.
- تحديد مجالات الخدمات السريرية الرئيسية التي تتطلب تحسيناً مركزاً لسلامة المرضى استناداً إلى الأولويات الصحية الوطنية والمحلية، ومدى أهمية الخدمات المقدمة، وحوادث السلامة المبلغ عنها.
- تحديد جميع الإجراءات السريرية المعرضة للمخاطر ضمن نطاق الرعاية التي تقدمها المنظمة للمرضى ووضع مجموعة من الإجراءات اللازمة لتخفيف المخاطر.
- تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر السريرية لتحسين رعاية المرضى، مثل معالجة الجلطات الدموية الوريدية، والسقوط، وقرحة الضغط، وتحديد هوية المريض، والتواصل أثناء مراحل الرعاية الانتقالية.
- تعزيز الاستخدام الأوسع لإجراءات التشغيل القياسية المعتمدة في جميع المجالات السريرية بالتشاور مع الأطباء.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تشجيع المنظمات المهنية على تحديد مصادر الخطر والأذى بشكل منهجي في كل مجال من مجالات الرعاية السريرية وتيسير السبل التي تتيح لها ذلك، وصياغة حلول بشأن سلامة المرضى لمختلف بيئات الرعاية الصحية، وتبادل ما لديها من خبرات.
- إنشاء آليات للمرضى والأسر من أجل المشاركة في تصميم عمليات رعاية صحية أكثر مأمونية.
- دعم البلدان ومقدمي الرعاية الصحية في منح الأولوية لبرامج السلامة السريرية على أساس السياق والعبء والجودة.
- الدعوة إلى إدراج مكونات سلامة المرضى وإدماجها ومنحها الأولوية في برامج الصحة العامة الدولية، مثل صحة الأم والوليد، والصحة الإنجابية، والتحصين، وأمراض المناطق المدارية المهملة.
- وضع ترتيبات عمل تعاونية مع شركاء القطاع الخاص لتحديد المخاطر الملزمة لمنتجاتهم وخدماتهم والتخفيف من حدتها.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- استعراض البَيِّنَات لتحديد الإجراءات السريية المعرضة للمخاطر بالتعاون مع الهيئات المهنية والخبراء والأوساط الأكاديمية وممثلي المرضى والأسر أو أصحاب المصلحة والشركاء ذوي الصلة.
- إعداد أدوات التقييم والتوجيه لتحديد هذه المخاطر والتخفيف من حدتها، على سبيل المثال في المجالات المتعلقة بسلامة التشخيص، وسقوط المرضى، والجلطات الدموية الوريدية.
- وضع برامج لتحسين سلامة المرضى بالتعاون مع إدارات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة التي تستهدف المواضيع المنهجية، ومجموعات المرضى، ومختلف بيئات الرعاية الصحية، ومصادر الأذى، والمجالات السريية، وبرامج الصحة العامة.
- دعم تنفيذ ورصد وتقييم الأدوات والموارد مثل قائمة منظمة الصحة العالمية للتحقق من السلامة في العمليات الجراحية والقائمة المرجعية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الولادة المأمونة.
- تجميع ونشر أفضل الممارسات وقصص النجاح.

إجراءات للحكومات

- اتخاذ إجراءات مبكرة لحماية المرضى من الأذى الناجم عن الحالات العالية المخاطر، وتعيد الأدوية، ومراحل الرعاية الانتقالية.
- دعوة الخبراء الوطنيين وقادة النظم الصحية والممارسين في أفرقة العمل المتعددة التخصصات إلى إعداد توجيهات وخطط عمل لكل مجال من المجالات الأربعة (المرضى والجمهور، والأدوية، ومهنيو الرعاية الصحية، ونظم وممارسات الأدوية) للتحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: أدوية بلا أذى.
- وضع آليات، بما في ذلك استخدام الأدوات والتقنيات، لتعزيز وعي المرضى ومعرفتهم بالأدوية وبعملية استخدام الدواء، بما في ذلك أدوار المرضى في تناول أدويتهم بأمان.
- ضمان إدراج سلامة استخدام الأدوية التقليدية والتكميلية في البرامج الرامية إلى معالجة مسألة سلامة الأدوية.
- تعيين منسق وطني لقيادة التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: أدوية بلا أذى.
- تشجيع الإبلاغ عن الأحداث الدوائية الضائرة والأخطاء الدوائية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إنشاء فريق قيادي داخل المنظمة لتنفيذ التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: أدوية بلا أذى، لإجراء تقييم للإجراءات المبكرة والموافقة عليها مع مراعاة التوجيهات والأولويات الوطنية.
- تعيين موظف أو فريق مسؤول عن سلامة الأدوية في كل مرفق من مرافق الرعاية الصحية؛ والتوعية بمخاطر الأدوية وتنفيذ ممارسات السلامة في كل خدمة سريرية داخل المنظمة.
- تحديد الأخطاء وأشكال الأذى المرتبطة بالأدوية من خلال نظام الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم في المنظمة، والتحقق في أسبابها الجذرية، واتخاذ إجراءات لضمان منح الأولوية للتعلم.
- رصد التقدم المحرز في الحد من الأذى المرتبط بالأدوية داخل خدمات المنظمة، وذلك باستخدام نظام اليقظة الدوائية القائم عند الاقتضاء. وتنبيه السلطات الوطنية إلى كل ما يبدو أنه مصدر جديد للأذى المرتبط بالأدوية.
- المشاركة في تصميم وتنفيذ التدابير اللازمة لتحسين معرفة المريض بالأدوية. وضمان أن المرضى على دراية بأدوات سلامة الأدوية وإمكانهم الحصول على هذه الأدوات التي تسمح للمريض بالتركيز على النقاط الرئيسية في عملية التداوي للتخفيف من المخاطر.
- تشجيع جميع المرضى الذين تقوم المنظمة بخدمتهم على استخدام تطبيق منظمة الصحة العالمية الخاص بالهاتف المحمول (MedSafe) (5 مراحل لسلامة استخدام الأدوية)، والذي يسمح للمريض بالتركيز على النقاط الرئيسية في عملية التداوي لتخفيف المخاطر.

الاستراتيجية 2-3

تنفيذ برنامج لإحداث تحول في سلامة إدارة الأدوية واستخدامها استناداً إلى التحدي العالمي الثالث للمنظمة بشأن سلامة المرضى متمثلاً في: أدوية بلا أذى.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- ضمان مشاركة المرضى والأسر ومنظمات المجتمع المدني بشكل وثيق في جميع جوانب التحدي وإعداد الأدوات اللازمة لمساعدة المرضى على حماية أنفسهم من الأذى.
- إشراك أصحاب المصلحة بشكل كامل لتنفيذ التحدي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والبحثية، والسلطات التنظيمية، والجمعيات المهنية الصحية، والهيئات الصيدلانية، ومجموعات الدفاع عن المرضى، والجهات المانحة، والصناعة الصيدلانية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- وضع وتنفيذ استراتيجية للاتصالات والدعوة وتعزيز الحملة العالمية "اعرف. تحقق. اسأل" وأداة "5 مراحل لسلامة استخدام الأدوية".
- الدعوة إلى تقييم وتحديد عبء الأذى المرتبط بالأدوية بسبب الأدوية والممارسات الدوائية غير المأمونة ودعمه، ومواصلة الجهود بنشاط لتحسين سلامة الأدوية.
- قيادة عملية التغيير واتخاذ إجراءات عالمية لإحراز تقدم في المجالات الأربعة وثلاثة مجالات عمل مبكرة لإطار /التحدي، وتوفير أدوات للبلدان لدعم عملية إدارة التغيير.
- إعداد مواد تقنية ونشرها، بما في ذلك حلول سلامة المرضى، والتقارير التقنية، وأدوات ومنهجيات القياس (مثل أدوات تقييم سلامة الأدوية)، وإطار الرصد والتقييم لرصد التقدم المحرز وتقييم أثر التحدي.
- دعم البلدان في إنشاء وتعزيز آليات للإبلاغ عن الأخطاء الدوائية، وتعزيز دور الفريق المتعدد التخصصات في مجال سلامة الأدوية وتشجيع التعلم من الأخطاء.
- ترتيب أولويات البحوث المتعلقة بعبء الأذى المرتبط بالأدوية وفعالية التدخلات الرامية إلى معالجة مسألة سلامة الدواء.

إجراءات للحكومات

- وضع برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها لتوفير السلامة للمرضى والعاملين الصحيين والزوار.
- وضع سياسة وبرنامج وطنيين للوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يتواءم مع السياسة العامة الوطنية والبرنامج الوطني لسلامة المرضى، مع أهداف ووظائف وأنشطة محددة بوضوح وفقاً للأولويات الوطنية الرامية إلى الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومكافحة مقاومة الميكروبات من خلال تكريس ممارسات جيدة في هذا المجال.
- تكييف التوجيهات التقنية واستراتيجيات التنفيذ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع السياق الوطني وبناء القدرات اللازمة للمكونات الأساسية لمجال الوقاية من العدوى ومكافحتها.
- تشجيع متطلبات الإبلاغ العامة الروتينية عن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ومقاومة مضادات الميكروبات وغيرها من الأحداث الضائرة من مرافق الرعاية الصحية (بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الطويلة الأجل) إلى الحكومات المحلية والوطنية.
- إنشاء نظم لترصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات، لرصد الممارسات المتبعة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها وتقييم التقدم والتحسين بمرور الوقت ومقارنتها بأحسن الممارسات وأفضل المعايير.
- تكريس وضمان قدرات وإمكانات الاختبار المناسبة في مختبرات الرعاية الصحية على المستويات المحلي والوطني والعالمية لتحسين الكشف عن الكائنات المقاومة لأدوية متعددة والتصدي لها في أماكن الرعاية الصحية.
- توفير الأحكام التنظيمية والموارد والتوجيهات الملائمة بشأن مناوله النفايات المعدية والتخلص منها.

الاستراتيجية 3-3:

وضع تدابير صارمة ومُثبتة بالبيانات للوقاية من العدوى ومكافحتها، بغية التقليل إلى أدنى حد من حدوث حالات عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات الوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية (راجع المتطلبات الدنيا لمنظمة الصحة العالمية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها، 2019).
- تعيين موظف مسؤول في كل مرفق للرعاية الصحية لتنسيق الجهود المبذولة من أجل سلامة المرضى وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها لمنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ولمكافحة مقاومة الميكروبات.
- تنفيذ إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإشراف على إعطاء المضادات الحيوية، وتوفير التثقيف الشامل في مجال إدارة النفايات، وتقديم التدريب لجميع العاملين الصحيين باستخدام استراتيجيات قائمة على الأفرقة والمهام وتشمل التدريب بجانب السرير والمحاكاة.
- القيام بالترصد الوبائي المنتظم للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات) لتوجيه التدخلات والكشف عن الفاشيات وتقديم تعقيبات سريعة على النتائج (بما في ذلك إبلاغ الشبكات الوطنية) للعاملين الصحيين وأصحاب المصلحة وسلطات الصحة العامة.
- تشجيع وتنفيذ استخدام الاختبارات التشخيصية لتعزيز نتائج التعرف المبكر والدقيق على مسببات الأمراض ومقاومة الميكروبات لتوجيه أنجع علاج وأكثره سلامة للمرضى باستخدام الأدوية والجرعات ومدة العلاج المناسبة.
- تنفيذ استراتيجيات متعددة الوسائط في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها؛ ومراجعة الامتثال لمعايير الوقاية من العدوى ومكافحتها ونتائج التعقيبات المقدمة لقيادة المنظمة والموظفين.
- ضمان بيئة نظيفة وصحية تتضمن بنية تحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع توافر المواد والمعدات المناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها.
- تنفيذ عمليات قائمة على البينات لفصل النفايات المعدية ونقلها والتخلص منها.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تعهد الشبكات والمجموعات ذات الخبرة والمشاركة البحثية في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها للمساعدة في وضع مبادئ توجيهية وتقديم المشورة بشأن تطبيقها في مختلف بيئات الرعاية الصحية وسياقاتها.
- ربط عمل جميع البرامج والمنظمات المهنية ذات الصلة بالبرامج الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها.
- التوعية بأهمية الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في مجال الرعاية الصحية على المستويات المحلي والوطني والعالمي.
- الدعوة إلى تخصيص موارد تركز لوضع ودعم برامج تتصل بالوقاية من العدوى ومكافحتها، والأمراض المرتبطة بالرعاية الصحية، ومقاومة مضادات الميكروبات على المستويات المحلي والوطني والعالمي.
- تشجيع المساءلة والإبلاغ العام عن البيانات والشفافية لإحراز تقدم نحو الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات في مجال الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- توفير القيادة وسبل الاتصال والتنسيق لدعم البرامج الناجحة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها عبر مختلف بيئات الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم.
- ضمان الاتصال الإلكتروني والجهود المنسقة مع الإدارات المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية داخل منظمة الصحة العالمية.
- تقديم توجيهات وتوصيات بشأن أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في مجال الرعاية الصحية.

- تصميم وإدارة الحملات ومبادرات الدعوة لإنكفاء الوعي ببرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوليد الحماس وكسب الالتزام بشأنها للحد من الأذى ومنع الوفاة.
- تيسير وحشد التمويل لبناء القدرات القطرية في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها.
- وضع أهداف ومعايير محددة وقياس التقدم المحرز في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع أنحاء العالم واستخلاص رسائل رئيسية لنشرها على الصعيد العالمي.
- إعادة تقييم وتقييم وتحديث المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوقاية من العدوى ومقاومتها والمبادئ التوجيهية الأخرى المتصلة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومقاومة الميكروبات، حسب الاقتضاء، وضمان اتساق هذه المبادئ التوجيهية مع الوثائق التوجيهية الأخرى الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

إجراءات للحكومات

- تعزيز برامج السلامة المتعلقة بالأجهزة الطبية، والدم ومشتقات الدم، واللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية بدءاً من إنتاجها وتخزينها وتوريدها إلى استخدامها في المستشفى أو العيادة أو المجتمع المحلي.
- توفير السياسات والأحكام القانونية والتنظيمية الملزمة لضمان إمكانية تنفيذ هذه البرامج بأمان وفعالية لتحقيق الغرض المنشود منها.
- إقامة روابط ثنائية الاتجاه لبرامج سلامة الأجهزة الطبية والأدوية والدم ومشتقات الدم واللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية مع برامج سلامة المرضى.
- وضع برنامج وطني للدم يدعمه إطار سياساتي وتشريعي متعلق بهذا الموضوع.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- الاقتصار على استخدام الأجهزة الطبية المأذون بها والتي تفي بمعايير السلامة المنصوص عليها.
- استحداث آليات للصيانة والمعايرة المنتظمين لجميع المعدات الحيوية.
- ضمان توافر دليل التشغيل وتعليمات السلامة للمعدات بشكل دائم عند نقطة الاستخدام وحصول الموظفين الجدد على تدريب توجيهي بشأن الاستخدام المناسب، وكذلك على التدريب أثناء العمل على تحسين الأجهزة.
- اعتماد إجراءات تشغيل موحدة لخدمات نقل الدم والمشاركة في برنامج خارجي لتقييم الجودة وفي برنامج بشأن اليقظة في نقل الدم.
- اعتماد إجراءات تشغيل موحدة وبروتوكولات السلامة المتعلقة بخدمات التحصين.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الحفاظ على معايير السلامة والجودة الدولية المتفق عليها بشكل متبادل للأجهزة الطبية والدم ومشتقات الدم والأدوية واللقاحات.
- التعاون مع قادة الصناعة لتحسين المنتجات والأجهزة في مجالات تخصصهم.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- وضع توجيهات معيارية لضمان سلامة المنتجات الطبية.
- تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددي القطاعات لمنع انتشار المنتجات الطبية غير المستوفية للمعايير والمغشوشة.
- دعم الدول الأعضاء في وضع برامج مراقبة سلامة المنتجات الطبية وتنفيذها وتعزيزها.
- تعزيز ودعم تنظيم الحملات العالمية، بما في ذلك تخليد اليوم العالمي للمبتربين بالدم والاحتفال به في 41 حزيران/يونيو من كل عام.

الاستراتيجية 3-4:

ضمان سلامة الأجهزة الطبية والأدوية والدم ومشتقاته واللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية

- إنشاء بنى تحتية للمعلومات المتكاملة لإتاحة التدفق الحر للمعلومات على صعيد بيانات الرعاية الصحية.
- وضع إجراءات وبروتوكولات تسليم موحدة وواضحة داخل مرافق الرعاية الصحية والرعاية المنزلية وفيما بينها.
- وضع وتنفيذ مسارات التشخيص والعلاج والإحالة في مجال الرعاية الأولية.
- إدخال عناصر سلامة المرضى وتعزيزها لدى تقديم الخدمات، ومنح الترخيص والاعتماد للرعاية الأولية، وخدمات رعاية المسنين وخدمات الرعاية المنزلية.
- توسيع نطاق تدخلات نظام سلامة المرضى مثل نظم الإبلاغ والتعلم، ودمج التكنولوجيات الرقمية، وثقافة السلامة، وإشراك المرضى عبر سلسلة الرعاية المستمرة، بما في ذلك الرعاية الأولية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- توحيد أشكال سجلات المرضى في الرعاية الأولية والإسعافية ودعمها بسجلات صحية إلكترونية.
- تنفيذ إجراءات تشغيل موحدة وإنشاء قنوات واضحة للتواصل مع مختلف مقدمي الرعاية عبر مراحل الانتقال أثناء الرعاية، وكمثال على ذلك من سياق الرعاية الأولية إلى سياق المستشفى لإحالة المرضى.
- إدراج خدمات الرعاية الأولية والإسعافية في نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها.
- تنفيذ مسارات التشخيص والعلاج في خدمات الرعاية الأولية، على غرار خدمات المستشفيات.
- تنفيذ إجراءات تسليم موحدة على صعيد مرافق الرعاية الصحية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تقديم الدعم في مجال تكييف وتنفيذ الاستراتيجيات والتدخلات المتعلقة بسلامة المرضى عبر سلسلة الرعاية المستمرة، بما في ذلك الرعاية الأولية وحالات الانتقال أثناء الرعاية.
- بناء قدرات منظمات الرعاية الأولية على توفير رعاية أكثر مأمونية.
- تعزيز البحوث المتعلقة بسلامة المرضى في المجالات والسياقات المختلفة عبر سلسلة الرعاية، بما في ذلك الرعاية الأولية ومراحل الانتقال أثناء الرعاية.
- إدراج وتعزيز عناصر سلامة المرضى في برامج الدعم التقني الدولية عبر سلسلة الرعاية المستمرة، بما في ذلك الرعاية الأولية ومراحل الانتقال.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- دمج مكونات سلامة المرضى في عمل المنظمة بشأن استمرارية الرعاية في جميع بيئات الرعاية الصحية، مع التركيز على الرعاية الأولية.
- إعداد الأدوات والتوجيهات اللازمة لتحسين سلامة المرضى عبر استمرارية الرعاية مثلما هو الحال في بيئات الرعاية الأولية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والتعزيزية، والتواصل المأمون أثناء مراحل انتقال الرعاية.
- تقديم الدعم التقني لبناء القدرات القطرية في تنفيذ الاستراتيجيات والتدخلات المتعلقة بسلامة المرضى عبر سلسلة الرعاية المستمرة.
- إعداد توجيهات وأدوات بشأن سلامة المرضى في إطار الرعاية المنزلية.

- منظمة الصحة العالمية. 2015. قائمة منظمة الصحة العالمية المرجعية للولادة المأمونة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199179/WHO_HIS_SDS_2015.26_eng.pdf;jsessionid=2FC7A277BCFCB23202AD9A).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2015. دليل تنفيذ القائمة المرجعية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الولادة المأمونة: تحسين نوعية الولادة في المرافق الصحية للأمهات والمواليد. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199177/9789246549450-ara.pdf?sequence=11&isAllowed=y>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2016. دليل لإنشاء نظام وطني بشأن اليقظة في نقل الدم [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/a-guide-to-establishing-a-national-haemovigilance-system>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2016. المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن استخدام المحاقن المعدة بأمان للحقن العضلي وداخل الأدمة وتحت الجلد في أماكن الرعاية الصحية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549820>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2017. التحدي العالمي الثالث لسلامة المرضى لمنظمة الصحة العالمية: أدوية بلا أذى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2017.6>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2019. برامج الإشراف على مضادات الميكروبات في مرافق الرعاية الصحية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل: مجموعة أدوات عملية صادرة عن منظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241515481>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2019. المتطلبات الدنيا لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516945>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2019. المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة: مرشد للمهنيين الصحيين [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-WSH-19.149>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2021. أدوية بلا أذى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2021. رعاية أولية أكثر مأمونية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/safer-primary-care>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2019. المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية: خطوات عملية لتحقيق التغطية الشاملة في مجال الرعاية الجيدة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241515511>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- de Bienassis K, Llana-Nozal A, Klazinga NS. 2020. The Economics of patient safety part III: long-term care: valuing safety for the long haul. OECD Health Working Paper No. 121. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (<https://doi.org/10.1787/be07475c-en>; accessed 16 July 2021).
- International Atomic Energy Agency. 2014. Radiation protection and safety of radiation sources: international basic safety standards. Vienna: IAEA (https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf, accessed 16 July 2021).
- Slawomirski L, Auraen A, Klazinga N. 2018. The economics of patient safety in primary and ambulatory care: flying blind. OECD Health Working Papers No. 106. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (<https://doi.org/10.1787/baf425ad-en>, accessed 16 July 2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2006. سلامة الأدوية في برامج الصحة العامة: اليقظة الدوائية كأداة أساسية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9241593911>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2007. حلول منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/patientsafety/topics/solutions/en>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2008. موجز بيانات مخاطر العلاج الإشعاعي: دليل تقني [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/patientsafety/activities/technical/radiotherapy_risk_profile.pdf).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2009. القائمة المرجعية للسلامة الجراحية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44186/9789241598590_eng_Checklist.pdf?sequence=2).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2009. توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن الجراحة المأمونة: الجراحة المأمونة تتخذ الأرواح [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44185/9789241598552_eng.pdf?sequence=1).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2012. نظافة اليدين في العيادات الخارجية والرعاية المنزلية ومرافق الرعاية الطويلة الأجل: دليل لتطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لتحسين نظافة اليدين المتعددة الوسائط ونهج "اللمحظات الخمس لنظافة اليدين [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2014. ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية: التصدي لتحدي رئيسي للصحة العامة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506670>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2015. مبادئ توجيهية بشأن المكونات الأساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني ومستوى مرافق الرعاية الصحية العاجلة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549929>).
اطلع عليه في 26 آذار/مارس (2021).

الهدف الاستراتيجي 4-

إشراك المرضى والأسر

إشراك وتمكين المرضى وأسرهم
من تقديم المساعدة والدعم
لتحقيق رعاية صحية أكثر
مأمونية



ولدى منظمة الصحة العالمية منذ عام 2005 برنامج بعنوان المرضى الملتمزمون بسلامة المرضى. ويمثل هذا البرنامج شبكة دولية فريدة من نوعها شارك في وضعها وتعهدها فريق يتألف من مدافعين عن سلامة المرضى ومناصرين لهم ويضم مرضى تعرضوا للأذى ونجوا منه، أو أفراد أسر فقدوا أحد أحبائهم بسبب الرعاية غير المأمونة. وهي ترمي إلى التشديد على حقوق المرضى وتكريس الشفافية والشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز دور المريض في مجال سلامة المرضى. وقد أثبتت هذه المجموعة، خلال سنوات وجودها، أنها صوت عالمي للتعبير عن أهم شواغل المرضى المتمثل في سلامة رعايتهم. وأصدرت المجموعة إعلان لندن الذي يحدد أربعة مجالات عمل واسعة النطاق.

- وضع وتعزيز برامج لسلامة المرضى ولتمكينهم.
- إقامة وقيادة حوار بناء مع جميع الشركاء المعنيين بسلامة المرضى.
- إنشاء نظم للإبلاغ عن الأذى الذي يحدث في الرعاية الصحية ومعالجته على نطاق عالمي.

قد يكون إشراك المرضى وتمكينهم هو أقوى أداة لتحسين سلامة المرضى. ويقدم المرضى والأسر وغيرهم من مقدمي الرعاية غير الرسميين رؤى ثاقبة مستخلصة من تجاربهم في مجال الرعاية التي لا يمكن للأطباء أو المديرين أو الباحثين الاستعاضة عنها أو تكرارها. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأشخاص الذين عانوا من الأذى. ويمكن للمرضى والأسر ومقدمي الرعاية أن يكونوا مراقبين يقظين لحالة المريض وبوسعهم تتبعه مقدمي الرعاية الصحية لدى بروز احتياجات جديدة. ومن خلال إعطاء المعلومات المناسبة، يمكن للمريض وأسرته تقديم المساعدة وذلك بأن يكونوا عيون النظام وآذانه.

لا تشارك معظم البلدان، ولا سيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشاركة قوية في تحسين سلامة المرضى. ولا تكون أصوات المرضى بارزة في العديد من نظم الرعاية الصحية. وقد لا تظهر هذه الأصوات داخل البلدان لعدة أسباب تتمثل في الخصوصيات الثقافية؛ أو عدم تحديد المدافعين المناسبين عن المرضى والمناصرين لهم أو تشجيعهم على إسماع أصواتهم؛ والافتقار إلى القيادة والفهم؛ أو عدم وجود بنية تحتية تنظيمية أو حيز كاف داخل هياكل الإدارة؛ أو نقص التمويل.

تحديد أفضل الممارسات في التعامل مع جميع أنواع الأذى الذي يحدث في الرعاية الصحية وتعزيز تلك الممارسات في شتى أنحاء العالم.

ويرسي التعاون مع المرضى أساساً صلباً لتحسين نظام الرعاية الصحية. ويتنقل المرضى عبر نظام الرعاية الصحية بأكمله، ومن ثم فهم أكثر قدرة من مقدمي الرعاية على تكوين رأي شامل عنه عوض التركيز على جزء صغير منه. ويمثل المرضى والأسر المستخدمين النهائيين لنظام الرعاية الصحية. وغالباً ما يشكلون الجهة الوحيدة التي لديها رؤية كاملة عن نتائج رعايتهم. وتتطوي دائماً وجهة نظرهم بشأن كيفية جعل الرعاية أكثر مأمونية على قيمة كبيرة. ويمكن تسخير الاهتمام العام والشخصي الشديد بالصحة لجعل المرضى شركاء أكثر تواتراً في تحسين سلامة المرضى.

ويشكل إطار عمل منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس دعوة إلى إحداث تحول أساسي في طريقة تمويل الخدمات الصحية وإدارتها وتقديمها. وهو يدعم تقدم البلدان نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال التحول عن النظم الصحية المصممة حول الأمراض والمؤسسات الصحية إلى النظم الصحية المصممة للناس.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باعتماد خمس استراتيجيات متداخلة يتعين تنفيذها، وهي على النحو التالي:

- إشراك وتمكين الناس والمجتمعات المحلية؛
- تعزيز الحوكمة والمساءلة
- إعادة توجيه نموذج الرعاية
- تنسيق الخدمات داخل القطاعات وعبرها
- تهيئة بيئة مواتية

وقد قيل الكثير عن الحاجز العاطفي والفجوة القائمة حالياً في مشاعر التعاطف بين المرضى والعاملين الصحيين الذين يقدمون لهم الرعاية. وفي بعض الأحيان، ينظر إلى المشتكين على أنهم الأصوات الرئيسية المدافعة عن المرضى. وقد سلطت جائحة كوفيد-19 ضوءاً جديداً على ذلك من خلال الإعراب العام عن الامتنان لما يضطلع به العاملون الصحيون في جميع أنحاء العالم والقلق السائد إزاء الظروف التي يعمل فيها الكثيرون منهم. ويدل ذلك على الفرصة المتاحة لإقامة شراكات أقوى تستند إلى مشاعر التعاطف بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في المستقبل.

ويجب اعتبار مشاركة المرضى والأسر جزءاً لا يتجزأ من سلامة المرضى وأحد ركائز ممارسة الرعاية الصحية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمجها في كل هيكل تنظيمي وهيكل حوكمة للرعاية الصحية، ومن خلال إخضاعها للرقابة المجتمعية والوطنية، ومنحها، مثلها مثل غيرها، مقعداً على طاولة القيادة العالمية لسلامة المرضى ومنتديات التخطيط. وسيتيح ذلك لصوت

المرضى والأسر وخبرتهم من أن يكون لهما تأثير قوي ومفيد يتراوح من السياسات العالمية والوطنية إلى الممارسات السريرية والطبية ويتيح أيضاً رؤية جميع الاستراتيجيات من منظور المريض.

ولئن كان من الضروري تحديد المدافعين عن المرضى والمناصرين لهم لزيادة مشاركة المرضى والأسر، فمن المهم بنفس القدر تحديد قادة الرعاية الصحية وإعدادهم وتحفيزهم من خلال قيم تتماشى مع هذا المفهوم. وسيدافع هؤلاء القادة عن مشاركة المرضى في هياكل الحوكمة المتعلقة بهم، وفي أولوياتهم الاستراتيجية، وفي ميزانياتهم. ويتمثل واجبهم الأخلاقي في ضرورة دمج أدوار المرضى والمواطنين في عمل منظماتهم وتكريس ثقافة السلامة والاحترام التي تشجع على الاستماع الفعال إلى أصوات المرضى داخل منظماتهم. وينفذ ذلك في كلا الاتجاهين. وعادة ما تكون الثقافة الأكثر أماناً للمرضى أكثر أماناً للعاملين الصحيين.

والأهم من ذلك هو ضرورة تزويد المرضى بالمعلومات التي يحتاجونها لإدارة شؤون رعايتهم وتحمل مسؤولية سلامتهم إلى أقصى حد ممكن. وينبغي لمؤسسات الرعاية الصحية المدعومة من كيانات وطنية ودولية أن تلتزم بالسياسات الرامية إلى تعزيز الشفافية إزاء المرضى، بما في ذلك الموافقة المستنيرة تماماً، وتمكين المرضى من الوصول إلى السجلات الطبية، والإفصاح الكامل إذا لحق بالمرضى أذى ناجم عن الرعاية التي قدمتها لهم. وينبغي أن يكون المرضى قادرين على نقل شواغلهم إلى مستويات أعلى داخل مؤسسة الرعاية الصحية وينبغي تشجيعهم بنشاط على تقديم تقارير إلى نظم الإبلاغ عن سلامة المرضى. وينبغي أن تمنح هذه التقارير مكانة كاملة كبلاغات لحوادث وعدم تهميشها ضمن فئة منفصلة مثل "شكاوى" المرضى.

وتقف البلدان في نقاط متباعدة على مسار إشراك المرضى. وحتى البلدان التي قطعت شوطاً بعيداً في هذا الشأن، فإنها لم تظهر ميلاً إلى التركيز على سلامة المرضى. ويشكل التحول في التركيز على النظر إلى سلامة المرضى كحق أساسي من حقوق الإنسان، والذي ينبغي أن يحظى بالأولوية من خلال إشراك المرضى، مبدأ هاماً يمكن أن تستند إليه الاستراتيجيات. وتشمل الأنشطة التي قد تساعد في تعزيز مشاركة المرضى ما يلي: تعزيز برنامج منظمة الصحة العالمية المعنون المرضى الملتزمون بسلامة المرضى وإنشاء شبكات لسلامة المرضى تركز على سلامة المرضى في كل بلد؛ وإدراج مسألة إشراك المرضى والأسر في المبادئ والممارسات المتعلقة بسلامة المرضى من خلال المواثيق الوطنية لسلامة المرضى؛ وزيادة الوعي العام والتثقيف بشأن سلامة المرضى؛ وإسماع صوت المرضى باعتباره قوة لازمة لتحسين سلامة المرضى.

الهدف الاستراتيجي 4

إشراك وتمكين المرضى وأسرهم من تقديم المساعدة والدعم لتحقيق رعاية صحية أكثر مأمونية

الاستراتيجية 4-1:

إجراءات للحكومات

- وضع ميثاق أو مشروع قانون وطني ذي صفة قانونية بشأن حقوق سلامة المرضى، ليشمل مفاهيم مثل حقوق المرضى في السلامة والاحترام والاستقلالية والرعاية الموثوقة والمعلومات والشفافية؛ وتعزيز مفهوم الرعاية المأمونة والمحترمة كحق من حقوق الإنسان.
- إدماج إطار منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس لدى تصميم الخدمات الصحية المأمونة وتقديمها.
- إنشاء آليات رسمية لإشراك المرضى والأسر في آليات الحوكمة الوطنية، والأفرقة العاملة وفرق العمل واللجان التي تخطط وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين سلامة المرضى في البلد.
- إقامة تحالفات مع منظمات المرضى والمجتمع المدني القائمة بشأن سلامة المرضى.
- إدماج معايير إشراك المرضى والأسر في عمليات الاعتماد والتقييم.
- إدراج الأهداف المتعلقة بإشراك المرضى والأسر كمكونات رئيسية للخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأجل.

إشراك المرضى وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني في وضع سياسات وخطط واستراتيجيات وبرامج ومبادئ توجيهية تجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إشراك ممثلي المرضى أو الأسر الذين عانوا من أذى يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية في تصميم الاستراتيجيات وتحديد الإجراءات الرامية إلى الحد من احتمال تكرار ذلك.
- تعيين ممثلين للمرضى والأسر ليشكلوا جزءاً من مجالس المنظمة ولجانها.
- إعادة ترتيب عمليات الرعاية وإعادة توجيهها حيثما تقتضي الضرورة لجعل الخدمات تركز على المريض وتستند إلى المبدأ الأساسي المتمثل في "ما هو مهم للمرضى والأسر".
- إنشاء مجالس استشارية للمرضى والأسر تركز على سلامة المرضى.
- وضع إجراءات بشأن أحكام الميثاق أو مشروع القانون الوطني، بما في ذلك عدم التمييز، واستقلالية المريض، والموافقة المستنيرة، وصنع القرارات المشتركة، والاستجابة لحالات الطوارئ، والوصول إلى السجلات الطبية، والكشف الكامل عن الأحداث الضائرة.
- وضع معايير مؤسسية لإشراك المرضى والأسر؛ وتطوير ممارسة التحسين على أساس تجربة المرضى.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- إجراء بحوث لتحديد السلوكيات التي تشكل وتدعم إشراك المرضى والأسر - من جانب المرضى والأسر والأطباء والإداريين والمهنيين الصحيين الآخرين، ضمن سياقات الرعاية الصحية المختلفة.
- نشر ميثاق حقوق سلامة المرضى وتعزيز فكرة سلامة المرضى كحق من حقوق الإنسان.
- الدعوة إلى المشاركة الكاملة للمرضى والأسر والمجتمعات المحلية في جميع الخطط والبرامج المتعلقة بسلامة المرضى على المستويات العالمي والوطني والمحلي.
- تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الدول الأعضاء والشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر.
- المساعدة في إنشاء آليات رقابة مجتمعية لمرافق الرعاية الصحية المحلية وبرامج مساعدة المرضى على المستوى المحلي لفائدة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في تلقي الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- ضمان مشاركة المرضى والأسر والمدافعين عن سلامة المرضى والمناصرين لهم وأعضاء شبكة المرضى الملتزمين بسلامة المرضى ومنظمات المرضى والمجتمع المدني في أنشطة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى وضع سياسات واستراتيجيات وتوجيهات وأدوات مشتركة متعلقة بسلامة المرضى.
- وضع أطر عمل ومبادئ للمشاركة وأدوات تنفيذ لإشراك المرضى والأسر في مجال سلامة المرضى بحيث يمكن للبلدان والمؤسسات اعتمادها على مختلف المستويات.
- مناصرة الدول الأعضاء لوضع سياسات وإعداد أدوات بشأن إشراك المرضى والأسر، بما في ذلك تقديم توجيهات بشأن الموافقة المستنيرة.
- إشراك أعضاء شبكة "المرضى الملتزمون بسلامة المرضى" والمرضى والأسر الذين عانوا من أذى كان بالإمكان تجنبه، ومنظمات المرضى والمجتمع المدني في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى، وفي آليات الرصد والمساءلة المتعلقة بها.
- وضع ميثاق نموذجي لحقوق سلامة المرضى أو عرض الميثاق القائم؛ وتقديم الأساس المنطقي لمسألة سلامة المرضى باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان وتقديم توجيهات بشأن وضع الموثائق وتنفيذها.

إجراءات للحكومات

- إنشاء منصات وشبكات وفعاليات لجمع المدافعين عن سلامة المرضى والمناصرين لهم والمرضى ومنظمات المرضى لتبادل خبراتهم بشأن الأذى الذي يمكن تجنبه أو الرعاية غير المأمونة وأفضل الممارسات في مجال إشراك المرضى والأسر.
- إنشاء آلية وتعزيز المنصات لتبادل تجارب المرضى والأسر في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك إبلاغ المرضى عن النتائج والخبرات، والتي تسلط الضوء على المشاكل المتعلقة بسلامة المرضى وتشير إلى الحلول، من أجل تحسين سلامة المرضى.
- ضمان أن يفيد ما تعرض له المرضى والأسر من أذى في تصميم جميع المجالات البرنامجية المتعلقة بسلامة المرضى (على سبيل المثال، السياسات والتتبع والتدريب والبحوث والمعلومات).

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تكريس الثقافة الملائمة ووضع إطار تنظيمي بحيث تشكل المقابلات التي جرت مع المرضى والأسر الذين عانوا من أذى كان بالإمكان تجنبه والتجارب التي عاشوها وتحدثوا عنها جزءاً لا يتجزأ من جميع الأعمال المتعلقة بسلامة المرضى ضمن خدمات المنظمة.
- إدراج تجارب المرضى والأسر التي وردت على ألسنتهم كبند منتظم في جدول الأعمال في اجتماع مجلس الإدارة الرئيسي للمنظمة من أجل تمكين قادة الرعاية الصحية من الحصول على فكرة عميقة عن واقع تأثير الرعاية غير المأمونة.
- إنشاء آليات تعنى بالإبلاغ عن سلامة المرضى وتشجع المرضى والأسر على الإبلاغ، من خلال جمع ما يبلغ عنه المرضى من نتائج وتجارب بشأن الرعاية غير المأمونة وتجميعها وتحليلها، وإظهار الإجراءات المتعلقة بالتعلم والتحسين.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تنظيم حلقات عمل وندوات وفعاليات وطنية ومحلية لتبادل خبرات المرضى والأسر وتوقعاتهم، وخاصة من عانى منهم من أذى كان بالإمكان تجنبه.
- ضمان قيام الرابطات المهنية والجمعيات المتخصصة بدعوة المرضى وأفراد الأسر ممن لهم تجربة في مجال سلامة المرضى إلى مؤتمراتها السنوية وفعالياتها العلمية.

الاستراتيجية 2-4:

التعلم من تجارب المرضى وأسرهـم المعرّضين لرعاية غير مأمونة بهدف تحسين فهم طبيعة الأذى وتعزيز استنباط حلول أكثر فعالية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- مناصرة الدول الأعضاء لإنشاء آليات للتعليم من تجارب المرضى في مجال الرعاية المأمونة وغير المأمونة، بما في ذلك ما يبلغ عنه المرضى من تجارب ونتائج.
- إعداد أدوات وتوجيهات لجمع ما يبلغ عنه المرضى من نتائج وتجارب بشأن الرعاية غير المأمونة وتجميع ذلك وتحليله من أجل تحسين سلامة المرضى.
- وضع وتعهّد مجموعة عالمية من القصص التي يرويها المرضى والأسر الذين لديهم تجارب مع الرعاية المأمونة وغير المأمونة، والأذى الذي يمكن تجنبه والتغيير الفعال، ونشرها لزيادة الوعي بأهمية منح الأولوية لسلامة المرضى ضمن جهود تبذل على نطاق أوسع لتعزيز النظام الصحي.

إجراءات للحكومات

- دعم الشبكات الوطنية للمدافعين عن المرضى والمناصرين لهم وإتاحة سبل إنشائها، والتعاون مع برنامج المرضى الملتزمون بسلامة المرضى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
- إنشاء فريق من المدافعين عن سلامة المرضى والأسر وتدريب ودعم أفرادهم للتدخل كمتحدثين في المؤتمرات الوطنية والمحلية.
- تقديم نتائج الإبلاغ عن سلامة المرضى ونظام التعلم للمدافعين عن المرضى والمناصرين لهم.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إجراء استعراض واسع النطاق لتقييم مشاركة المرضى في تحسين السلامة في الرعاية الصحية داخل المنظمة.
- اتخاذ تدابير للتعاون بشكل كامل مع المرضى والأسر لتعزيز فرصهم للمساهمة في العمليات الرامية إلى تحسين سلامة المرضى.
- وضع استراتيجية لإشراك المدافعين عن سلامة المرضى والمناصرين لهم كمرتبين.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- استخدام الشبكات وأوجه التعاون لتحديد المدافعين عن المرضى والمناصرين لسلامة المرضى وتعيينهم وتدريبهم للعمل كممثلين للمرضى لدى الحكومة ومؤسسات الرعاية الصحية.
- إعداد ونشر مواد إعلامية لفائدة المرضى بشأن مختلف جوانب سلامة المرضى والمشاركة في حملات التوعية العامة.
- العمل مع الحكومة لدعم وضع برنامج للمرضى الملتزمين بسلامة المرضى على المستوى الوطني.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تعزيز برنامج المرضى الملتزمون بسلامة المرضى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وتوسيع نطاق الشبكة العالمية المعنونة "المرضى الملتزمون بسلامة المرضى".
- الدعوة إلى وضع برامج "المرضى الملتزمون بسلامة المرضى" وإنشاء منظمات للمرضى على المستويين الإقليمي والوطني وتقديم التوجيهات لدعم ذلك.
- إعداد موارد تثقيفية وتقنية، بما في ذلك برنامج التعلم الإلكتروني وتوجيهات وأدوات، لفائدة المدافعين عن سلامة المرضى والمناصرين لهم.
- دعم بناء قدرات المدافعين عن سلامة المرضى والمناصرين لهم على المستويات الإقليمية والوطني والمحلي.
- تيسير العلاقات بين منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن المرضى، والوكالات الحكومية.

الاستراتيجية 3-4:

بناء قدرات المدافعين عن المرضى والمناصرين لهم تحقيقاً لسلامة المرضى.

- وضع توجيهات وطنية بشأن الموافقة المستنيرة، وإمكانية حصول المرضى على سجلاتهم الطبية، وقدرة المرضى والأسر على نقل شواغلهم المتعلقة بالرعاية إلى مستويات أعلى إذا أحسوا بتدهور حالة المريض.
- وضع إطار توجيهي وإجراءات لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من أن يفصحوا للمرضى والأسر عن الأحداث الضائرة التي تسببت (أو كان يمكن أن تتسبب) في حدوث أذى غير مقصود.
- النظر في وضع تشريعات بشأن سياسات الإفصاح لإبلاغ المرضى والأسر حينما لا تكون التوجيهات فعالة.

إرساء مبدأ الانفتاح في جميع مراحل الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال الإفصاح عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى للمرضى وأسرهم.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- وضع سياسات مؤسسية بشأن الحصول على موافقة مستنيرة قوية، والوصول إلى سجلات المرضى الطبية، ونظم التصعيد في حالات الطوارئ والتي يمكن أن يحركها المرضى وأسرهم.
- وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات الإفصاح لإبلاغ المرضى والأسر بالحوادث المتعلقة بسلامة المرضى التي تسببت (أو كان يمكن أن تتسبب) في حدوث أذى غير مقصود.
- ضمان حصول المرضى والأسر والعاملين الصحيين على الدعم النفسي المستمر وغيره من أشكال الدعم في أعقاب وقوع حادث تعرضت فيه سلامة المرضى للخطر.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- التوعية بنظم الإبلاغ عن السلامة، والحق في الوصول إلى السجلات الطبية، والحق في إبداء الموافقة المستنيرة، والحق في الاستفادة من الاستجابة في حالات الطوارئ، بما في ذلك السبل الأخرى المتاحة للمرضى بشأن سلامتهم.
- توعية منظمات المجتمع المدني والمرضى والأسر، والسعي للحصول على الدعم الكامل من الهيئات المهنية وأعضائها لسياسات الإفصاح صراحة للمرضى وأفراد أسرهم عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى.
- تنظيم تدفق المعلومات من أصحاب المصلحة بشأن الخبرة العملية لسياسات الإفصاح العلني وغيرها من مبادرات الشفافية والاقتراحات الرامية إلى التحسين.
- توعية منظمات المجتمع المدني والمرضى والأسر بالغرض الإيجابي لسياسات الإفصاح العلني واستحقاقاتهم بموجب ذلك.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- جمع سياسات وإجراءات الإفصاح النموذجية وتجميعها ونشرها لإبلاغ المرضى وأسرهم بالحوادث المتعلقة بسلامة المرضى التي تسببت (أو كان يمكن أن تتسبب) في حدوث أذى غير مقصود.
- التوصية بسياسات بشأن الشفافية ومعلومات المرضى، والإفصاح الكامل، بما في ذلك تقديم مراجع عينات السياسات والمشورة فيما يتعلق بالتنفيذ.
- تشجيع الدول الأعضاء على وضع سياسات تعزز الشفافية، بما في ذلك سياسات الإفصاح العلني، في إطار السياسات الوطنية لسلامة المرضى، باعتبارها وسيلة لإظهار التزامها بثقافة إيجابية بشأن سلامة المرضى في نظمها الصحية.
- تقديم توجيهات بشأن أفضل الممارسات في تصميم سياسات وتشريعات الإفصاح العلني وتشغيلها.

الاستراتيجية 4-5:

توعية وتنقيف المرضى وأسرهم بغرض إشراكهم في الرعاية الذاتية وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات.

إجراءات للحكومات

- دمج الأنشطة لتعزيز التنقيف العام، بما في ذلك في المدارس والمجتمعات المحلية، والتوعية بأهمية سلامة المرضى في الخطة الوطنية لسلامة المرضى.
- إدراج إشراك المرضى والأسر في منهج التعليمي المتعلق بسلامة المرضى؛ ووضع منهج دراسي محدد للأطفال في سن الدراسة.
- وضع آليات لتوفير المعلومات والتعليم للمرضى وأسرهم من أجل تمكينهم من إقامة شراكة مع منظمات الرعاية الصحية ومع أصحاب المصلحة الآخرين.
- وضع ونشر إعلانات الخدمة العامة من خلال رسائل واضحة توضح مشاركة المرضى وتبين أسباب أهميتها.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- دمج مشاركة المرضى وأسرهم في مناهج مهن الرعاية الصحية؛ وتطوير كفاءات موحدة في مجال مشاركة المرضى وأسرهم.
- تنقيف المرضى وأسرهم بشأن صحتهم ورعايتهم الصحية، ودعم المرضى في إدارة شؤون صحتهم، وتدريب الأسر على تقديم الرعاية، لا سيما لدى تلبية احتياجات المرضى في بيئة الرعاية المنزلية.
- إعداد مواد إعلامية للمرضى بشأن الإجراءات السريرية، بما في ذلك المخاطر المتصلة بالسلامة، لتمكين المرضى من طرح الأسئلة على العاملين الصحيين.
- تنفيذ آليات الاتصال التي تساعد الأطباء السريريين على فهم وجهات نظر المرضى وشواغلهم.
- تحديد هيكل عمليات الرعاية لدعم تبادل المعلومات، وتخطيط الرعاية، والإدارة الذاتية، وصنع القرارات المشتركة؛ وتنفيذ الأدوات التي تركز على المريض والمتاحة للمرضى والأطباء لدعم عملية صنع القرارات المشتركة.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- زيادة استخدام التنقيف عن طريق الأقران لفائدة المرضى وأسرهم، ودعم المرضى في إدارة شؤون صحتهم، وتشجيعهم على الاضطلاع بدور نشط.
- إدراج مسألة مشاركة سلامة المرضى وأسرهم في المناهج التعليمية والدورات التدريبية.
- إعداد مواد إعلامية وتنقيفية بشأن سلامة المرضى ونشرها لفائدة المرضى.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- إعداد وتجميع ونشر المعلومات والمواد والأدوات التنقيفية لتعزيز محور الأهمية الصحية لدى المرضى وأسرهم، وإشراكهم في الرعاية الذاتية وصنع القرارات المشتركة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، وصحائف الوقائع، ومقاطع الفيديو، وإتاحة هذه الموارد بسهولة وتشجيع استخدامها.
- إدراج مشاركة المرضى والأسر في منهج منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى؛ ووضع منهج دراسي محدد للأطفال في سن الدراسة.
- الدعوة لإشراك المرضى وأسرهم كمرتبين في أنشطة التنقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى.

- منظمة الصحة العالمية. 2015. تقرير من الأمانة: إطار بشأن الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس. في: جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون، جنيف، 23-28 أيار/مايو 2015. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_39-ar.pdf?ua=1&ua=1).
منظمة الصحة العالمية. 2016. إشراك المرضى: سلسلة تقنية بشأن الرعاية أولية الأكثر مأمونية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/patient-engagement>، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).
- منظمة الصحة العالمية. 2017. إطار منظمة الصحة العالمية بشأن المشاركة المجتمعية من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة وقادرة على التكيف وتركز على الناس [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259280>، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).
- المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا. 2013. استكشاف مشاركة المرضى في الحد من مخاطر السلامة المتصلة بالرعاية الصحية [بالإنكليزية]. كوبنهاغن: مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/185779/e96814.pdf، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

Canadian Patient Safety Institute, Atlantic Health Quality and Patient Safety Collaborative, Health Quality Ontario, Patients for Patient Safety Canada. 2019. Engaging patients in patient safety: a Canadian guide. Edmonton: Canadian Patient Safety Institute (www.patientsafetyinstitute.ca/engagingpatients, accessed 16 July 2021).

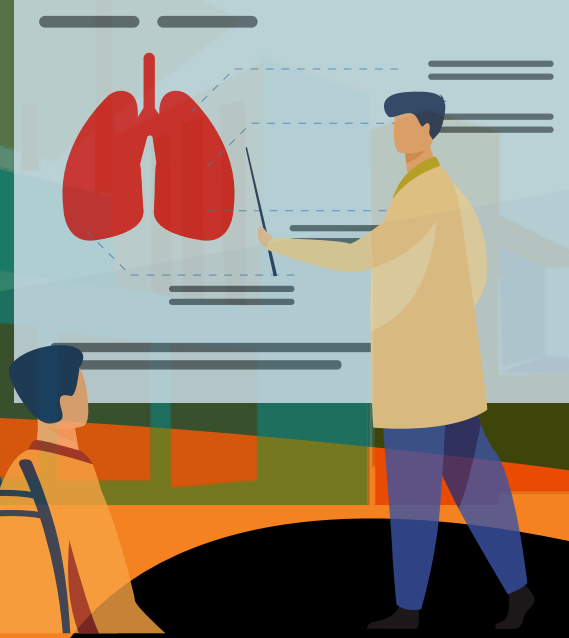
منظمة الصحة العالمية. 2006. التحالف العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المرضى: إعلان لندن [بالإنكليزية]. لندن: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/London_Declaration_EN.pdf?ua=1، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2013. المرضى الملتزمون بسلامة المرضى: شراكات من أجل رعاية صحية أكثر مأمونية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/PFPS_brochure_2013.pdf?ua=1، اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021).

الهدف الاستراتيجي 5-

تثقيف العاملين الصحيين، ومهاراتهم وسلامتهم

تحفيز العاملين الصحيين وتثقيفهم
وإكسابهم المهارات اللازمة وحمايتهم
للمساهمة في تصميم وتنفيذ نظم
لرعاية المأمونة



وفي الواقع، فإن من الضروري تقديم رعاية مأمونة وجيدة وتحقيق أفضل النتائج من التشخيص والعلاج والعمليات السريرية الأخرى المتعلقة بالرعاية. ومع ذلك، فالنهج القائم على سلسلة من الفترات الفردية من الرعاية غير كاف في هذا الشأن. ومن الضروري أن يكون هناك تقدير كامل لحجم المخاطر وطبيعتها لدى تقديم الرعاية، إلى جانب معرفة كيفية توجيه الممارسة نحو التقليل من هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن أو إزالتها. ويتطلب ذلك إدراك أن كل لقاء سريري فردي مدمج في نظام أوسع لتقديم الرعاية قد تؤثر على سلامة المريض في أي لحظة.

ومن الضروري أن يفهم جميع العاملين الصحيين والمديرين والقادة مسألة سلامة المرضى. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكونوا واضحين بشأن طبيعة المخاطر وأهميتها وكيفية حدوث الأذى، والمفاهيم الأساسية لعلم سلامة المرضى، والطرق التي تستخدم في التحقيق في أسباب الرعاية غير المأمونة وفهمها، والإجراءات اللازمة لضمان أن تكون الرعاية والعمليات الفردية التي تشكلها مأمونة قدر الإمكان.

ونشرت منظمة الصحة العالمية دليل مناهج سلامة المرضى لكليات الطب، ونشرت أيضاً طبعة متعددة التخصصات. وقد نشر كلاهما على نطاق واسع واعتمدا في بعض البلدان. ووضعت

على الرغم من التزام جميع العاملين الصحيين بالحفاظ على سلامة مرضاهم، فإن الأغلبية منهم تعتقد أنها تقي بهذا الالتزام من خلال ممارسة مهنتها في إطار مدونة الأخلاقيات المهنية، والتي هي مرادف لعضويتهم في مهنتهم. وسيذهب عدد أقل من الناس في تفكيرهم إلى ما هو أبعد من ذلك لدى تقديرهم بشكل كامل لنطاق المخاطر التي ينطوي عليها تقديم الرعاية الصحية وحجم الأذى الذي يمكن تجنبه، بما في ذلك الأذى الذي يمكن الوقاية منه ومعالجته، والذي ينشأ يومياً داخل كل نظام رعاية صحية في العالم.

وقد يبدو هذا النقص في الوعي بهذه المشكلة الهامة وفي فهمها لدى العديد من مقدمي الرعاية في نقطة الرعاية أمراً محيراً. ومن المؤكد أن هذا القصور لا يرجع إلى غياب أي تعاطف لدى مهنيي الرعاية الصحية. ويعزى ذلك إلى أن البرامج التقليدية للطلاب الجامعيين والدراسات العليا والتعليم المستمر تركز على الممارسات والمعايير القائمة على البَيِّنَات والموجهة نحو المرض أو الحالة السريرية. وكثيراً ما تكون جوانب النظم المتعلقة بمسائل السلامة مفقودة، ولا توفر البرامج أي تدريب بشأن العوامل البشرية.

وعلاوة على ذلك، يركز التدريب على المهارات غير التقنية تركيزاً شديداً على الاستماع إلى المريض والتواصل معه. وكل هذا مهم.

مجموعات رئيسية من مقدمي الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم مناهج تعليمية بشأن سلامة المرضى، بالإضافة إلى هيئات تعليمية تنظيمية ومهنية في بلدان مختلفة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كان تأثير هذه المبادرات على المناهج الدراسية القائمة محدوداً للغاية. ولا يكمن التحدي في وضع السياسات، بل يكمن في تنفيذها. وهناك العديد من الحواجز التي تحول دون ضمان أن تكون سلامة المرضى عنصراً رئيسياً في برامج التعليم والتدريب. وتشمل هذه الحواجز الافتقار إلى حيز مخصص للمناهج الدراسية، وعدم وجود تأييد من أصحاب المصلحة، ونقاط الضعف التي تعترى التنسيق والتخطيط التعليميين، ومحدودية الاهتمام من القيادة، وعدم وجود عدد كاف من كبار المناصرين الطبيين والتمريضيين.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من العوامل التي أعاقَت التنقيف بسلامة المرضى، وهي على النحو التالي:

• عدم إلمام المربين أو المدربين بتدريس موضوع سلامة المرضى كمجال جديد للمعرفة والتعلم؛

• إحجام المؤسسات الأكاديمية عن تدريس المعارف التي تندرج خارج التخصصات السريرية لطلاب الرعاية الصحية بسبب وجود مناهج دراسية كاملة؛

• عدم مواكبة التعليم لأوجه التقدم التكنولوجي وتطورات النظم في مجال الرعاية المأمونة.

وفي العديد من الأوساط المنخفضة الدخل، لا يوجد تدريب ملائم ضمن التخصص. وعلى سبيل المثال، قد يمارس أخصائيو العلاج الإشعاعي تخصصهم دون متابعة أي برنامج تدريبي رسمي معتمد. ويكون تدريبهم حينها في مجال سلامة المرضى أشد صعوبة دون أن يحصلوا على تدريب أساسي في مجال تخصصهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم العديد من مهنيي الرعاية الصحية طائفة واسعة من الخدمات السريرية في هذه الأوساط. وقد يجرون جراحة عامة، بل وعمليات قيصرية أيضاً. وقد يجرون تحقيقات ويقدمون الرعاية للأطفال المصابين بالحمى الشديدة والبالغين المصابين بالملاريا. وقد يعالجون طائفة واسعة من أمراض المناطق المدارية المهملة ويشخصون السرطان دون امتلاك تكنولوجيا متطورة. ومن الصعب على الأشخاص المثقلين بشدة بهذه الضغوط التي يفرضها عليهم تعدد المهام السريرية المعقدة اكتساب كفاءات إضافية تتعلق بسلامة المرضى ويمكنهم دمجها في ممارستهم. ويجب أن يراعي محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بسلامة المرضى في البلدان المنخفضة الدخل الظروف الخاصة والمتنوعة التي يواجهها مهنيو الرعاية الصحية الذين يعملون في هذه البيئات.

وتتباين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع المناهج الدراسية وتنفيذها في شتى أنحاء العالم. وفي العديد من البلدان، تقع المسؤولية العامة على عاتق وزارات التعليم وليس على عاتق وزارات الصحة. وقد تكون لدى هيئات الاعتماد أو الهيئات

التنظيمية المهنية، حيثما وجدت، مسؤولية شاملة عما يجري تدريسه ومتى يكون ذلك ومن المستفيد منه. ويجوز للهيئات المهنية وجمعيات العضوية مثل كليات الطب والتمريض وضع ورصد المعايير التعليمية التي توجه بعد ذلك تصميم المناهج الدراسية. ومن الواضح أن مقدمي الخدمات التعليمية أنفسهم، سواء في الجامعات أو في المدارس والمعاهد المستقلة، يمثلون أيضاً صانعي سياسات مهمين. وتشكل الاستفادة من هذه الهيئات المتباينة لتحقيق التغيير عنصراً ضرورياً للغاية وهو غير موجود في الوقت الحالي.

وباختصار، لم يستخدم تعليم وتدريب مهنيي الرعاية الصحية استخداماً كافياً ولم يقدّر حق قدره باعتباره أداة حيوية للتصدي للتحديات التي تعترض تحسين سلامة المرضى حسبما هو مفهوم اليوم.

وتقليدياً، لا يولي التعليم المتاح لمهنيي الرعاية الصحية سوى القليل من الانتباه لأهمية سلامة المرضى، حيث يسود ما يلي:

• انعدام الأخلاقيات المهنية التي تنص على ضرورة أن تمتد مسؤوليات الممارس إلى ما هو أبعد من رعاية المرضى الأفراد إلى ضمان أن تكون خدمتهم مأمونة في مجملها؛

• قلة فهم طبيعة المخاطر القائمة في مجال الرعاية الصحية وأهمية تعزيز النظم؛

• التركيز بقدر ضئيل على أهمية العمل الجماعي والتواصل في حماية المرضى من الأذى.

وبالنظر إلى أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية وغيرها من الصناعات العالية المخاطر، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى اعتماد نهج جذرية جديدة، بما في ذلك النهج المشتركة بين المهن والمتعددة التخصصات، إذا أريد للتعليم والتدريب أن يؤدي الدور الكامل الذي ينبغي أن يؤديه في تحسين سلامة المرضى.

وتشكل سلامة العاملين الصحيين وسلامة المرضى مجالين من مجالات الممارسة المترابطة بشكل لا ينفصم. ويمكن أن تؤدي المخاطر الصحية والمخاطر المتصلة بالسلامة والتي يتعرض لها العاملون الصحيون إلى مخاطر على المرضى وإلى إلحاق الأذى بهم وإلى نتائج ضائرة. وتشكل أوجه العنف والإرهاق والاضطرابات العضلية الهيكلية التي يتعرض لها العاملون الصحيون مشاكل صحية مهنية واسعة الانتشار في مرافق الرعاية الصحية المرهقة والتي يواجه العديد منها أيضاً نقصاً حاداً في أعداد العاملين الصحيين الأكفاء. ويتزايد تغيب العاملين الصحيين واستنزافهم، ولذين تتجم عنهما نتائج دون المستوى الأمثل في مجال الرعاية، بسبب سوء الصحة البدنية والنفسية للعاملين الصحيين. ويكون العاملون الصحيون السليمون بدنياً ونفسياً أقل عرضة لارتكاب الأخطاء، مما يساهم في توفير رعاية أكثر مأمونية. ولذلك، فسلامة العاملين الصحيين تؤثر تأثيراً مباشراً على سلامة المرضى.

الهدف الاستراتيجي 5

تحفيز العاملين الصحيين وتنقيفهم وإكسابهم المهارات اللازمة وحمايتهم للمساهمة في تصميم وتنفيذ نظم للرعاية المأمونة

الاستراتيجية 5-1:

إدراج سلامة المرضى في مناهج التعليم الجامعي والدراسات العليا في مجال الصحة وبرامج التطوير المهني المستمر، مع التركيز على التعلم المشترك بين المهنيين.

إجراءات للحكومات

- التوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة المسؤولين عن وضع معايير ومناهج دراسية لدمج سلامة المرضى في التعليم المهني والتطوير المهني المستمر.
- تقديم دليل مناهج سلامة المرضى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية على المستوى الوطني واعتماد نهج ومبادئ رئيسية في السياق المحلي.
- تنظيم دورات متخصصة بشأن سلامة المرضى من أجل التدريب أثناء الخدمة لمهنيي الرعاية الصحية من مختلف الفئات.
- إدراج مهارات الصحة والسلامة المتعلقة بالسلامة الشخصية في المناهج التعليمية وبرامج التدريب مع الأخذ بنهج التعلم المشترك بين المهن.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إدراج مسألة سلامة المرضى في برامج التعريف والتوجيه، فضلاً عن توفير التدريب أثناء العمل للموظفين.
- تقديم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة بشأن سلامة المرضى لجميع الموظفين المهنيين، مع التركيز على الاستراتيجيات القائمة على الأفرقة والمهام والتي تشمل التدريب بجانب السرير والمحاكاة، مع التصديق على الإنجاز المرضي.
- توفير تدريب متقدم بشأن كفاءات سلامة المرضى وتحسين الجودة لمن يضطلعون بأدوار إدارية وقيادية.
- تشجيع الموظفين على أخذ دورات تدريبية عبر الإنترنت وفي الموقع بشأن سلامة المرضى في إطار التطوير المهني المستمر.
- تصميم برامج تدريبية متخصصة للموظفين العاملين في المجالات العالية المخاطر مثل أقسام العناية المركزة والطوارئ.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- عقد منتدى لممثلي المؤسسات التعليمية والهيئات المهنية والجمعيات العلمية لتقديم المشورة للحكومة بشأن تصميم ومضمون وتقديم برامج التنقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى ودعم تنفيذها.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- استعراض وتوسيع دليل مناهج سلامة المرضى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية مع التركيز على نهج التعليم القائم على الكفاءة وبين المهنيين.
- تنظيم وتعزيز دورات وتدريبات بشأن سلامة المرضى، بما في ذلك في شكل التعلم الإلكتروني، من خلال منصات الوصول المفتوح مثل أكاديمية منظمة الصحة العالمية.
- إنشاء مستودع عالمي للموارد التعليمية والتدريبية بشأن سلامة المرضى ونشرها على مختلف المستويات.
- وضع برنامج "تدريب المدربين" لأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في التدريب في مجال سلامة المرضى.
- تيسير تصميم برامج التنقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى على المستويين الإقليمي والوطني، لجميع فئات العاملين الصحيين.

الاستراتيجية 2-5:

تحديد وترسيخ أوجه التعاون مع المراكز المتميزة المختصة بالتثقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى.

إجراءات للحكومات

- تعيين مركز أو أكثر يعنى بسلامة المرضى في البلد لتوفير القيادة التي تشرف على التثقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى.
- إنشاء شبكة وطنية لمراكز سلامة المرضى والوكالات المرتبطة بها لدعم التعليم والتدريب المهنيين في مجال سلامة المرضى.
- تعزيز استخدام أساليب المحاكاة في جميع مراحل التعليم والتدريب المهنيين في مجال سلامة المرضى، من خلال تحديد المراكز وتعيينها لقيادة عملية الإعداد والتنفيذ.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- العمل بشكل وثيق مع المراكز الوطنية لسلامة المرضى والشبكة حسب الاقتضاء، لتوفير فرص التدريب في مجال سلامة المرضى داخل المنظمة.
- تبادل التعليقات بشأن أفضل الممارسات والابتكارات داخل المنظمة مع المراكز الوطنية لسلامة المرضى والشبكة، حسب الاقتضاء، لضمان تبادل المعلومات وتطبيقها على نطاق أوسع.
- تحديد الموظفين لبرنامج "تدريب المدربين" في مجال سلامة المرضى وتيسير تدريبهم وتطوير كفاءاتهم.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الجمع بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على المستوى الفردي والتنظيمي لتقديم المشورة والدعم في مجالي التثقيف والتدريب المتعلقين بسلامة المرضى على جميع المستويات.
- الاتفاق على الأدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة، والتي تغطي مختلف الوظائف في مجالي التثقيف والتدريب، مثل وظيفة "تدريب المدرب"، وتصميم الدورات والمناهج الدراسية، وأساليب التدريس والتدريب، وتطوير تقنيات المحاكاة.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تحديد المركز المتميزة في مجالي التثقيف والتدريب المتعلقين بسلامة المرضى، وضمان التمثيل الجغرافي العادل، وإقامة علاقات تعاون إستراتيجية.
- إقامة شبكة عالمية من مراكز التميز المعنية بالتثقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات، ودعم تنمية القدرات على المستوى الوطني.
- تعزيز إنشاء شبكات إقليمية ووطنية لمراكز التميز المعنية بالتثقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى والدعوة لتمثيلها في الشبكة العالمية.

الاستراتيجية 3-5:

ضمان أن تكون الكفاءات الأساسية لسلامة المرضى جزءاً من المتطلبات التنظيمية للمهنيين الصحيين.

إجراءات للحكومات

- العمل مع هيئات الترخيص والتنظيم والاعتماد لضمان الروابط بين الأداء الفردي والتنظيمي مع إدخال تحسينات في مجال سلامة المرضى في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- تحديد الكفاءات الأساسية لسلامة المرضى لكل فئة من فئات الرعاية الصحية المهنية والدور السريري المتخصص لتحسين مجال سلامة المرضى. وينبغي أن تشمل الكفاءات المهارات غير التقنية مثل العمل الجماعي والاتصال.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إجراء تقييم دوري للكفاءات في مجال سلامة المرضى بين المهنيين الصحيين.
- دمج الكفاءات المتعلقة بسلامة المرضى في نطاق الممارسة والوصف الوظيفي لمهنيي الرعاية الصحية.
- ربط الكفاءات المتعلقة بسلامة المرضى بمعايير الخدمات.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- دعوة الخبراء والباحثين والمربين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستخدام الروتيني للكفاءات المتعلقة بسلامة المرضى والاتفاق عليها.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تحديد مجموعة من الكفاءات في مجال سلامة المرضى لمختلف المهنيين الصحيين ومواءمتها مع إطار الكفاءة العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية
- العمل مع الهيئات الوطنية المهنية للترخيص والاعتماد والتنظيم لاعتماد معيار عالمي مشترك للكفاءات في مجال سلامة المرضى وتقييمها.

إجراءات للحكومات

- ضمان ربط تقييمات أداء المهنيين الصحيين بالمشاركة في البرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة المرضى.
- استكشاف الآليات، مثل الحوافز وعلامات التقدير، التي تعترف بالإنجاز الاستثنائي الذي يحققه فرادى الموظفين في تحسين مجال سلامة المرضى.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إنشاء نظام تقييم داخلي لرصد الكفاءات من أجل فهم مصادر الأذى والمشاركة في إيجاد الحلول والتبَيّنات التي تدل على تحقيق مكاسب بشأن سلامة المرضى في الخدمات السريرية.
- دمج الجوانب القائمة على الأفرقة للأداء المتعلق بسلامة المرضى في التقييمات.
- الاعتراف بصفة خاصة بالجهات التي حددت مصادر الخطر ونفذت تدابير ناجحة لمكافحتها.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- جمع ما لدى جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من بيانات وخبرات لتقديم المشورة بشأن تحديد التميز في العمل المتعلق بسلامة المرضى والمنجز من جانب المهنيين والفرق الصحية الفردية وتقديم المشورة بشأن أفضل طرق وأدوات التقييم.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- وضع معيار عالمي وأدوات وطرق لتقييم أداء المهنيين الصحيين والفرق العاملة المشاركة في العمل المتعلق بسلامة المرضى.

إجراءات للحكومات

- دعم وتأييد ميثاق منظمة الصحة العالمية المعنون سلامة العاملين الصحيين: الأولوية لسلامة المرضى من خلال التوقيع عليه ودعم تنفيذه.
- وضع وتنفيذ برامج وطنية للصحة والسلامة المهنية للعاملين الصحيين بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوفير الموارد الكافية لاستدامة البرامج.
- اعتماد وتنفيذ السياسات والآليات ذات الصلة لمنع العنف في قطاع الصحة والقضاء عليه وفقاً للقوانين الوطنية.
- إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للعاملين الصحيين، بما في ذلك المشورة بشأن التوازن بين العمل والحياة وتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها من أجل مواجهة الإنهاك وتحسين الرفاه وتعزيز القدرة على الصمود.
- إقامة روابط بين البرامج المتعلقة بسلامة المرضى والصحة والسلامة والبيئة والصحة المهنية وبرامج تعزيز الموارد البشرية على المستويين الوطني ودون الوطني.

الاستراتيجية 4-5:

ربط الالتزام بسلامة المرضى بنظم التقييم للعاملين في الرعاية الصحية والمديرين.

الاستراتيجية 5-5:

تصميم أماكن وبيئات وممارسات الرعاية على نحو يهيئ ظروف عمل مأمونة لجميع العاملين.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- ضمان المدة المناسبة والعادلة لعمليات النشر وساعات العمل وفترات الراحة، بالإضافة إلى تقليل العبء الإداري على العاملين الصحيين للحيلولة دون التعرض للإجهاد وتعزيز الرفاه بوجه عام.
- ضمان تطعيم جميع العاملين الصحيين المعرضين للخطر ضد العدوى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
- توفير معدات ووحدات تشغيل وظيفية ومصممة هندسياً لتقليل الإصابات العضلية الهيكلية وحوادث السقوط.
- الحفاظ على مستويات معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها العاملون الصحيون لأغراض عبء العمل المتوقع مع تخزين الإمدادات المناسبة للاستجابة لحالات الطوارئ.
- تنفيذ تدابير لحماية العاملين الصحيين من العنف البدني والنفسي، بما في ذلك الممارسات غير الأخلاقية والتتمر والتحرش والتمييز.
- إجراء تقييم استباقي لجميع بيئات الرعاية لتحديد وتخفيف المخاطر والأخطار التي تهدد سلامة المرضى والعاملين الصحيين باستخدام الإطار الوطني كدليل.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- إشراك الهيئات المهنية وقطاع صناعة الأجهزة الطبية والخبراء والباحثين لتقديم المشورة للحكومة بشأن الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين الصحيين من جميع النواحي.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- الدعوة إلى وضع وتنفيذ أطر سياساتية وتنظيمية ملائمة لسلامة العاملين الصحيين وسلامة المرضى على المستويات الدولي والوطني ودون الوطني.
- تجميع ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة المرضى وسلامة العاملين الصحيين من أجل وضع أطر سياساتية وتشريعية وتنظيمية.
- وضع قواعد ومعايير وتوجيهات لتصميم أوساط وبيئات الرعاية لضمان سلامة العاملين الصحيين.
- تعزيز نظام عالمي للإبلاغ والقياس والتعلم بشأن الأحداث الضائرة المتصلة بالعمل فيما يتعلق بالعاملين الصحيين والمرضى.
- تعزيز أوجه التآزر والروابط بين عمل منظمة الصحة العالمية في مجالي الصحة المهنية وسلامة المرضى والوقاية من العدوى ومكافحتها والقوى العاملة الصحية.
- العمل مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعاملين الصحيين، مع التركيز بوجه خاص على المستجيبين في التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.

موارد تقنية:

منظمة الصحة العالمية. 2020. سلامة العاملين الصحيين: الأولوية لسلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/339287>). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2020. حماية صحة العاملين الصحيين وسلامتهم: قائمة مرجعية لمرافق الرعاية الصحية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/protection-of-health-workers-and-safety-of-health-workers>). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2020. غايات اليوم العالمي لسلامة المرضى للفترة 2020-2021 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/who-uhl-ihs-2020.8>). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. 2020. رعاية القائمين على الرعاية: البرامج الوطنية للصحة المهنية للعاملين الصحيين. موجز سياسات [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240011588>). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2009. دليل منهج منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى لكليات الطب [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/publications/i/item/9789241598316>). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2011. دليل منهج منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى: طبعة متعددة التخصصات جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9789241501958_eng.pdf?sequence=1). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

منظمة الصحة العالمية. 2020. الكفاءات الأساسية للمهنيين العاملين في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335821/9789240011656-eng.pdf?ua=1>). اطلع عليه في 26 آذار/مارس 2021.

الهدف الاستراتيجي 6-

المعلومات والبحوث وإدارة المخاطر

ضمان التدفق المستمر للمعلومات
والمعرفة تجاه التخفيف من المخاطر
وخفض مستويات الأذى الذي يمكن
تجنبه وتحسين سلامة الرعاية



تحليلها بشكل مركز. ويشكل العمل على توفير اتساع وعمق في المعلومات المطلوبة عنصراً حاسماً فيما تحقق من مكاسب.

ولا شك في أن هناك حاجة إلى نظم معلومات شاملة في البرامج ذات الأهداف الواضحة والنتائج الصحية المحسنة المستهدفة.

وعلى الرغم من انقضاء عقد أو أكثر من العمل في مجال سلامة المرضى، فإن قدرة وإمكانات البرامج العالمية والوطنية والمحلية في الحد من المخاطر، وتجنب الأذى، وتحسين سلامة الرعاية الصحية تظل مقيدة بشدة بسبب عدم وجود نظم معلومات عالية الجودة. وهناك العديد من مصادر البيانات المختلفة التي يمكن أن تلقي الضوء على مسألة سلامة المرضى. وتشمل هذه النظم ما يلي: نظم الإبلاغ عن الحوادث؛ والشكاوى؛ والدعاوى المتعلقة بسوء الممارسة؛ والنتائج التي يبلغ عنها المرضى؛ والوفيات التي يمكن تجنبها؛ وأدوات تحريك ملاحظة الحالات؛ وعمليات التحقق من الرعاية السريرية؛ والدراسات المتعلقة بعبء المرض؛ والاستقصاءات المتعلقة بالثقافة التنظيمية؛ وعمليات التحقق من الحوادث الخافرة. وباستثناء الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى، فقد وضعت معظم البيانات لأغراض أخرى. ولا يمكن النظر إليها إلا على أنها مؤشرات بديلة لسلامة المرضى، وإن كان بعضها مفيداً للغاية لدى العمل بهذه الطريقة.

يتطلب كل برنامج صحي توافر مصدر من مصادر البيانات الصحيحة والموثوقة لتوفير المعلومات ووضع تدابير لأنشطته الرئيسية، مثل تحديد الأولويات والمشاكل، ووضع المعايير المقارنة، وصياغة الإجراءات، ورصد الأداء والأثر. وهناك تقليد طويل في تطوير هذه البنية التحتية للمعلومات في المجالات الراسخة للصحة العامة، ولا سيما الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها. وفي بعض الحالات، يرجع تاريخ ذلك إلى أواخر القرن التاسع عشر. والواقع أنه لولا وجود بيانات ونظم معلومات جيدة، لكان التقدم المحرز في الحد من انتشار العدوى وعبئها العام في جميع أنحاء العالم ضئيلاً.

وعلى مدار القرن العشرين، اتُّبع نهج مماثل تجاه الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم والكثير من الأمراض الأخرى. وجمعت بيانات عن المخاطر والعوامل السببية والوفيات والنتائج الأخرى. وقد استمرت هذه التطورات حتى القرن الحادي والعشرين، وهي توفر مورداً أساسياً لدعم البرامج الوطنية والعالمية للأمراض غير السارية. وبالمثل، تعتمد البرامج ذات الأهمية الحيوية في منع الوفيات المبكرة والحد من الأمراض المتصلة بالفقر وتحسين صحة البالغين والأطفال في أجزاء كثيرة من العالم على البيانات الجيدة وعلى

وأن تحدد أنواع الحوادث التي يتعين الإبلاغ عنها. ويؤدي ذلك إلى تحويل نظم الإبلاغ إلى نظم لإدارة المخاطر والتحسين في الوقت الحقيقي (مثلاً هو الحال في قطاعات أخرى). وسوف تسفر المناقشة والتحقيق على المستوى المحلي عن رؤى عميقة بشأن المسببات المحتملة.

ومن أجل معالجة الصعوبات التي تحول دون تمكين الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى من تحقيق كامل إمكاناته، نشرت منظمة الصحة العالمية في عام 2020 وثيقة بعنوان نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: التقرير التقني والتوجيه.

التفكير بعمق أكبر في مسألة القياس

مهما كان نوع البيانات المستخدمة لتقييم مستوى سلامة المرضى في النظام الصحي أو المنظمة الصحية، فإنه ينبغي ربط العملية ربطاً وثيقاً بالتعلم والتحسين. وإذا لم تكن للقياس "حلقة تعلم"، فسيكون ذا قيمة محدودة للغاية.

ومن السهل قول ذلك، ولكن تفعيل هذا المبدأ سيكون أكثر صعوبة. وعلى سبيل المثال، تطرح الأسئلة أدناه بالصيغة التالية:

- كيف يمكن لتحليل بيانات الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى أن يؤدي إلى الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها في وحدة العناية المركزة في المستشفى؟
- كيف يحد من الأخطاء الخطيرة في صرف الأدوية في كل صيدلية في بلد من البلدان؟
- كيف يوقف جميع حالات الانتحار في وحدة الصحة النفسية؟
- كيف يحد من معدلات الإصابة المرتبطة بالرعاية الصحية في مستشفى ريفي لا يتوافر على مياه جارية عذبة؟
- كيف يقضي على انتقال الأمراض الفيروسية المنقولة بالدم عن طريق الإبر الملوثة في مخيم من مخيمات اللاجئين؟

وينبغي أن يستند القياس في مجال سلامة المرضى إلى البيانات التي تُجمع بانتظام لتشغيل نظم الرعاية الصحية وإدارتها. وينبغي أيضاً أن يكون مدعوماً بأنشطة الحوكمة التي تعزز بالفعل البنية التحتية للمعلومات بطريقة يمكن من خلالها قياس سلامة المرضى. ويدور معظم النقاش المتعلق ببيانات سلامة المرضى حول استخدامها التفاعلي. ويولي اهتمام أقل بكثير للمبادرات التي تستخدم هذه البيانات للتعلم التوعفي والاستباقي.

وهناك أيضاً فرص هامة لتعزيز قدرة نظم المعلومات، مثل ربط تقارير الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى بالسجلات الطبية ومصادر البيانات الأخرى ومجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بأكمله. ويمكن لهذه الابتكارات أن تقدم رؤى أعمق بكثير بشأن سبب الأذى، فضلاً عن سبل الحد منه.

ولذلك، فإن مصادر البيانات الحالية مجزأة ومتباينة ولا ترقى إلى مستوى نظام المعلومات الشامل والمتكامل واللائم في برامج سلامة المرضى. ومع ذلك، لا يستطيع سوى عدد قليل من قادة الرعاية الصحية أن يصفوا بثقة البيانات التي تستخدمها منظماتهم لرصد الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها. ولا يستطيع سوى القليل منهم فهم نقاط القوة التي لديهم والقيود المفروضة عليهم لفهم موضوع سلامة المرضى. ومن شأن تقييم ما يمكن أن يضيفه كل مصدر من مصادر البيانات فيما يتعلق بالمفاهيم الرئيسية الموضحة في التصنيف الدولي لسلامة المرضى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية أن يحدد المواضيع التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار.

وينبغي أن تمثل تجارب وآراء المرضى وأسرهم وسيلة العبور إلى جميع تدفقات المعلومات. ومع ذلك، فغالباً ما يكون ذلك مفقوداً أو لا يحظى بالأولوية لدى تصميم نظم المعلومات الصحية.

الدور الرئيسي لنظم الإبلاغ والتعلم

يتمثل أكبر استثمار للوقت والمال في إنشاء نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى وتشغيلها. وقد تراكمت لدى بعض هذه النظم قواعد بيانات كبيرة. وهناك الكثير مما يمكن تعلمه من الصناعات الأخرى العالية المخاطر التي يجري فيها الإبلاغ والتحقيق والاستجابة في ظل ثقافة "عدم إلقاء اللوم" ويركز فيها بشدة على التعلم. وإلى درجة ما، سيثبت حدوث انخفاض في المخاطر وتحسين السلامة بانتظام. وليس هذا هو الحال عموماً في مجال الرعاية الصحية، على الرغم من وجود بعض النماذج في شتى أنحاء العالم، ولا سيما على مستوى المرافق الصحية.

وقد أثار العديد من برامج سلامة المرضى توقعات عالية للغاية بشأن الأثر المحتمل لنظم الإبلاغ عن الحوادث والتعلم. ومن الناحية المثالية، ستوثق بسرعة جميع الحوادث التي وقعت خلال تقديم الخدمة الصحية والتي سببت الأذى أو كان يمكن أن تسببه وتستعرض ويحقق فيها بالكامل. وسيؤدي الإجراء الناتج عن ذلك إلى إعادة تصميم عمليات الرعاية والمنتجات والإجراءات والتغييرات في ممارسات الأفراد والأفرقة وأساليب عملهم. وعادة ما تسفر هذه الإجراءات عن خفض خطر إصابة المرضى في المستقبل بشكل قابل للقياس ومستدام. ويمكن إزالة بعض أنواع الأذى تماماً. ومع ذلك، يمكن لعدد قليل للغاية من النظم الصحية أو المرافق الصحية في العالم أن يقترب من هذا المستوى المثالي من الأداء لدى رصد حوادث الأذى التي يمكن تجنبها والتعلم منها.

وينبغي أن يهدف نظام الإبلاغ إلى توفير الموارد المناسبة وفقاً لعدد الحوادث المبلغ عنها. وإذا أبلغ عن عدد كبير للغاية من الأحداث من أجل معالجتها أو حتى النظر فيها بصورة واقعية، ناهيك عن استعراضها، فإن ذلك سيخيب آمال الجهات التي تقضي وقتاً لتقديم هذه التقارير بضمير حي. وفي حالة غياب هذه القدرة، يمكن للمنظمات أن تكون انتقائية بشأن المواضيع والمسائل

وفي نهاية عام 2019، وضعت ندوة سالزبورغ العالمية سلسلة من المبادئ لقياس سلامة المرضى، وهي تتمثل فيما يلي:

- الغرض من القياس هو جمع ونشر المعارف التي تؤدي إلى العمل والتحسين.
- يتطلب القياس الفعال المشاركة الكاملة للمرضى والأسر والمجتمعات المحلية داخل النظام الصحي وعبره.
- يجب أن يعزز قياس السلامة الإنصاف.
- يجب أن تسلط التدابير المختارة الضوء على نظرة متكاملة للنظام الصحي عبر سلسلة الرعاية المستمرة والمسار الكامل لتجربة المريض الصحية.
- ينبغي جمع البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي لتحديد الأذى ومنعه على نحو استباقي قدر الإمكان.
- يجب أن تتطور نظم القياس والبيانات والممارسات وتتكيف بصورة مستمرة.
- يجب الحد من عبء التدابير التي جمعت وحللت.
- يجب على أصحاب المصلحة أن يعززوا عن عمد ثقافة مأمونة وعادلة لتحسين قيمة القياس بشكل كامل.

وسيكون تفعيل هذه المبادئ أكثر صعوبة في بعض البلدان ومنظمات الرعاية الصحية وسياقات الرعاية مقارنة بغيرها. وستكون للبلدان مستويات مختلفة من الاستثمار في نظم المعلومات، وبالتالي ستعوق التكنولوجيا والخبرة المتاحة والموارد المخصصة قدرتها على القياس. وليس هناك شك في أن الالتزام ضروري لإحراز تقدم في القدرة التحليلية على تحسين سلامة المرضى. وينبغي لمنظمات الرعاية الصحية، لدى الاضطلاع بذلك، أن تطمح إلى الانتقال من مراحل العمل الوصفية أو التشخيصية البحتة - من معرفة ماذا حدث، ولماذا حدث ذلك؟ إلى القدرة على التنبؤ (ما الذي يحتمل أن يحدث؟) والقدرة الإلزامية (ما الذي يمكن تحقيقه).

وبمجرد تحديد المسائل ذات الأولوية المتعلقة بالتدخل، يمكن استخدام الأساليب الراسخة لتحسين الجودة من أجل تصميم وإعادة تصميم النظم والعمليات الرامية إلى تحسين سلامة المرضى. وبعد عقود من التطبيق الناجح لنماذج التغيير في مجال الرعاية الصحية، يمكن لهذه النماذج التي أعدت من خلال علم التحسين أن تدعم الأفرقة في توضيح هدف خطط المشاريع والهياكل لتطوير التغييرات واختبارها، ورصد تأثير التغييرات، والحفاظ على النجاح المحرز.

البحوث: توليد المعارف من خلال البحوث يقدم حلولاً للرعاية غير المأمونة

يتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للبحوث المتعلقة بسلامة المرضى في إنتاج معارف جديدة تُحسن قدرة نظم الرعاية الصحية،

وكذلك المنظمات الصحية والممارسين الذين يشكلونها، على الحد من الأذى المرتبط بالرعاية الصحية. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تكون نتائج الدراسات البحثية قابلة للتعميم على نظم الرعاية الصحية الأخرى في شتى أنحاء العالم.

وحينما اتضح حجم وطبيعة الأخطاء وأنواع الأذى في الرعاية الصحية لأول مرة في أواخر تسعينات القرن الماضي من خلال الدراسات التي تناولت حدوثها وانتشارها بين مرضى المستشفيات، أصبحت سلامة المرضى أولوية بالنسبة لواضعي السياسات الصحية في أجزاء كثيرة من العالم. وقد نشأ مجال نشط للبحوث رصدت معه موارد كبيرة لهذا التخصص.

وشكل البحث والتطوير أحد المجالات ذات الأولوية حينما أنشئ برنامج منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى لأول مرة. وقد اتخذت البحوث المتعلقة بسلامة المرضى عدداً من الاتجاهات منذ ذلك الحين. ويتضمن ذلك دراسات عن مدى وسببية الأذى الذي يلحق بالمرضى في مختلف التخصصات السريرية (على سبيل المثال - التخدير)، وفي مجالات العلاج (على سبيل المثال - الأدوية)، وفي المجموعات الديمغرافية (على سبيل المثال - حديثي الولادة)، والسياقات (على سبيل المثال - غرف العمليات). وبالإضافة إلى ذلك، أعيدت صياغة المشاكل ذات النمط الثابت للأذى ودرست من ناحية سلامة المرضى (على سبيل المثال، عدوى الرعاية الصحية)، وقُيِّمت الحلول التكنولوجية وغيرها من الحلول الرامية إلى الحد من المخاطر، وطُبقت مفاهيم السلامة والتدخلات المتعلقة بتخصصات أخرى على الطب والرعاية الصحية.

وعلى مدى العقد الماضي، بذلت محاولات لتجسيد هذه البحوث من أجل تحسين سلامة الرعاية والحد من عبء الأذى المرتفع نسبياً. ويتعين الاضطلاع بعمل منهجي جديد في بعض المجالات الرئيسية، بما في ذلك ما يلي: أ) زيادة استخدام النماذج النظرية والمنطقية؛ ب) الفهم الأوضح للعلاقة بين النقاط النهائية البديلة المستخدمة في العديد من الدراسات والأذى الفعلي؛ ج) تقديم وصف أفضل للتدخلات وآلياتها المقترحة للأثار والمسارات المؤدية إلى التنفيذ؛ د) تحسين تفسير النتائج المرجوة وغير المقصودة؛ هـ) تقديم وصف وقياس أكثر تفصيلاً للسياق ومعرفة كيفية تأثير ذلك على فعالية التدخل.

وينبغي عدم الاستخفاف بقيمة أوجه التقدم المنهجي السابقة. وينبغي للباحثين الانتباه إلى التحديات التي قد تنشأ لدى استخدام مفاهيم وتعريف غير تقليدية لتحسين جودة هذا العمل وقيمه. وسيكون من المفيد بوجه خاص استخدام المصطلحات المتفق عليها، ووضع مجموعة أساسية من مقاييس نتائج الدراسات المتعلقة بسلامة المرضى (وترتيبها الهرمي)، وإنتاج المزيد من قوائم الإبلاغ المرجعية عن سلامة المرضى. وستدعم المواءمة الدقيقة مع التصنيف الدولي لسلامة المرضى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية التقاسم العالمي للبيانات من أجل تحديد

الأولويات، وتبادل الحلول لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة فرص التعلم من الأحداث النادرة إلى أقصى حد.

وتكرس البحوث الرئيسية المطلوبة للعقد القادم للتجارب حتى يتسنى بشكل رسمي تقييم فعالية السياسات وإجراءات الصحة العامة أو التدخلات السريرية الرامية إلى تحسين سلامة المرضى. ولدى تطوير هذه التجارب، يجب على الباحثين التعلم من التقدم المحرز في مجالات سريرية أخرى (مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية) يكون فيها اختبار مجموعة من التدخلات على نطاق واسع ممكناً من خلال ما يسمى بالتجارب "الضخمة". ومع ذلك، فالموازاة لا تكون مباشرة. وقد انطوت العديد من هذه التجارب على تدخلات علاجية، في حين أن معظم التدخلات المتعلقة بسلامة المرضى هي على الأرجح تدخلات معقدة وغير دوائية. وسيطلب تطوير التجارب الطموح والتعاون بين الباحثين الذين نادراً ما كانوا يجرون في السابق بحثاً في مجال سلامة المرضى.

وهناك ندرة كبيرة في البحوث المتعلقة بحجم الأذى وطبيعته في الرعاية الأولية، وفي خدمات الصحة النفسية، وبين الفئات الضعيفة من المرضى (مثل كبار السن والمعوقين). وفي البلدان المتوسطة الدخل، توجد أيضاً حاجة ملحة إلى تحديد وتطوير واختبار حلول محلية فعالة وميسورة التكلفة واستراتيجيات الحد من المخاطر وتقييم أثر التدخلات المتعلقة بسلامة المرضى.

ويشكل الانتقال العالمي من النظم الورقية إلى البنى التحتية الرقمية عاملاً تمكينياً للبحوث والابتكارات المتعلقة بسلامة المرضى والتي تُجرى بطرق مجدية وفعالة من حيث التكلفة وتكون مناسبة التوقيت. ويمكن أن يصبح استنتاج بيانات السجلات الصحية الإلكترونية هو النهج الافتراضي للدراسات التي تتناول علم الأوبئة وعبء المرض الناجم عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى. ويمكن أيضاً استخدام هذه البنى التحتية لإعداد نماذج التنبؤ بالمخاطر التي تكون مدعومة بنهج تحليلية قائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الأذى الناجم عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى. وتتيح أيضاً التطورات التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات الصحية فرصاً لدعم تقديم الرعاية والإدارة الذاتية من خلال دعم القرار المهني أو القرار المحسوب

الذي يواجه المرضى على سبيل المثال. ولا يخلو الانتقال إلى البنى التحتية الرقمية من المخاطر، ويكون ذلك على سبيل المثال بدءاً من الخوارزميات المتحيزة وخروقات البيانات التي قد تشمل فئات سكانية بأكملها. وفي المستقبل القريب، ستقتصر هذه التكنولوجيات على النظم الصحية ذات الموارد الجيدة.

ويمكن للتكنولوجيا التي تركز على الإنسان أن تقدم مساهمة هائلة في مجال سلامة المرضى. وينبغي وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية التي تعالج المسائل الأساسية المتعلقة بالتوحيد القياسي، وقابلية التشغيل البيئي، والأداء، وتقييم الاحتياجات، والنمو على المستويات المحلي والوطني والدولي. وينبغي تطبيق نهج العوامل البشرية على تصميم المعايير والأجهزة والبرامج الحاسوبية وتقييمها. وفي المجال الطبي، تنطوي العلاجات المدروسة والفعالة على آثار جانبية. وعلى الرغم من أن نظم المعلومات الصحية قد عززت بالتأكيد سلامة المرضى، فلا بد من توشيقيطة لتحديد ومعالجة العقاقير غير المقصودة التي تترتب على السلامة بسبب التكنولوجيات الجديدة. وهذا الاعتبار هام للغاية للنظم الأكثر تقدماً وذات المستوى العالي من التشغيل الآلي والتي تؤدي بالتالي إلى فقدان التحكم البشري. وينبغي أن تتضمن الاستراتيجيات الرقمية الوطنية برامج تقييم تكوينية مستقلة. وينبغي أن تسعى التقييمات أيضاً إلى فهم عدم استخدام النظم الرقمية لأن ذلك ضروري لاعتماد التكنولوجيا وسلامة المرضى بقدر ما هو ضروري لفهم استخدامها.

ولا يبدأ تحويل البحوث إلى تحسينات في مجال سلامة المرضى ولا ينتهي بعرض نتائج البحوث على صانعي السياسات والممارسين. وينطوي تنفيذ الممارسات الجديدة في جميع الأحوال تقريباً على عملية تطوير تنظيمي، بما في ذلك جوانب السلوكيات والثقافة المهنية. ويجب أن يكون تركيز البرامج البحثية على المشاكل وتطبيق حلول نهائية أولوية من الأولويات إذا ما أريد للرعاية الصحية أن تكون أكثر مأمونية. ومن الضروري إقامة علاقات أوثق مع صانعي السياسات للانتقال من نموذج "الدفع" الحالي لترجمة المعارف إلى نموذج "الجذب" الذي يستجيب فيه الباحثون بشكل أسرع لاحتياجات صناع القرار.

الهدف الاستراتيجي 6

ضمان التدفق المستمر للمعلومات والمعرفة تجاه التخفيف من المخاطر وخفض مستويات الأذى الذي يمكن تجنبه وتحسين سلامة الرعاية

الاستراتيجية 6-1:

إنشاء أو تعزيز نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها.

إجراءات للحكومات

- إنشاء أو تعزيز الآليات القائمة في مجال الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها وإجراء تحسينات عند الضرورة على النظام (راجع منشور منظمة الصحة العالمية المعنون نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: التقرير التقني والتوجيه، 2020 ونموذج المعلومات الدنيا لمنظمة الصحة العالمية بشأن نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: دليل المستخدمين، 2016).
- إنشاء نظام إنذارات لنظام الرعاية الصحية لتوجيه الانتباه إلى الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى وتقديم المشورة بشأن هذه الحوادث التي تسلط الضوء على المخاطر التي تترتب على ذلك على صعيد النظام. والتركيز على ضرورة التحقيق في الحوادث، وتعلم الدروس، واتخاذ إجراءات واضحة للتخفيف من الأسباب الجذرية للحوادث المبلغ عنها.
- دعم وتيسير الوصول في الوقت المناسب إلى البيانات لأغراض البحث والتطوير.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تقييم وظيفة النظام الحالي للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى المتوافق مع منشور منظمة الصحة العالمية المعنون نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: التقرير والتوجيه التقنيين، 2020، ومنشور منظمة الصحة العالمية المعنون نموذج المعلومات الدنيا لنظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: دليل المستخدمين، 2016، وأي توجيهات وطنية.
- استخدام نظام الإبلاغ والتعلم لترتيب أولويات مجال سلامة المرضى التي تتعين معالجتها من خلال أنشطة التحسين.
- إنشاء نظام الإبلاغ والتعلم (إن لم يكن موجوداً) أو تعديله إلى نطاق مناسب وفقاً لقدرة المنظمة على رصد الحوادث وتحليلها والتحقيق فيها؛ ودعم زيادة القدرات.
- إشراك جميع موظفي المنظمة وإثارة حماسهم في السعي إلى الإبلاغ والتعلم من خلال التعقيب على ما تسنى تعلمه وعلى الإجراءات التي اتخذت لتحسين السلامة.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- التوعية بأهمية الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى ونشر الدروس المستفادة، بما في ذلك ضرورة تعزيز الثقافات التنظيمية الصحية والقيم المهنية لتحقيق ذلك.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- إعداد أدوات التنفيذ والتوجيهات اللازمة لدعم البلدان في إنشاء نظام للإبلاغ والتعلم.
- نشر توجيهات وأدوات الإبلاغ والتعلم الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
- إقامة روابط مع برامج الإبلاغ والتعلم في مجال السلامة في جميع الإدارات المعنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
- تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لإنشاء وتعزيز نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها.
- إنشاء شبكة عالمية من نظم الإبلاغ والتعلم الوطنية بهدف تبادل المعارف بشأن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى ومصادر الأذى الذي يمكن تجنبه والذي قد يؤثر على بلدان ومرفق صحية متعددة، بما في ذلك نشر الدروس المستفادة.

الاستراتيجية 2-6:

إنشاء نظام معلومات عن سلامة المرضى يستند إلى جميع مصادر البيانات المتعلقة بالمخاطر والأضرار الملازمة لتقديم الرعاية الصحية ودمجه مع نظم معلومات الإدارة الصحية القائمة.

إجراءات للحكومات

- تعزيز أوجه التآزر وقنوات تبادل البيانات بين مصادر المعلومات المتعلقة بسلامة المرضى من أجل اتخاذ الإجراءات والتدخل في الوقت المناسب، مثل نظم الإبلاغ عن الحوادث (بما في ذلك تقارير المرضى)، والدعاوى المتعلقة بسوء الممارسة، والتجارب التي يبلغ عنها المرضى ومقاييس النتائج، وعمليات التحقق من الرعاية السريرية، والاستقصاءات، وعمليات التحقق الأحداث الهامة، والدراسات المتعلقة بعبء الأذى، وبيانات ترصد سلامة لمنتجات الدم والأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات والإجراءات المتعلقة بزرع الأعضاء.
- نشر تقرير سنوي عن أداء مجال سلامة المرضى في النظام الصحي في البلد، بما في ذلك تواتر الأذى الذي يمكن تجنبه وطبيعته وعبئه في الرعاية الصحية، وتنفيذ خطط للحد منه.
- وضع مجموعة من المؤشرات لسلامة المرضى تتماشى مع الأهداف العالمية لسلامة المرضى. وينبغي أن تكون هذه المؤشرات قابلة للمقارنة بين مرافق الرعاية الصحية وكذلك على الصعيد الوطني.
- تصميم آليات مساءلة تسترشد بتقييم دقيق لضمان إحراز تقدم في الحد من الأذى وتحسين سلامة المرضى على صعيد نظام الرعاية الصحية.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تحديد مصادر الأذى الذي يمكن تجنبه وتتبعها على صعيد المنظمة وفي كل خدمة من الخدمات السريرية.
- تنفيذ مؤشرات سلامة المرضى واستخدامها لتتبع التقدم المحرز ورصد الاتجاهات.
- تقييم أثر برامج التحسين مع التركيز على استدامة الفوائد بمرور الوقت.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- دعوة أفرقة للخبراء وباحثين والمجتمع المدني إلى إعداد منهجيات ونظم بيانات أفضل لقياس سلامة الرعاية الصحية وطرق تقييم التقدم المحرز.
- تبادل برامج التعلم داخل الهيئات المهنية والجمعيات المتخصصة وبينها لإيجاد حلول فعالة لحالات الأذى والوفيات التي يمكن تجنبها في الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- رصد الممارسات المتعلقة بسلامة المرضى وتقييم التقدم المحرز والتحسين بمرور الوقت مقابل أحسن الممارسات وأفضل معايير الأداء.
- إدراج الغايات العالمية لسلامة المرضى الواردة في إطار نتائج برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية.
- إنشاء مستودع لمؤشرات سلامة المرضى.
- وضع ونشر أدوات تقييم سلامة المرضى لمختلف بيئات الرعاية الصحية.

الاستراتيجية 3-6:

إنشاء نظم لترصد سلامة المرضى وتحقيق التضامن بينها والارتقاء بها للتحقق من نطاق وأسباب الأضرار في مجال الرعاية الصحية.

إجراءات للحكومات

- إنشاء نظم لترصد سلامة المرضى لرصد ممارسات سلامة المرضى وتقييم التقدم المحرز والتحسين بمرور الوقت مقابل أحسن الممارسات وأفضل معايير الأداء.
- إنشاء آلية تحقيق مستقلة آلية في حالات الأذى الشديد والأحداث الخافرة التي تستدعي إجراء تحليل متعمق.
- إجراء استقصاءات أساسية ومتزامنة لتحديد عبء الأذى الناجم عن الرعاية غير المأمونة.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- المشاركة في نظام ترصد سلامة المرضى على المستويين الوطني والمحلي.
- إعداد تحليلات مرجعية لمقارنة أداء المنظمة في معالجة الأذى الذي يمكن تجنبه مقابل "أفضل الممارسات" القائمة في أماكن أخرى من البلد وفي العالم.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- دعم الحكومات ومرافق الرعاية الصحية في إنشاء نظم لترصد السلامة وتشغيلها.
- الجمع بين الخبرات والتجارب القائمة في علم التحسين في مجالات الرعاية الصحية الأخرى وخارج القطاع الصحي؛ وإتاحة هذه الموارد لتقديم المشورة بشأن البرامج الوطنية والمحلية.
- دعم إنشاء نظم وشبكات مختبرية على المستويات المحلي والوطني والعالمي للكشف بسرعة عن العدوى الناشئة والمخاطر المتصلة بسلامة المرضى والتصدي لها.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- إجراء دراسة أساسية بشأن العبء العالمي للأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية وتقييم التقدم المحرز والتحسين بمرور الوقت.
- دعم الدول الأعضاء في وضع نظم ترصد سلامة المرضى وتنفيذها وتعزيزها، بما في ذلك شبكات المختبرات لتحديد ما ينشأ من مخاطر متصلة بسلامة المرضى.
- وضع توجيهات معيارية بشأن منهجية التعلم والتحسين لخدمة سلامة المرضى.

إجراءات للحكومات

- تعيين وتحليل وتحديد أولويات المجالات التي يمكن أن تسفر فيها البحوث عن مكاسب كبيرة في المعرفة بشأن الأذى الذي يمكن تجنبه والحد منه في نظام الرعاية الصحية في البلد.
- ضمان وجود القدرات والمهارات والموارد الكافية لتلبية احتياجات البلد في مجال البحوث المتعلقة بسلامة المرضى.
- إدراج البينات البحثية الدولية، إن وجدت، في السياق المحلي، وفي السياسات وبرامج التنفيذ المتعلقة بسلامة المرضى. وتيسير تجسيدها في ممارسات نقاط الرعاية.
- إنشاء أو دمج تقييم المخاطر المتصلة بالسلامة في برامج تقييم التكنولوجيا الصحية القائمة للإجراءات الطبية والأدوية والأجهزة ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- توفير بيئة مواتية للبحوث التي تستكشف أسباب الأذى الذي يمكن تجنبه وإعداد تدخلات فعالة لتحسين سلامة المرضى.
- وضع تصميم لبرامج تحسين سلامة المرضى في كل خدمة سريرية على أساس الأولويات الواضحة من البيانات المحلية واستخدام البينات البحثية المتاحة بشأن الحلول الفعالة والممارسات الأكثر مأمونية لتحسين النظام.
- الشراكة مع الباحثين في مجال البحوث المتعلقة بالقياس والتحسين.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- دعوة هيئات تمويل البحوث والباحثين وشركاء البحوث للمضي قدماً بخطة البحوث المتعلقة بسلامة المرضى.
- ضمان أن يضطلع المرضى والأسر بدور هام في تحديد أولويات البحوث، وتصميم الدراسات، وإجراء الدراسات، والدعوة للتمويل، وحوكمة البحوث.

الاستراتيجية 4-6:

وضع وتمويل برامج بحثية نشطة بشأن سلامة المرضى، وخاصة الأبحاث الانتقالية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- الحفاظ على استراتيجية بحثية محدثة تحدد أولويات البحوث المتعلقة بسلامة المرضى في البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل.
- حشد الموارد لتعزيز ودعم البحوث المتعلقة بسلامة المرضى ودعمها.
- تعزيز البحوث المتعلقة بسلامة المرضى ودعمها في مجالات محددة مثل سلامة المرضى في الرعاية الأولية، والصحة النفسية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وشيخوخة السكان.
- تعزيز بناء القدرات البحثية في مجال سلامة المرضى وتقديم الدعم لهذه العملية، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

إجراءات للحكومات

- وضع استراتيجية وطنية والأدوات المطلوبة أو مواءمة الاستراتيجية القائمة ذات الصلة لتحقيق فوائد الرقمنة، بما في ذلك تسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لفائدة الجهود الرامية إلى تحسين سلامة الرعاية الصحية في البلد، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (راجع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020-2025).
- تعزيز رقمنة عمليات الرعاية الصحية ودعمها، مثل السجلات الطبية، والوصفات الإلكترونية، ونظم دعم القرار السريري، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإمكانية التشغيل المتبادل للحلول الرقمية.
- استثمار الموارد في إضفاء الطابع الرقمي على الخدمات الصحية للمستخدمين النهائيين، مثل الطبيب عن بعد والتشخيص عن بعد، فضلا عن خدمات الصحة العامة، مثل تعزيز الصحة وترصد الأمراض والوقاية منها.
- إنشاء آليات لتقييم وضمان سلامة حلول تكنولوجيا المعلوماتية الصحية قبل نشرها لأغراض الاستخدام في القطاع الصحي.
- الرصد المستمر لجوانب السلامة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية الصحية المستخدمة في العمليات السريرية والتشخيصية.
- توفير وسائل تنظيمية أو قانونية لاستخدام بيانات الرعاية الصحية لأغراض تحليلية في الوقت المناسب دون المساس بالخصوصية والسرية والمعايير الأخلاقي لرعاية فرادى المرضى والمواطنين.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تطبيق تقنيات جديدة ومثبتة لتحسين سلامة الرعاية على نطاق واسع.
- تقديم تعقيبات على المعلومات والخبرات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية في برنامج المنظمة المتعلق بسلامة المرضى إلى المسؤولين عن الاستراتيجية الوطنية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- تطوير التكنولوجيات الرقمية الحالية والجديدة لتعزيز تحديد وتحليل الخطر والأذى الذي يمكن تجنبه والحوادث المتعلقة بسلامة المرضى.
- ربط مبتكري التكنولوجيا بالنظام الصحي والقادة السريريين لاستكشاف طرق جديدة وأكثر فعالية لتحديد المخاطر والأذى المحتمل واكتشاف طرق جديدة لتحسين سلامة المرضى بمشاركة نشطة من قطاع الصناعة والقطاع الخاص.
- تعزيز الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الرقمية وتمويله من أجل تحسين سلامة المرضى.

الاستراتيجية 5-6:

وضع وتنفيذ حلول رقمية لتحسين سلامة الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- استكشاف النهج الرقمية لتحديد مصادر الخطر والأذى الذي يمكن تجنبه والإبلاغ عن هذه المصادر التي تمثل مشكلة في نظم الرعاية الصحية على مستوى العالم.
- تحديد وإدراج المجالات التي يمكن أن تساعد فيها التكنولوجيا الرقمية في جعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية.
- تطوير إطار للسياسات ومجالات الممارسة والاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية في استخدام التكنولوجيات الرقمية لتعزيز سلامة المرضى.
- وضع قاعدة بيانات وتصنيف لأوجه الأذى التي تلحق بالمرضى والتي يحتمل أن تكون مرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية.
- وضع أدوات وتطبيقات رقمية لمساعدة مقدمي الخدمات على توفير رعاية أكثر مأمونية.

موارد تقنية:

منظمة الصحة العالمية. 2020. الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية للفترة 2020-2025 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/gd4dhdad2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d_02adc66d-800b-4eb5-82d4-f0bc778a5a2c.pdf?sfvrsn=f112ede5_68/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2020. نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها: التقرير التقني والتوجيه [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240010338>، اطلع عليه في 27 آذار/مارس 2021).

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. 2016. دليل تقييم سلامة المرضى، الطبعة الثانية [بالإنكليزية]. القاهرة: منظمة الصحة العالمية (https://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18948.pdf?ua=1، اطلع عليه في 27 آذار/مارس 2021).

The Health Foundation. 2013. The measurement and monitoring of safety (<https://www.health.org.uk/publications/the-measurement-and-monitoring-of-safety>, accessed on 16 July 2021).

Institute for Healthcare Improvement and Salzburg Global Seminar. 2019. The Salzburg Statement on moving measurement into action: global principles for measuring patient safety. Salzburg (https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2019/Session_622/SalzburgGlobal_Statement_622_Patient_Safety_01.pdf, accessed 16 July 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2009. الإطار المفاهيمي للتصنيف الدولي لسلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_full_report.pdf، اطلع عليه في 27 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2012. بحث بشأن سلامة المرضى: دليل لتطوير البرامج التدريبية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75359/9789241503440_eng.pdf?sequence=1، اطلع عليه في 27 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2014. ورقة عمل: نسخة أولية من نموذج المعلومات الدنيا لسلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/patientsafety/implementation/IMPS_working-paper.pdf?ua=1، اطلع عليه في 27 آذار/مارس 2021).

الهدف الاستراتيجي 7-

التآزر والشراكة والتضامن

تطوير وتعزيز التآزر والتضامن
والشراكات على مستوى متعدد
القطاعات ومتعدد الجنسيات
لتحسين سلامة المرضى وجودة
الرعاية

والسلامة الجراحية؛ والوقاية من العدوى ومكافحتها؛ وإدارة الإنتان؛
وسلامة التشخيص؛ والنظافة الصحية والبنية التحتية البيئية؛
وسلامة الحقن؛ ومأمونية الدم؛ والأمان من الإشعاع.

وينبغي التعرف على القواسم المشتركة بين مجالات السلامة وحالات
تفرد كل مجال منها وتحديدها. وتسعى خطة العمل العالمية بشأن
سلامة المرضى للفترة 2021-2030 إلى الاضطلاع بذلك من
خلال دمج قدرات وموارد التفرد وتعزيزها من أجل الصالح العام.

ونظراً للدور المتكامل الذي تضطلع به الشراكات الرامية إلى تحسين
سلامة المرضى على مستوى العالم في جميع النظم الصحية، فإن
من الضروري العمل في تآزر مع مجموعة واسعة منها، مثل
الدول الأعضاء والهيئات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة
المتخصصة (على سبيل المثال، منظمة الأمم المتحدة للطفولة،
منظمة العمل الدولية)، وشركاء التنمية، والمنظمات المهنية،
ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات المرضى، والجامعات،
والخبراء، والمدافعين عن سلامة المرضى والمناصرين لهم.

وساعدت هذه الشراكات في تشكيل تصميم مبادرات منظمة الصحة
العالمية بشأن سلامة المرضى وفي تنفيذها. وعلى سبيل المثال،
جمع التحدي العالمي الأول لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة

على مدى العقدين الماضيين، كان نهج تحسين سلامة المرضى
يستند في المقام الأول إلى منظور النظام الصحي، مع وجود عدد
قليل من الآليات والهيكل المحددة لتجسيد عناصر نظام سلامة
المرضى في نقطة الرعاية التي تقع بجانب المريض.

وتميل عدة برامج وبرامج سريرية مرتبطة ومتعلقة بالسلامة إلى
العمل بمعزل عن غيرها في ظل قدر محدود من التفاعل أو
التكامل أو أي روابط مباشرة وإلزامية مع عناصر النظام المتعلقة
بسلامة المرضى. وتتجسد الصلة المفقودة في عدم إضفاء الطابع
المؤسسي على مجال سلامة المرضى في مختلف البرامج ومجالات
الممارسة. وتشكل سلامة المرضى جزءاً هاماً من عملية تقديم
الرعاية الصحية على جميع المستويات، بما في ذلك المجتمعات
المحلية وبيئات الرعاية الأولية والمستشفيات.

ومن الأهمية بمكان وضع آليات لدمج الاستراتيجيات المتعلقة
بسلامة المرضى وتنفيذها في جميع البرامج الصحية العالمية التقنية
وبرامج الرأسية لمكافحة الأمراض ومجالات الخطر. وسيترتب
على ذلك تأثير محتمل في الحد من الأذى الذي يمكن تجنبه وفي
التخفيف من خطر حدوث هذا الأذى المتعلق بإجراءات الرعاية
الصحية والمنتجات والأجهزة المتصلة بها. وتشمل المجالات
الرئيسية في نطاق العمل، في جملة أمور أخرى، سلامة الأدوية؛

بسلامة المرضى والتي تشمل عدة أنواع من أصحاب المصلحة في تحسين الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس وعلى المضي قدماً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وينشط العديد من أصحاب المصلحة في مجال سلامة المرضى، وهناك ثروة من الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الشأن.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أنشأت منظمة الصحة العالمية شبكة عالمية معنية بسلامة المرضى لربط الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة من الوكالات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بسلامة المرضى والجودة؛ ووزارات الصحة؛ وجهات الاتصال الوطنية والإقليمية والمناطقية من البلدان في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الست؛ وجهات الاتصال القطرية والإقليمية والعالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بسلامة المرضى وجودة الرعاية؛ والهيئات المهنية الدولية؛ وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الشبكة في تشجيع التزام القيادة؛ وجمع البيانات من مجموعة متنوعة من وجهات النظر، وإثراء السياسات والممارسات المستقبلية؛ وتعزيز نقل المعارف والقدرات التقنية عبر الحدود؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على مسألة سلامة المرضى لأغراض الاستدامة؛ وتشجيع تبادل أفضل الممارسات وتطبيقها.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في مجال سلامة المرضى في توفير القيادة العالمية وتسخير المعارف والخبرات والابتكارات لتحسين سلامة المرضى في بيئات الرعاية الصحية. ويوفر الدور التنظيمي الفريد الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية على الصعيد العالمي وسيلة لتحسين سلامة المرضى وإدارة المخاطر في مجال الرعاية الصحية من خلال التعاون والمشاركة والعمل المنسق على الصعيد الدولي بين الدول الأعضاء والمؤسسات والخبراء التقنيين والمرضى ومنظمات المجتمع المدني والصناعة ومنظمات المرضى، فضلاً عن شركاء التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين.

المرضى: الرعاية النظيفة هي الرعاية الأكثر مأمونية لجّل خبراء العالم في مجال الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومكافحتها. وقد ساهموا في وضع أول مجموعة من المبادئ التوجيهية القائمة على البيانات بشأن نظافة اليدين والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ التحدي. وساعد تحالف من الدول الأعضاء والرابطات المهنية والمراكز الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المرضى في إعطاء دفع لبرنامج اعتمدت أهدافه الأساسية لتغطي 90٪ من سكان العالم.

وتشجع منظمة الصحة العالمية أصحاب المصلحة على وضع مبادرات تعاونية لتحسين سلامة النظم الصحية ودعمها على الصعيد العالمي، ولا سيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويمكن أن تساعد مبادرات مثل المبادرة التعاونية العالمية بشأن سلامة المرضى في الحد من خطر الأذى الذي يمكن تجنبه وتحسين سلامة نظم الرعاية الصحية الوطنية، وكذلك على مستوى المرافق.

ولتوسيع نطاق الممارسات الجيدة المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها على جميع المستويات، سيكون من المهم إقامة شراكات وإنشاء شبكات في جميع أنحاء العالم. وينبغي أن تستند جميع المبادرات والشراكات التعاونية إلى الاحترام والثقة المتبادلين، والتواصل الواضح، والرؤية المشتركة للنتائج المرجوة. وينبغي أن تكون جميع الشراكات في مجال سلامة المرضى متعددة التخصصات ومتعددة القطاعات من حيث تكوينها، مع وجود تنسيق قوي ومتناسك، وتخطيط مشترك، وإنتاج مشترك فيما بينها كأساس للنجاح.

ومن الأهمية بمكان أن تكون هناك شبكات تحفز الحوار، وتتقاسم استراتيجيات قابلة للتكيف بشأن التدخلات المنخفضة التكلفة، وتعزز التعلم المستمر والدروس الرئيسية المستفادة التي يمكن أن تتجذّر أيضاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أو الدول الهشة. ويمكن أن تساعد الشبكات المتعددة التخصصات المعنية

الهدف الاستراتيجي 7

تطوير وتعزيز التآزر والتضامن والشراكات على مستوى متعدد القطاعات ومتعدد الجنسيات لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية

الاستراتيجية 1-7:	إجراءات للحكومات
إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين يمكنهم تحقيق تأثير إيجابي على سلامة المرضى.	- إجراء تحليل لأصحاب المصلحة على المستويين الوطني ودون الوطني، بما في ذلك الأفراد والمنظمات، والذين يمثلون القطاعين العام والخاص، مع إمكانية إشراكهم في العمل المتعلق بسلامة المرضى. - تحديد أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة في تعزيز سلامة المرضى أو النهوض بها داخل النظام الصحي للبلد. - إنشاء آليات تنسيق واضحة وشاملة لإشراك أصحاب المصلحة في العمل المتعلق بسلامة المرضى.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- تحديد أصحاب المصلحة للسكان الذين تقدم لهم الخدمات، بما في ذلك المرضى والأسر وقادة المجتمعات المحلية، والفروع المحلية للمنظمات المهنية، ومقدمي التدريب، وإشراكهم في برامج المنظمة ومبادراتها المتعلقة بسلامة المرضى.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- الحد من العمل المنعزل وتعزيز الحركة الموحدة حول سلامة المرضى من خلال شبكات المنظمات المهنية التي تمثل مختلف قطاعات الرعاية الصحية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين، على المستويات العالمي والإقليمي والوطني، ممن لهم أدوار ومسؤوليات في مجال سلامة المرضى، فضلاً عن أصحاب المصلحة الذين لديهم القدرة على المساهمة والتأثير الإيجابي.
- توفير التأييد الرفيع المستوى والقيادة الاستراتيجية والتوجيهات لجميع أصحاب المصلحة من أجل إعطاء الأولوية لمجال سلامة المرضى في التخطيط الاستراتيجي.
- إنشاء شبكات من الخبراء والممثلين، مثل منظمات المجتمع المدني، ومنظمات المرضى، والمنظمات المهنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والقطاع الخاص، والصناعة.

إجراءات للحكومات

- وضع سرد واضح يعكس بوضوح غايات خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى ومبادئها وأهدافها ويتماشى مع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية بشأن سلامة المرضى في سياق الرعاية الصحية الأوسع للبلد.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- مضاهاة غايات خطة العمل العالمية وأهدافها مع الخطط المؤسسية ذات الصلة، في السياق المحلي، وإشراك جميع الموظفين والمرضى والأسر في عمليات التنفيذ.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- وضع سرد واضح ومقنع داخل مجتمع أصحاب المصلحة المعنيين بسلامة المرضى بحيث يشرح خطة العمل العالمية لجميع فئات الجمهور المعنية ويدافع عن تنفيذها.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- رصد تنفيذ خطة العمل العالمية، بما في ذلك تحديد العوائق الرئيسية واقتراح الحلول.
- توسيع خبرات المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة غير الحكومية وتنسيقها في إطار العلاقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية لضمان إدراج مسألة سلامة المرضى في خطط عملها وتسريع تنفيذ خطة العمل العالمية.

إجراءات للحكومات

- إنشاء شبكات وطنية ودون وطنية معنية بسلامة المرضى لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة المرضى ونشرها وضمان التعلم المتبادل للحد من الأذى الذي يلحق بالمرضى.
- دعوة الشركاء وأصحاب المصلحة إلى عقد اجتماعات استشارية لوضع آليات مستدامة لتنفيذ خطة العمل العالمية والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بسلامة المرضى.
- إشراك الشركاء والمبتكرين من القطاعات غير الصحية لتعزيز الإبداع في إيجاد حلول جديدة للحد من أشكال الأذى والوفيات التي يمكن تجنبها في الرعاية الصحية، بما في ذلك الصناعة والقطاع الخاص.

الاستراتيجية 2-7:

تعزيز فهم موحد والتزام مشترك بين جميع أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى بنجاح.

الاستراتيجية 3:

إنشاء شبكات وعقد اجتماعات استشارية لتعزيز التعاون والشراكات في مجال سلامة المرضى.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- إنشاء "أكاديمية" داخلية لتدريب الأفراد داخل المنظمة على المشاركة الاستباقية في تعزيز الرعاية المأمونة داخل المنظمة وتقديمها.
- المشاركة في الشبكات المعنية بسلامة المرضى لتبادل الخبرات والموارد وتحسين الممارسات المتعلقة بسلامة المرضى في الرعاية السريرية اليومية.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- المشاركة في المبادرات والاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية والمحلية المتعلقة بتنفيذ خطة العمل العالمية.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- تعزيز الشبكة العالمية المعنية بسلامة المرضى وتوسيع المجموعات الفرعية المعنية بمجالات محددة لسلامة المرضى.
- توسيع نطاق الشبكات المواضيعية والإقليمية المعنية بسلامة المرضى وتعزيزها.
- الدعوة إلى إنشاء شبكات وطنية ودون وطنية معنية بسلامة المرضى لإشراك جميع الشركاء في العمل المتعلق بسلامة المرضى.
- عقد مشاورات عالمية وإقليمية ووطنية للعمل المشترك بشأن سلامة المرضى والملكية الجماعية.

إجراءات للحكومات

- وضع نماذج تعاونية مبتكرة متعددة الحكومات ومشاركة بين الحكومات مع اتخاذ إجراءات ذات أولوية استراتيجية بشأن سلامة المرضى والمشاركة في المبادرات التعاونية الدولية بشأن سلامة المرضى.
- النظر في المشاركة في مؤتمرات القمة الوزارية العالمية المعقودة سنوياً بشأن سلامة المرضى.
- تبادل أفضل الممارسات ونشرها وتشجيع التعلم على أساس متبادل للحد من الأذى الذي يلحق المرضى، وذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي.
- تشجيع قادة إدارات الرعاية السريرية والصحية على البحث عن أمثلة لأفضل الممارسات المتعلقة بسلامة المرضى في البلدان الأخرى واعتماد النهج المتبعة في النظام الصحي الوطني.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- المشاركة في المبادرات التعاونية الوطنية والمشاركة بين البلدان للبحث عن أفضل الممارسات وأوجه الأداء في مجال سلامة المرضى ودمجها في تصميم الخدمات والبرامج داخل المنظمة.
- تحديد الفرص المتاحة للمبادرات التعاونية المشتركة بين المنظمات ووضع مخططات للسماح بتبادل موظفي المنظمة عبر مختلف النظم والسياقات.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- استخدام الشبكات والمبادرات الدولية القائمة بين المنظمات المهنية والجمعيات الطبية والمجموعات البحثية وجمعيات المرضى في مختلف البلدان لإعطاء الأولوية بشكل استراتيجي لمجال سلامة المرضى والتعبير عن التضامن لدعم غايات خطة العمل العالمية ومبادئها وأهدافها.

الاستراتيجية 4-7:

النهوض بإطلاق مبادرات شاملة لعدة قطاعات وفيما بين المناطق الجغرافية لتعزيز العمل بشأن سلامة المرضى.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- حشد أوسع قدر ممكن من الالتزام السياسي والتضامن الدولي من أجل سلامة المرضى، بما في ذلك من خلال الاستمرار في تعزيز مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السنوية بشأن سلامة المرضى.
- إنشاء آليات تعاونية رسمية ذات أهداف مشتركة بشأن سلامة المرضى، مثل المبادرة الأفريقية من أجل سلامة المرضى، والمبادرة التعاونية العالمية لسلامة المرضى، وتوسيع التعاون مع البلدان ضمن هذه الآليات.
- تعزيز المبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل لضمان المواءمة والتآزر في العمل المتعلق بسلامة المرضى بين الدول الأعضاء وداخل المجموعات الخاصة، مثل الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
- الدعوة إلى منح الأولوية لمسألة سلامة المرضى في الخطط الاستراتيجية للآليات والمبادرات التعاونية، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030، لضمان اتخاذ إجراءات آنية وضمان الاستدامة.
- تعزيز المبادرات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى ودعمها، بما في ذلك الاحتفال باليوم العالمي بشأن سلامة المرضى سنوياً.

إجراءات للحكومات

- استعراض مدى ونطاق جميع البرامج الصحية التقنية داخل البلد وتحديد الحاجة إلى مواءمتها مع الإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى والفائدة المرجوة منها.
- إدماج الأهداف والإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى ضمن البرامج التقنية، بما يتماشى مع السياق المحلي.

إجراءات لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها

- ضمان إدراج مسألة سلامة المرضى في جميع البرامج الصحية التي تكون المنظمة مسؤولة عنها، ولا سيما تلك التي درجت على عدم الاعتراف بشكل صريح بأن الأذى الذي يمكن تجنبه يمثل مشكلة من المشاكل.

إجراءات لأصحاب المصلحة

- إبراز مكانة سلامة المرضى في البرامج التقنية الصحية العالمية وبرامج التعاون الصحي الدولي (بما في ذلك الحالات التي لم يعترف فيها من قبل بأنها تشكل مجاًلاً مثيراً للقلق).
- تعزيز منح الأولوية الاستراتيجية لمسألة سلامة المرضى في النقاش الذي يدور مع الجهات المانحة وتعبئة الموارد للعمل المشترك بشأن سلامة المرضى.

إجراءات لأمانة منظمة الصحة العالمية

- وضع رؤية واضحة بشأن مصادر ومستويات الأذى الذي يمكن تجنبه في الخدمات المقدمة من خلال البرامج الصحية الأخرى وتحديد أوجه التآزر ونطاق العمل التعاوني، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية.
- تعزيز التعاون الاستراتيجي وإقامة روابط مع البرامج المتعلقة بالسلامة، مثل سلامة الحقن، والسلامة الإشعاعية، والوقاية من الإشعاع، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وسلامة الدم، وسلامة التحصين، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ والبرامج السريرية، مثل صحة الأم، والأمراض غير السارية، والأمراض السارية؛ وبرامج النظم الصحية الأوسع نطاقاً، مثل القوى العاملة الصحية، والمعلومات والبحوث، وجودة الرعاية لضمان اتساق التدخلات وفعاليتها.
- ضمان وضع استراتيجيات مشتركة لحشد الموارد على جميع المستويات لاتخاذ إجراءات بشأن سلامة المرضى في جميع البرامج التقنية.

الاستراتيجية 5-7:

العمل عن كثب مع البرامج التقنية لضمان المواءمة في مجال العمل المتعلق بسلامة المرضى.

منظمة الصحة العالمية. 2018. التصدي معاً لمقاومة مضادات الميكروبات. ورقة عمل 1-0: التنسيق المتعدد القطاعات [بالإنكليزية].
جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/Tackling-AMR-multisectoral-coordination-june2018.pdf?ua=1).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2019. السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجودة: خلاصة الأدوات والموارد [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/9789241516549).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2020. توفير خدمات صحية جيدة للجميع، من خلال تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: دروس من ثلاثة بلدان أفريقية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/9789240009493).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2020. إطار عمل منظمة الصحة العالمية لتعزيز الإنتاجية الشاملة لمنتجات الدم الآمنة والفعالة والمضمونة الجودة 2020-2023 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/action-framework-to-advance-uas-bloodprods-978-92-4-000038-4).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2021. المبادرة التعاونية العالمية بشأن سلامة المرضى [موقع شبكي] [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/initiatives/global-patient-safety-collaborative).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2021. شبكات وشراكات [موقع شبكي] [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety-networks-and-partnerships).
2021).

Godschalk B, Härtel I, Sbrzesny R, Grundmann A, Kalicinski M, editors. 2017. Best practices in patient safety: 2nd Global Ministerial Summit on Patient Safety. Berlin: Federal Ministry of Health (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/P/Patientensicherheit/Best-Practice_Patient_Safety_Web_plusWHO.pdf, accessed 28 March 2021).

منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 2020. دمج أصحاب المصلحة والمشاركة المجتمعية في مبادرات جودة الرعاية لصحة الأم والوليد والطفل. جنيف: اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/9789240006317).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2011. مذكورة: وضع نظام وطني للدم [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/aide-m%C3%A9moire-developing-a-national-blood-system).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2012. الشراكات الأفريقية من أجل سلامة المرضى: تحسين سلامة المرضى: مجموعة إعداد الشراكات: مورد لجميع الشراكات الصحية الملتزمة بتعزيز سلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-PSP-2012.13).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2014. نظم الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية والتعلم منها: دور مراكز اليقظة الدوائية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/9789241507943).
2021).

منظمة الصحة العالمية. 2016. الإبلاغ عن مخاطر الإشعاع في تصوير الأطفال [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/publications/i/item/978924151034).
2021).

6- التنفيذ

1.6 خيارات سياساتية لتنفيذ خطة العمل العالمية

ويمكن أن يبدأ تنفيذ التدخلات السياساتية والمبادرات الاستراتيجية على المستوى دون الوطني أو المؤسسي لإبراز نماذج الفعالية وبناء الزخم نحو اعتماد أوسع على الصعيد الوطني. وعوضاً عن ذلك، يمكن أن يبدأ التنفيذ من المستوى الوطني ويتبع نهجاً تراكمياً يشمل تدريجياً المستويات دون الوطنية والمزيد من مؤسسات الرعاية الصحية. ومع ذلك، فمن المهم ضمان تنفيذ خطة العمل العالمية بطريقة شاملة، مع مجموعة متوازنة من التدخلات السياساتية التمهيدية والتدخلات المتعلقة بتحسين المراحل النهائية.

ويمكن أن تشكل التدخلات التمهيدية في المراحل الأولى لوضع السياسات في مجالات مثل التنظيم، والاعتماد، والقيادة، وثقافة السلامة، والإبلاغ العام القوى الدافعة لتحسين سلامة المرضى. وينبغي أن تظهر هذه التدخلات قيمتها في المساهمة في إحداث تخفيضات كبيرة في الأذى لدى تقديم الرعاية. وينبغي أن تُستكمل هذه التدخلات بتدخلات لاحقة في المراحل النهائية لتحسين سلامة المرضى في مجالات مثل بناء القدرات، ونظم الإبلاغ والتعلم، والعمل الجماعي والتواصل، وإشراك المرضى، فضلاً عن إيجاد حلول لعمليات الرعاية السريرية الشديدة الخطورة. وستشير مبادرات تحسين سلامة المرضى طلباً على سياسات أفضل تكيفاً وتدخلات على مستوى النظام من خلال حلقة التعقيبات (الشكل 6-1).

2.6 المعالم الرئيسية في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى

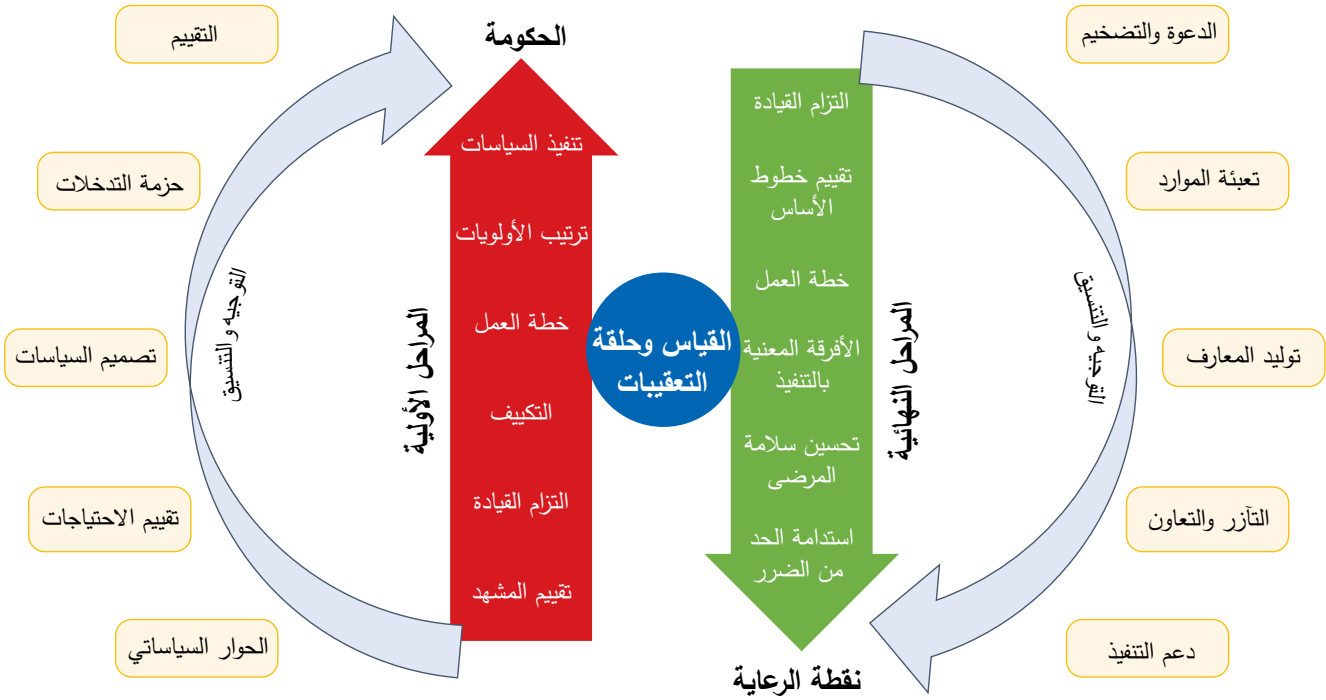
سلامة المرضى هي مسألة تهم الجميع. ولذلك، يتجاوز تنفيذ خطة العمل العالمية للفترة 2021-2030 نطاق أي وكالة من الوكالات أو مجموعة من أصحاب المصلحة، وسيطلب شراكات فعالة. ويجب أن يساهم جميع الشركاء في العمل في تنفيذ هذه الخطة على المستويات العالمي والإقليمي والوطني ودون الوطني، بشكل فردي ومن خلال الشراكات، مع مراعاة جوهر التماسك والتكامل بين الإجراءات. ويترك تنفيذ خطة العمل العالمية مجالاً لتكريس

يوجد تنوع كبير في هيكل نظم الرعاية الصحية وتمويلها وحوكمتها في جميع أنحاء العالم، ويوجد أيضاً تباين شاسع في الطريقة التي تتم بها قيادة وإدارة مرافق الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، تختلف أهداف السياسات والأولويات الاستراتيجية وفعالية التدخلات عبر مختلف البيئات ومختلف الفئات السكانية الفرعية تبعاً للثقافة والسياق والموارد. وقد تسنى وضع مسودة خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 مع الإقرار التام بأن البلدان تمر بمراحل مختلفة في جهودها الرامية إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمرضى في قطاع الرعاية الصحية ولتعزيز نظمها الصحية الوطنية. ولذلك لا توجد سياسة عامة واحدة أو نهج استراتيجي أو تدخل واحد يمكن تطبيقه عالمياً على جميع أنواع بيئات الرعاية الصحية. وينبغي تكيف هذه الخطوات قبل الشروع في التنفيذ. وينبغي أيضاً أن يتماشى نهج التنفيذ مع الخطة الوطنية للصحة وأن يكون متسقاً فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية القائمة، وعمليات الحوكمة والإدارة، والآلية الاستشارية المتخصصة.

وتوفر خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 سبعة أهداف استراتيجية يمكن تحقيقها من خلال 35 استراتيجية وتقتصر إجراءات يتعين على مختلف الشركاء ومجموعات أصحاب المصلحة اتخاذها. ويمكن اختيار هذه الإجراءات المقترحة وترتيب أولوياتها وتكييفها وتنفيذها، مع مراعاة عوامل مختلفة.

وسيكون تحقيق التنفيذ الكامل على الصعيد الوطني جدول أعمال طويل الأجل لمعظم الدول الأعضاء. ولذلك، يوصى بأن تضطلع الدول الأعضاء، قبل تنفيذ خطة العمل العالمية، بتقييم وتحليل حالتها لتحديد مجالات التقدم التي يمكن تعزيزها، فضلاً عن الفرص السياساتية المتاحة والثغرات التي تشوب الممارسات.

الشكل 6-1 نظام إيكولوجي لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2020-2031



المتعلقة بعبء الأذى الذي يلحق بالمرضى والأثر الاقتصادي، لا سيما إذا كانت البيانات متاحة في السياقين الوطني والمحلي. ويمكن أن تؤدي التغطية الإعلامية لقصاص المرضى الذين عانوا من أذى يمكن تجنبه إلى إطلاق خطاب عام يشجع القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات من أجل توفير رعاية صحية أكثر مأمونية. ويمكن أن يساعد تشجيع القادة الصحيين على المشاركة في المنابر الدولية مثل مؤتمرات القمة الوزارية العالمية بشأن سلامة المرضى في حشد الزخم والسعي إلى الحصول على الالتزام. وقد توفر أيضاً المشاركة في المبادرات الرائدة المتعلقة بسلامة المرضى والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، مثل التحديات العالمية للمنظمة بشأن سلامة المرضى، رؤية واضحة ومكاسب مبكرة نحو الحصول على الالتزام الكامل.

المعلم 3: إنشاء آلية مستدامة للتنفيذ

ينبغي إنشاء آلية مستدامة لتنفيذ التدخلات السياسية والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بسلامة ضمن السياق الأوسع للخطط الصحية الوطنية والسياسات المتعلقة بالسلامة والجودة. وقد يؤدي تفصيل المسؤولين الذي يتولون تنفيذ خطة العمل العالمية هذه على المستويين الوطني أو دون الوطني إلى تنسيق أعداد اللجان وأفرقة العمل والهيكل الاستشارية وغيرها من الهياكل وتحسينها على النحو الأمثل. وتبعاً لنوع السياق، وتوافر الموارد، والهيكل البرنامجية القائمة، يلزم تعيين مركز أو معهد أو إدارة أو وحدة أو منسق وطني معني بسلامة المرضى لتنسيق التنفيذ والإشراف عليه. وأياً كانت الآلية المعتمدة، فلا بد من ترجمتها على المستويين دون الوطني والمؤسسي مع تعيين جهة محورية

مرونة النهج من خلال مراعاة البيئة السياسية الحالية، والسياق التنظيمي القائم، وخيارات توزيع الموارد، شريطة أن تواصل الأهداف تحقيق التقدم على نحو فعال. وسيختلف أيضاً تحديد الأولويات والجدوى وسرعة التنفيذ حسب السياق. ولهذا السبب يقترح أن يأخذ جميع الشركاء وأصحاب المصلحة في الاعتبار بعض المعالم الرئيسية أثناء تنفيذ خطة العمل العالمية.

المعلم 1: تقييم المشهد

ينبغي إجراء تقييم للوضع فيما يتعلق بالتطورات التي يشهدها مجال سلامة المرضى على مختلف المستويات، وتحديد البيئة والفرص السياسية المتاحة، والمخاطر المتعلقة بالسلامة، وفجوات الممارسة، والعوائق التي تحول دون التحسين، ومجالات التقدم التي يمكن تعزيزها. وتحديد السياسات والاستراتيجيات والبرامج واللوائح والآليات المؤسسية القائمة، وتحليل سجل الأداء. وينبغي أن تساعد في تنفيذ هذه العملية أدوات تقييم موثوقة وضعتها منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى. وسيوضح تقييم وتحديد المشهد المتطلبات الأساسية لتنفيذ خطة العمل العالمية ويدعم اختيار الإجراءات ذات الصلة ويمنحها الأولوية.

المعلم 2: ضمان التزام قوي من جانب القيادات السياسية والتنظيمية

سيساعد تقييم المشهد في تسويق إعطاء الأولوية لمسألة سلامة المرضى ضمن الخطة الصحية الأوسع نطاقاً، وكذلك المعلومات

(من سنتين إلى ثلاث سنوات) والمتوسط (من ثلاث إلى ست سنوات) والأطول (من سبع إلى عشر سنوات). وتحدد مؤشرات للحكم على الأداء على المستوى الوطني وعلى مستوى مرافق الرعاية الصحية.

المعلم 5: البت في نموذج التغيير وتصميمه للتنفيذ

ينبغي وضع استراتيجية قوية لإدارة التغيير لضمان اتباع نهج شامل إزاء التدخلات السياسية والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بسلامة المرضى، إلى جانب إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار رؤية واضحة وتنفيذ مستدام. وتتمثل بعض أفضل الممارسات فيما يلي:

- النهج التدريجي للتحسين؛ والبدء بالتنفيذ على نطاق صغير مع إجراء تحول سريع؛
 - الاعتراف بالفرقة ومكافأتها على عملها الجيد؛
 - استخدام نهج إدارة المشاريع لتنفيذ الإجراءات المخطط لها؛ وتعيين الأدوار والمسؤوليات لجميع أصحاب المصلحة، وتحديد الجداول الزمنية وتعيين شخص رئيسي لتنسيق التنفيذ ورصده؛
 - وضع نظام للإرشاد والتدريب، وتحديد أفضل الممارسات والنماذج (الفردية والتنظيمية) التي يمكن أن تشجع وتحفز على إدخال تحسينات؛
 - كسر حواجز الانعزال، والاتصال الدائم، والتعاون مع البرامج الأخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين.
- وينبغي الاحتفاء بالنجاح وتعزيزه لرفع مستوى الوعي والدعم لدى السياسيين وأصحاب المصلحة والجمهور. ويشكل حشد المرضى والأسر والمجتمعات المحلية للمشاركة في تخطيط الحلول والإجراءات وتنفيذها عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.
- ويمكن لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية أن تحدد شكل مجال سلامة المرضى في البلدان وتُعجل وتيرة تنفيذه في البلدان من خلال الدعوة، والتنسيق، والتوجيه المعياري، والدعم التقني. وسينشئ هذا النهج الشامل للنظم والذي ينسق التدخلات على جميع المستويات "نظاماً إيكولوجياً" لتحسين سلامة المرضى على المستوى العالمي خلال السنوات العشر القادمة.

معنية بسلامة المرضى أو فريق معني بسلامة المرضى لاتخاذ إجراءات مركزة على جملة أمور منها سلامة المرضى، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وسلامة الأدوية. وبالمثل، ففي الحالات التي توجد فيها بالفعل ترتيبات جيدة الإعداد لإقامة شراكات فعالة، بما فيها تلك التي تتفاعل مع المرضى والأسر، فإن الإجراءات المقترحة في خطة العمل قد تتشكل من خلال ما يعمل بصورة جيدة على المستويين الوطني أو المحلي. وينبغي أن تتشكل التدخلات السياسية والمبادرات الاستراتيجية من خلال عملية تشاورية صارمة يشارك فيها جميع الشركاء في العمل، بما في ذلك القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص.

المعلم 4: التواءم مع السياق والأولويات الوطنية

توفر خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 إطاراً للعمل الذي سيتدفق من المستوى الوطني إلى مستوى المرافق الصحية والفريق السريري. ولا بد أن يراعي تكييف الإطار العالمي مع السياق القطري سياق الرعاية الصحية داخل البلد، وتصميم نظام الرعاية الصحية وتمويله، والأولويات القائمة. ويتعين على البلدان التي لديها بالفعل خطة عمل وطنية تتضمن تدخلات محددة في مجال سلامة المرضى أن تستعرض خطة العمل العالمية وتتوافق معها وأن تستكمل خططها وتعديلها وفقاً لذلك.

وقد تتمثل بعض معايير ترتيب الأولويات فيما يلي:

- الإجراءات الأساسية والحاسمة للحد من أعلى المخاطر التي يتعرض لها المرضى؛
- التدخلات التي يسهل تنفيذها نسبياً وتؤثر تأثيراً كبيراً على الأذى الذي يمكن تجنبه؛
- التدخلات المتعلقة بسلامة المرضى والمتسقة مع الأولويات الصحية القائمة على المستويين الوطني أو دون الوطني؛
- التدخلات المتعلقة بسلامة المرضى والتي تساهم في تحسين أداء النظام الصحي وتحسين النتائج الصحية؛
- التدخلات المنهجية بطبيعتها، والتي تعود بالنفع على أعداد كبيرة من المرضى، وتضمن تحسينات مستدامة على المدى الطويل.

واستناداً إلى ترتيب الأولويات والجداول الزمنية المقدرة للتنفيذ، تحدد العمليات والنتائج التي يتعين تحقيقها على المدى القصير

7- الرصد والإبلاغ

منظمة الصحة العالمية رصد جميع المؤشرات الأساسية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. وسيعرض تقرير عن التقدم المحرز في تحقيق هذه المؤشرات إلى جمعية الصحة العالمية من خلال تقارير مرحلية متتالية تقدم كل سنتين على النحو المنصوص عليه في القرار ج ص ع ٧٢-٦. وتتعلق معظم المؤشرات الأساسية المقترحة بالسياسات أو البرامج، وستجمع البيانات عن التقدم المحرز فيها من خلال استقصاءات تتعلق بالدول الأعضاء وتتسقها أمانة منظمة الصحة العالمية أو المنظمات والمؤسسات الشريكة، حسب الاقتضاء.

وتُقدّم مجموعة المؤشرات "المتقدمة" لإتاحة قياس جوانب إضافية من إجراءات سلامة المرضى. وتُشجّع البلدان على اختيار أنسب المؤشرات استناداً إلى سياقها وقدراتها وأولوياتها المحددة المتعلقة بسلامة المرضى. ويمكن إتاحة التقدم المقاس على أساس المؤشرات الأساسية والمتقدمة للجمهور على المستويين الوطني أو المحلي والمساهمة في الإبلاغ السنوي عن حالة التحسينات المتعلقة بسلامة المرضى.

وستضطلع أمانة منظمة الصحة العالمية بوضع توجيهات مفصلة بشأن الرصد والإبلاغ كجزء من مجموعة أدوات تنفيذ خطة العمل. وستوفر مجموعة الأدوات هذه معلومات عن التعاريف ومصادر البيانات والأساليب وعملية الإبلاغ والتحليل.

وتعمل أمانة منظمة الصحة العالمية أيضاً على إعداد أداة لتقييم سلامة المرضى لدعم تنفيذ خطة العمل العالمية. وستساعد هذه الأداة الحكومات ومرافق الرعاية الصحية على تقييم خط الأساس وتقييم التقدم المحرز بشكل دوري. وتتماشى أداة التقييم مع الأهداف والاستراتيجيات الاستراتيجية لخطة العمل ويمكن أن تساعد في تحديد درجات رقمية لقياس التقدم المحرز في الإجراءات والنتائج في إطار كل هدف من الأهداف الاستراتيجية. وستوفر اتجاهات هذه الدرجات مقياساً إضافياً لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية.

وستقدم منظمة الصحة العالمية، من خلال مكاتبها الإقليمية والقطرية، الدعم التقني والتدريب والتوجيه من أجل إجراء تقييمات

ترمي خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 إلى الحد إلى أقصى قدر ممكن من الأذى الذي يمكن تجنبه على الصعيد العالمي والذي نجم الرعاية الصحية غير المأمونة. ولم تحدد خطة العمل هدفاً للخفض العددي، مع الإقرار بأنه لا يوجد تقدير موثوق به لمدى عبء الضرر في معظم البلدان، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ولذلك، فهي تشجع جميع البلدان على وضع تقديراتها الأساسية للأداء المرتبط بالسلامة وتحديد أهداف لتنفيذ الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين سلامة المرضى. ويقترح هذا الفرع مجموعة من المقاييس لدعم الدول الأعضاء في رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل هذه والإبلاغ عنه. ويمكن لجهود الرصد والإبلاغ أن تعزز نظم إدارة المعلومات الصحية القائمة للحصول على بيانات للإبلاغ عن التقدم المحرز في العديد من هذه المؤشرات المقترحة لسلامة المرضى وتتبعها.

وإدراكاً بأن البلدان تمر بمراحل مختلفة من نضج النظام الصحي ولديها موارد وقدرات وأولويات متنوعة لتحسين سلامة المرضى، ينبغي أن يتسم اعتماد آليات الرصد والإبلاغ وتطبيقها بالمرونة لاستيعاب هذه الاختلافات. ويمكن لآلية عالمية للإبلاغ عن مجموعة دنيا من المؤشرات والأهداف الأساسية أن تساعد في تقييم التقدم المحرز في التنفيذ على المستويات العالمي والإقليمي والوطني.

وتتوافق المؤشرات المعروضة هنا مع الأهداف الاستراتيجية السبعة لخطة العمل العالمية. واقترحت هذه التدابير بوصفها "نتائج" تمثيلية للإجراءات المتخذة بشأن الهدف الاستراتيجي المقابل. وتصنف المؤشرات إلى مؤشرات "أساسية" و "متقدمة" للحد من عبء جمع البيانات وإتاحة سبل المرونة.

7-1 المؤشرات الرئيسية

والمؤشرات الأساسية 10 المقترحة هي مؤشرات ضرورية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية هذه. وتعزّم أمانة

لترتيب أولويات مؤشرات سلامة المرضى وتفعيلها من أجل الإبلاغ عنها وتحليلها وتحسينها. موضوعية وتحليل لوضع سلامة المرضى باستخدام المؤشرات وأدوات التقييم. وستقدم منظمة الصحة العالمية أيضاً دعماً تقنياً



الهدف
الاستراتيجي

1

المؤشر

عدد البلدان التي وضعت خطة عمل وطنية (أو ما يعادلها) لتنفيذ سياسات واستراتيجيات بشأن سلامة المرضى

الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي وضعت خطة عمل وطنية لسلامة المرضى أو ما يعادلها

وضع خط الأساس	2021
30% من البلدان	2023
50% من البلدان	2025
80% من البلدان	2027
90% من البلدان	2030

مصادر البيانات

استقصاء تجريه منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء



الهدف
الاستراتيجي

2

المؤشر

عدد البلدان التي طبقت نظاماً للإبلاغ عن الأحداث التي لم تحدث قط (أو الأحداث الخافرة)

الغايات العالمية

نسبة البلدان طبقت نظاماً للإبلاغ عن الأحداث التي لم تحدث قط (أو الأحداث الخافرة)

وضع خط الأساس	2021
30% من البلدان	2023
50% من البلدان	2025
80% من البلدان	2027
90% من البلدان	2030

مصادر البيانات

استقصاء أجرته للدول الأطراف منظمة الصحة الدولية أو مؤسسة شريكة



الهدف
الاستراتيجي

3

المؤشر

انخفاض كبير في العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية

الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي حققت غاياتها الوطنية في مجال خفض معدل الإصابة بالعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية

وضع خط الأساس أو غايات وطنية	2022
20% من البلدان	2023
40% من البلدان	2025
60% من البلدان	2027
80% من البلدان	2030

مصادر البيانات

النظم الوطنية للمعلومات المتعلقة بالصحة أو سلامة المرضى



الهدف الاستراتيجي

3

المؤشر

انخفاض كبير في الأذى المتصل بالأدوية (أحداث الأدوية الضائرة)

الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي حققت غاياتها الوطنية في مجال الحد من الأذى المتصل بالأدوية

2022	وضع خط الأساس أو غايات وطنية
2023	20% من البلدان
2025	50% من البلدان
2027	70% من البلدان
2030	80% من البلدان

مصادر البيانات

النظم الوطنية للمعلومات المتعلقة بالصحة أو سلامة المرضى



الهدف الاستراتيجي

4

المؤشر

عدد البلدان التي لديها ممثل للمرضى في مجلس الإدارة (أو آلية مماثلة) في 60% أو أكثر من المستشفيات

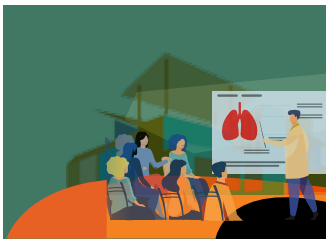
الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي يوجد في أكثر من 60% من مستشفياتها ممثل للمرضى في مجلس الإدارة (أو آلية مماثلة)

2022	وضع خط الأساس
2023	20% من البلدان
2025	30% من البلدان
2027	50% من البلدان
2030	70% من البلدان

مصادر البيانات

استقصاء أجرته منظمة شريكة معنية بالمرضى وعينتها منظمة الصحة العالمية



الهدف الاستراتيجي

5

المؤشر

عدد البلدان التي أدرجت منهجاً دراسياً بشأن سلامة المرضى في البرامج التعليمية أو الدورات الدراسية لمهنيي الرعاية الصحية

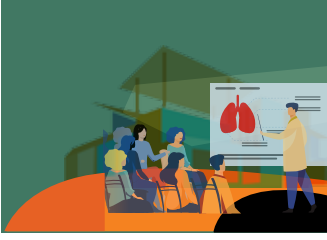
الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي أدرجت منهاجاً دراسياً لسلامة المرضى في البرامج التعليمية أو الدورات الدراسية لمهنيي الرعاية الصحية

2021	وضع خط الأساس أو غايات وطنية
2023	30% من البلدان
2025	50% من البلدان
2027	70% من البلدان
2030	80% من البلدان

مصادر البيانات

استقصاء للدول الأعضاء أجرته منظمة الصحة العالمية أو مؤسسة شريكة



الهدف الاستراتيجي 5

المؤشر

عدد البلدان التي وقعت لتنفيذ ميثاق منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة العاملين الصحيين¹

الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي وقعت لتنفيذ ميثاق منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة العاملين الصحيين

وضع خط الأساس	2021
30% من البلدان	2023
50% من البلدان	2025
80% من البلدان	2027
90% من البلدان	2030

مصادر البيانات

استقصاء للدول الأعضاء أجرته منظمة الصحة العالمية أو مؤسسة شريكة



الهدف الاستراتيجي 6

المؤشر

عدد البلدان التي لديها 60% أو أكثر من مرافق الرعاية الصحية المشاركة في نظام الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها

الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي لديها 60% أو أكثر من مرافق الرعاية الصحية المشاركة في نظام الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها

وضع خط الأساس	2021
20% من البلدان	2023
40% من البلدان	2025
60% من البلدان	2027
80% من البلدان	2030

مصادر البيانات

استقصاء أجرته منظمة الصحة العالمية أو مؤسسة شريكة

التقارير الواردة من النظام الوطني للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها

المؤشر

عدد البلدان التي تنشر تقريراً سنوياً عن سلامة المرضى

الغايات العالمية

النسبة المئوية للبلدان التي تنشر تقريراً سنوياً عن سلامة المرضى

وضع خط الأساس	2021
20% من البلدان	2023
40% من البلدان	2025
60% من البلدان	2027
70% من البلدان	2030

مصادر البيانات

استقصاء أجرته للدول الأعضاء منظمة الصحة العالمية

¹ سلامة العاملين الصحيين: الأولوية لسلامة المرضى [بالإنكليزية]: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/339287>



الهدف الاستراتيجي

7

2-7 المؤشرات المتقدمة

1- الهدف الاستراتيجي 1

1-1 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي تحتفل باليوم العالمي بشأن سلامة المرضى

2-1 عدد مرافق الرعاية الصحية الموقعة لتنفيذ أهداف اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى

3-1 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي لديها نظام مكافأة لمرافق الرعاية الصحية استناداً إلى سلامة المرضى وجودة أداء الرعاية

4-1 النسبة المئوية للبلدان أو المقاطعات التي أدرجت معايير السلامة الدنيا في المتطلبات التنظيمية لمرافق الرعاية الصحية

5-1 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 1 بشأن أداة تقييم سلامة المرضى

2- الهدف الاستراتيجي 2

1-2 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي عينت موظفاً أو فريقاً أو وكالة (أو ما يعادل ذلك) لشؤون سلامة المرضى

2-2 عدد البلدان أو المقاطعات التي أنشأت إطاراً مؤسسياً لتنفيذ سلامة المرضى على جميع المستويات

3-2 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي تجري استقصاءات منتظمة بشأن ثقافة سلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية

4-2

عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي وضعت برنامجاً لبناء القدرات القيادية في مجال سلامة المرضى

5-2

عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي وضعت سياسة غير عقابية للإبلاغ عن الأحداث الضائرة وإثارة الشواغل المتعلقة بالسلامة

6-2

عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي أنشأت سجلاً للمخاطر لتحديد مخاطر السلامة المعروفة والمحتملة وإدارتها

7-2

عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي تجري تدريبات منتظمة أو عمليات محاكاة لاختبار خطة التخفيف من المخاطر

8-2

الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 2 بشأن أداة تقييم سلامة المرضى

3- الهدف الاستراتيجي 3

وتتصل معدلات الحوادث والحد منها بالقياسات المحددة لنتائج سلامة المرضى على المستويين الوطني ودون الوطني ومستوى مرافق الرعاية الصحية، بما يلي:

1-3

الوفيات التي يمكن تجنبها نتيجة للرعاية الصحية المرتبطة بالجلطات الدموية الوريدية أثناء أو بعد دخول المستشفى (لمدة تصل إلى 90 أيام بعد الخروج من المستشفى)

2-3

الوفيات التي يمكن تجنبها بسبب الإنتان المرتبط بالرعاية الصحية

3-3

غياب أو تأخر التشخيص

4-3

تعدد الأدوية غير الملائم

5-3

الوفيات خلال الفترة المحيطة بالجراحة

- 6-3 الوفيات التي يمكن تجنبها والتي تحدث بسبب سقوط المرضى أثناء الإقامة في المستشفى
- 7-3 ردود الفعل الشديدة لنقل الدم
- 8-3 إصابة الولادة أثناء الولادة العادية والولادة القيصرية
- 9-3 إصابة حديثي الولادة
- 10-3 قرحة الاستلقاء داخل المستشفى
- 11-3 أحداث نقل مقاومة مضادات الميكروبات
- 12-3 حوادث الالتهاب الرئوي المرتبط بالتنفس الاصطناعي (التهوية)
- 13-3 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 3 بشأن أداة تقييم سلامة المرضى
- 3-5 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي وضعت برنامجاً للسلامة المهنية للعاملين الصحيين
- 4-5 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي يعطى فيها التطعيم للعاملين الصحيين بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات (بما في ذلك كوفيد-19) على سبيل الأولوية
- 5-5 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 5 المتعلق بأداة تقييم سلامة المرضى

6- الهدف الاستراتيجي 6

- 1-6 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي وضعت سجلات صحية إلكترونية
- 2-6 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي أنشأت نظام إنذار يتعلق بالسلامة من أجل الإسراع في إيصال ما يجري تحديده حديثاً من معلومات عن المخاطر العالية الأثر التي تهدد سلامة المرضى
- 3-6 عدد البلدان أو المقاطعات التي حددت الأولويات البحثية في مجال سلامة المرضى
- 4-6 عدد البلدان أو المقاطعات التي تجري دراسات لقياس عبء الضرر في الرعاية الصحية
- 5-6 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 6 المتعلق بأداة تقييم سلامة المرضى

4- الهدف الاستراتيجي 4

- 1-4 عدد السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية الصحية الأكثر مأمونية والتي وضعت بالاشتراك مع ممثلي المرضى والأسر أو منظمات المرضى على المستويين الوطني أو دون الوطني أو على مستوى مرافق الرعاية الصحية
- 2-4 عدد البلدان أو المقاطعات التي أنشأت شبكات للمدافعين عن المرضى والمناصرين لهم
- 3-4 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي أنشأت لجنة استشارية معنية بالمرضى وأسره (أو ما يعادلها).
- 4-4 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي وضعت ونفذت إجراءات للكشف عن الأحداث الضائرة التي يتعرض لها المرضى والأسر
- 5-4 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي تقيس التجارب التي يبلغ عنها للمرضى أو النتائج المتصلة بالسلامة
- 6-4 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 4 بشأن أداة تقييم سلامة المرضى

7- الهدف الاستراتيجي 7

- 1-7 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي حددت أهدافاً وغايات سنوية للأولويات المتعلقة بسلامة المرضى
- 2-7 عدد البلدان أو المقاطعات التي أنشأت لجنة توجيهية تعنى بسلامة المرضى وتضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين
- 3-7 عدد البلدان أو المقاطعات التي أدمجت عناصر سلامة المرضى في البرامج الصحية (مثل صحة الأم والطفل، ومكافحة الأمراض السارية، والأمراض غير السارية، وحالات الطوارئ الصحية، وخدمات الدم ونقل الدم، والسلامة الإشعاعية)
- 4-7 عدد البلدان التي يمثلها صانع سياسات رفيع المستوى في مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السنوية بشأن سلامة المرضى
- 5-7 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 7 المتعلق بأداة تقييم سلامة المرضى
- 4-4 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي وضعت ونفذت إجراءات للكشف عن الأحداث الضائرة التي يتعرض لها المرضى والأسر
- 5-4 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي تقيس التجارب التي يبلغ عنها للمرضى أو النتائج المتصلة بالسلامة
- 6-4 الدرجة المركبة للهدف الاستراتيجي 4 بشأن أداة تقييم سلامة المرضى

5- الهدف الاستراتيجي 5

- 1-5 عدد البلدان أو المقاطعات التي أدرجت حداً أدنى من المعايير لسلامة المرضى في برامج ومعايير الترخيص وإعادة الترخيص لمهنيي الرعاية الصحية
- 2-5 عدد البلدان أو المقاطعات أو مرافق الرعاية الصحية التي تجري تقييمات دورية لكفاءات مهنيي الرعاية الصحية في مجال سلامة المرضى

8- مواءمة مجال سلامة المرضى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

الجدول 8-1 توضيحات عن كيفية مساهمة مجال سلامة المرضى في تحقيق غايات محددة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، في حين يبين الجدول 8-2 الدور المحوري لمجال سلامة المرضى في تحقيق غايات الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة.

تشكل سلامة المرضى عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة ("ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار") وفي تحقيق التغطية الصحية الشاملة (الغاية 3-8). وبصرف النظر عن هذه الغاية الأساسية، ترتبط سلامة المرضى بروابط سببية مع عدة أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة. ويقدم

الجدول 8-1 أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومجال سلامة المرضى

أهداف التنمية المستدامة	الغاية	الطرق التي يساهم بها مجال سلامة المرضى
الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 1-2: تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030	يدفع الإنفاق الكارثي على الرعاية الصحية ملايين الأسر كل عام إلى ما دون خط الفقر. وتساعد "سلامة المرضى" في خفض نفقات الرعاية الصحية التي تسببها أوجه القصور في السلامة وكذلك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية.
الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 3-1: خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من ٧٠ حالة لكل 100 000 من المواليد الأحياء	يُعزى العديد من وفيات الأمهات إلى الرعاية غير المأمونة في مرافق الرعاية الصحية ويمكن الوقاية منها بتنفيذ تدخلات ترمي إلى تحسين سلامة المرضى.
الغاية 3-8: تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية إلى جانب إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة	يجد تحسين سلامة المرضى بشكل جذري من الهدر في الرعاية الصحية ويحسن إمكانية الوصول إليها بالتأثير إيجابياً على السلوك الساعي إلى المحافظة على الصحة.	

أهداف التنمية المستدامة	الغاية	الطرق التي يساهم بها مجال سلامة المرضى
الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 5-2: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال	يضطلع القطاع الصحي والعاملون الصحيون بدور هام في منع العنف ضد المرأة والتصدي له. ومن خلال مشاركة المرضى والرعاية المحترمة، تعزز سلامة المرضى الرعاية التي تركز على الناجيات ولا سيما الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس. وبما أن النساء يشكلن 70٪ تقريباً من القوى العاملة في مجال الصحة، فمن الأهمية بمكان القضاء على العنف القائم على نوع الجنس في نظام الرعاية الصحية. وتشكل سلامة العاملين الصحيين بعداً هاماً من أبعاد مجال سلامة المرضى.
الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 6-1: تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030	تشكل خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مكوناً أساسياً في ضمان سلامة المرضى ويمكن أن يؤثر على سلوك المجتمع المحلي تجاه الصرف الصحي.
الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 8-8: حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العمال	قد يحسن التركيز على العوامل البشرية وثقافة السلامة بشكل مستدام السلامة في مكان العمل في نظم الرعاية الصحية، التي تشكل أحد أصحاب العمل الرئيسيين في معظم الاقتصادات.
الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 10-2: تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بصرف النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030	يشكل إشراك المرضى والأسر والمجتمعات المحلية وتمكينهم حجر الزاوية في مجال سلامة المرضى ويعزز الإنصاف والإدماج في الرعاية الصحية.
الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة 	الغاية 12-4: بحلول عام 2020، الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية وجميع النفايات، وفقاً للإطار الدولي المتفق عليه	تعزز البرامج المتعلقة بسلامة المرضى الإدارة السليمة للنفايات المعدية وهدف المستشفيات الخالية من الزئبق، وفقاً لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

الجدول 2-8 مسائل ذات صلة بسلامة المرضى لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة

أهداف الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة	أمثلة عن الأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية
1-3 خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 000 مولود حي	- عدم تشخيص الحمل عالي الخطورة - إصابات الولادة - التدبير غير الآمن لمضاعفات الولادة، مثل النزيف بعد الولادة وتعسر المخاض - الممارسات الخاطئة في غرفة المخاض، مثل الضغط الزائد على قاع الرحم والحث غير الضروري، وبضع الفرج غير الضروري، ولقط الحبل السري الفوري - الجلطات الدموية الوريدية أثناء الحمل
2-3 إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تجنبها، بحلول عام 2030	- المضاعفات الناجمة عن الرعاية غير المأمونة قبل الأوان وأثناء الولادة، مثل الاختناق عند الولادة - المسائل المتعلقة بسلامة التطعيم - عدم تشخيص التشوهات الخلقية - الأخطاء المرتكبة في جرعات الأدوية المقدمة للأطفال - السقوط في المستشفى للولدان والرضع - الفشل في عملية الإنعاش - تعفن الدم لدى حديثي الولادة - الأخطاء في أهداف الأكسجة
3-3 القضاء على أوبئة الإيدز والسل والملاريا وأمراض المناطق المدارية المهملة، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030	- الإصابات الحادة في مرافق الرعاية الصحية - عدم وجود منتجات الحماية الشخصية - نقل الدم غير الآمن - ممارسات الحقن غير المأمونة - التعرض للسائل المهني - الأحداث الدوائية الضائرة في علاج السل والملاريا - التشخيص الخاطئ لمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة - قضايا سلامة الأدوية في توزيع الأدوية على نطاق جماهيري لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة - قضايا السلامة بشأن التسمم بلدغات الأفاعي
4-3 خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة النفسية، بحلول عام 2030	- التشخيص المبكر الفائق والتشخيص الخاطئ للأمراض غير السارية - تعدد الأدوية - الأخطاء المعملية - أخطاء الوصفات الطبية والأخطاء في إعطاء الأنسولين - سلوك إيذاء النفس، والأحداث الدوائية الضائرة، والسقوط أثناء تقديم الرعاية الصحية النفسية - قضايا السلامة في العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي - الفشل في الإنقاذ - مخاوف تتعلق بالسلامة مع الاستخدام الطبي للإشعاع الأيوني

أمثلة عن الأذى الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية	غايات الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة
• عدم إشراك المرضى، مما يؤدي إلى التوقف والانتكاس • إيذاء النفس والسلوك العنيف • تعاطي المخدرات والإدمان • سرقة المخدرات وإساءة استعمالها • مضاعفات العلاج الدوائي، مثل الجرعة الزائدة	5-3 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك
• مضاعفات الإجهاد غير المأمون • مضاعفات جراحات التعقيم، مثل التهابات المواقع الجراحية والأحداث الدوائية الضائرة • عدم التقيد بمعايير الأهلية الطبية لاستخدام وسائل منع الحمل، مما يؤدي إلى وصف وسائل منع الحمل بطريقة غير ملائمة • قصور وسائل منع الحمل	7-3 ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتثقيف بشأنها، بحلول عام 2030
• الإقامة المطولة في المستشفى • العودة مجدداً إلى المستشفى • تكاليف التقاضي الناجمة عن الحوادث المتعلقة بالسلامة • الإجراءات المتكررة • فقدان الثقة الذي يؤدي إلى تضائل الحرص على التماس الرعاية الصحية • المنتجات الطبية المتدنية الجودة والمغشوشة	8-3 تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيدة والفعالة والميسورة التكلفة
• التلوث البيئي المتصل بالنفايات الخطرة والمعدية المرتبطة بالرعاية الصحية • الآثار الضارة الناجمة عن الاستخدام الطبي للزئبق • التخلص غير السليم من عوامل العلاج الكيميائي والعوامل المشعة • نفايات المستشفيات السائلة التي تحتوي على مواد خطيرة ومعدية	9-3 الحد بقدر كبير من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، وتلوث الهواء والماء والتربة، بحلول عام ٢٠٣٠
• إرهاب العاملين الصحيين، وتعرض السلامة النفسية للخطر • العنف ضد العاملين الصحيين • نقص الخبرة في العوامل البشرية التي يُستشهد بها في تصميم نظم رعاية أكثر مأمونية • المخاطر الفيزيائية والكيميائية • أوجه النقص في مهارات الموظفين والتدريب	ج-٣ تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

9- تخطيط قرار جمعية الصحة العالمية

ج ص ع 72-6 لخطة العمل

العالمية بشأن سلامة المرضى

للفترة 2030-2021

ويبين الجدول 9-1 كيف يمكن ربط فقرات منطوق قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 72-6، الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون في أيار/مايو 2019، باستراتيجيات خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2030-2021.

الجدول 9-1 أوجه الترابط بين القرار ج ص ع 72-6 واستراتيجيات خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2030-2021

الفقرة من المنطوق	البيان	الصلة مع الاستراتيجيات
	جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون:	
1	تؤيد إقامة يوم عالمي بشأن سلامة المرضى يُحتفى به سنوياً في 17 أيلول/سبتمبر من أجل زيادة وعي الجمهور وإشراكهم وتعزيز التفاهم على الصعيد العالمي والعمل صوب تحقيق التضامن العالمي واتخاذ الدول الأعضاء لإجراءات تعزز سلامة المرضى	الاستراتيجية 1-5: اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى
2	تحث الدول الأعضاء على ما يلي:	
1-2	الاعتراف بسلامة المرضى باعتبارها أولوية صحية في سياسات قطاع الصحة وبرامجها وجعلها عنصراً أساسياً لتعزيز نظم الرعاية الصحية بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة	الاستراتيجية 1-1: سياسة عامة واستراتيجية لسلامة المرضى وإطار للتنفيذ الاستراتيجية 2-2: الحوكمة الرشيدة لنظام الرعاية الصحية
2-2	تقييم مشكلة سلامة المرضى، بما فيها المخاطر والأخطاء والأحداث الضارة والأذى الذي يصيب المرضى، وقياسها من حيث طبيعتها وحجمها على جميع مستويات إيتاء الخدمات الصحية، بوسائل منها الاستعانة بنظم التبليغ والتعلم وإبداء التعليقات التي تدمج وجهات نظر المرضى وأسرهم؛ واتخاذ إجراءات وقائية وتنفيذ تدابير منهجية للحد من المخاطر التي يتعرض لها جميع الأفراد	الاستراتيجية 1-6: نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها الاستراتيجية 2-6: ترصد سلامة المرضى ونظم المعلومات المتعلقة بها الاستراتيجية 3-6: برامج تحسين سلامة المرضى

الفقرة من المنطوق	البيان	الصلة مع الاستراتيجيات
3-2	إعداد سياسات وتشريعات واستراتيجيات وإرشادات وأدوات وطنية وتنفيذها ونشر الموارد الكافية بغية تعزيز مأمونية جميع الخدمات الصحية حسب مقتضى الحال	- الاستراتيجية 1-1: سياسة عامة واستراتيجية لسلامة المرضى وإطار للتنفيذ - الاستراتيجية 2-1: تعبئة الموارد وتخصيصها - الاستراتيجية 3-1: التدابير التشريعية الوقائية - الاستراتيجية 3-5: الكفاءات في مجال سلامة المرضى بوصفها متطلبات تنظيمية
4-2	العمل بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرضى والمنظمات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث ودوائر الصناعة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية من أجل تعزيز سلامة المرضى ومنحها الأولوية وترسيخها في جميع السياسات والاستراتيجيات الصحية	- الاستراتيجية 1-7: إشراك أصحاب المصلحة - الاستراتيجية 2-7: الفهم الموحد والالتزام المشترك - الاستراتيجية 4-7: مبادرات شاملة لعدة قطاعات وفيما بين المناطق الجغرافية بشأن سلامة المرضى - الاستراتيجية 5-7: الروابط القائمة مع البرامج والمبادرات التقنية
5-2	تبادل أفضل الممارسات ونشرها وتشجيع التعلم على أساس متبادل للحد من الضرر الذي يصيب المرضى عبر التعاون الإقليمي والدولي	- الاستراتيجية 1-6: نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها - الاستراتيجية 2-6: ترصد سلامة المرضى ونظم المعلومات المتعلقة بها - الاستراتيجية 3-7: الشبكات والتعاون في مجال سلامة المرضى - الاستراتيجية 4-7: مبادرات شاملة لعدة قطاعات وفيما بين المناطق الجغرافية بشأن سلامة المرضى
6-2	إدماج الاستراتيجيات المتعلقة بسلامة المرضى وتنفيذها في جميع البرامج السريرية ومجالات المخاطر، حسب الاقتضاء، للوقاية من الأضرار التي تلحق بالمرضى ويمكن تجنبها بسبب إجراءات الرعاية الصحية ومنتجاتها وأجهزتها، مثل مأمونية الأدوية وسلامة العمليات الجراحية ومكافحة حالات العدوى والتدبير العلاجي للإنتان ومأمونية التشخيص ونظافة البيئة والبنى التحتية ومأمونية الحقن ومأمونية العلاج بالإشعاع، فضلاً عن التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن عدم دقة التشخيص والعلاج أو تأخيرهما، وإيلاء عناية خاصة للفئات المعرضة للخطر	- الاستراتيجية 1-3: سلامة الإجراءات السريرية المعرضة للخطر - الاستراتيجية 2-3: التحدي العالمي الثالث بشأن سلامة المرضى: أدوية بلا أذى أضرار - الاستراتيجية 3-3: الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات - الاستراتيجية 4-3: سلامة الأجهزة الطبية والأدوية والدم واللقاحات - الاستراتيجية 5-3: سلامة المرضى في سياق الرعاية الأولية ومراحل الرعاية الانتقالية - الاستراتيجية 5-7: الروابط القائمة مع البرامج والمبادرات التقنية
7-2	تعزيز ثقافة السلامة عن طريق توفير التدريب الأساسي لجميع المهنيين الصحيين، وإيجاد ثقافة أخرى بشأن الإبلاغ عن الأحداث المتعلقة بسلامة المرضى من دون إلقاء اللائمة على أحد من خلال الاستعانة بنظم مفتوحة وشفافة تحدد العوامل المسببة للضرر والمؤدية إليه وتستخلص العبر من دراسة تلك العوامل وتتناول العوامل البشرية وتبني القدرات في مجالي القيادة والإدارة وتتولى تشكيل فرق كفؤة ومتعددة التخصصات من المهنيين الصحيين رفعا لمستوى الوعي وزيادة لتولي الأمور وتحسيناً للحصائل المحققة بالنسبة إلى المرضى وتقليلاً للتكاليف المتكبدة عن الأحداث الضارة على جميع مستويات النظم الصحية	- الاستراتيجية 1-2: ثقافة الانفتاح والشفافية و"عدم اللوم" - الاستراتيجية 3-2: القدرة القيادية على أداء الوظائف السريرية والإدارية - الاستراتيجية 4-2: العوامل البشرية/بيئة العمل من أجل قدرة النظم الصحية على الصمود - الاستراتيجية 1-6: نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها

الفقرة من المنطوق	البيان	الصلة مع الاستراتيجيات
8-2	بناء قدرات الموارد البشرية المستدامة من خلال الاضطلاع بأنشطة تنقيف وتدريب متعدّدة التخصصات ومشاركة بين التخصصات المهنية وقائمة على الكفاءة ومبنية على المناهج الصادرة عن المنظمة بشأن سلامة المرضى ومواصلة تطويرها من الناحية المهنية تعزيزاً لاتباع نهج متعدّد التخصصات وإيجاد بيئة عمل مواتية تحقّق الحد الأمثل من عملية إيتاء الخدمات الصحية المأمونة	- الاستراتيجية 1-5: سلامة المرضى في التعليم والتدريب المهنيين - الاستراتيجية 2-5: المراكز المتميّزة المختصّة بالتنقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى - الاستراتيجية 4-5: ربط سلامة المرضى بنظم تقييم العاملين الصحيين - الاستراتيجية 5-5: بيئة عمل آمنة للعاملين الصحيين
9-2	تشجيع البحوث، بما فيها البحوث الانتقالية، دعماً لتقديم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية وأطول أجلاً	الاستراتيجية 4-6: وضع وتمويل برامج بحثية نشطة بشأن سلامة المرضى، وخاصة الأبحاث الانتقالية
10-2	تعزيز الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، ومنها التكنولوجيات الرقمية في مجال الصحة، بوسائل منها إنشاء نظم المعلومات الصحية وتعزيزها ودعم عملية جمع البيانات لأغراض ترصد المخاطر والأحداث الضارة وغيرها من المؤشرات الدالة على إلحاق الأذى والإبلاغ عنها على مختلف مستويات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية المتصلة بالصحة، والعمل في الوقت نفسه على ضمان حماية البيانات الشخصية، ودعم الاستفادة من الحلول الرقمية لتقديم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية؛	- الاستراتيجية 2-6: ترصد سلامة المرضى ونظم المعلومات المتعلقة بها - الاستراتيجية 5-6: التكنولوجيا الرقمية المتعلقة بسلامة المرضى
11-2	النظر في استعمال الطب التقليدي والتكميلي، حسب الاقتضاء، في مجال تقديم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية	الاستراتيجية 2-3: التحدي العالمي الثالث بشأن سلامة المرضى: أدوية بلا أضرار
12-2	تنفيذ نظم معنية بإشراك أسر المرضى والمجتمعات المحلية وتمكينهم في مجال تقديم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية (وخصوصاً منهم المتأثرون بأحداث ضارة)، وبوسائل منها التقدم بمبادرات وإنشاء شبكات وإقامة رابطات معنية ببناء القدرات؛ والعمل معهم ومع فئات المجتمع المدني والاستفادة إيجابياً من خبراتهم بشأن الرعاية المأمونة وغير المأمونة لأجل وضع استراتيجيات بشأن مأمونية الرعاية وتقليل الأضرار الناجمة عنها إلى أدنى حد، فضلاً عن وضع آليات وبرامج معنية بالتعويضات، وبما يشمل جميع النواحي المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، حسب الاقتضاء	- الاستراتيجية 1-4: المشاركة في وضع السياسات والبرامج مع المرضى - الاستراتيجية 2-4: التعلم من تجربة المرضى لتحسين السلامة - الاستراتيجية 3-4: المدافعون عن المرضى والمناصرين لهم - الاستراتيجية 4-4: الإفصاح عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى للضحايا - الاستراتيجية 5-4: إشراك المرضى في تنفيذ خطة العمل
13-2	والاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى كل عام في 17 أيلول/سبتمبر للترويج لجميع جوانب سلامة المرضى بما فيها التقدم المحرّر نحو بلوغ الأهداف المرحلية الوطنية، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين	الاستراتيجية 5-1: اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى
14-2	دراسة موضوع المشاركة في مؤتمرات القمة الوزارية العالمية المعقودة سنوياً بشأن سلامة المرضى	الاستراتيجية 4-7: مبادرات شاملة لعدة قطاعات وفيما بين المناطق الجغرافية بشأن سلامة المرضى

الفقرة من المنطوق	البيان	الصلة مع الاستراتيجيات
3	تدعو المنظمات الدولية والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة إلى التعاون مع الدول الأعضاء في ميدان تعزيز المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى ودعمها، بوسائل منها تخصيص يوم عالمي بشأن سلامة المرضى يُحتفى به سنوياً	الاستراتيجية 1-5: اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى
4	تطلب من المدير العام ما يلي:	
1-4	أن يشدد على سلامة المرضى بوصفها أولوية استراتيجية رئيسية في عمل المنظمة عبر جميع نواحي برنامج عمل التغطية الصحية الشاملة	الاستراتيجية 1-1: سياسة عامة واستراتيجية لسلامة المرضى وإطار للتنفيذ
2-4	أن يضع إرشادات معيارية بشأن الحد الأدنى من المعايير والسياسات والممارسات الفضلى والأدوات اللازمة لصون سلامة المرضى، ولاسيما ما يتعلق منها بثقافة السلامة والعوامل البشرية والبنية التحتية الصحية وتصريف الشؤون السريرية وإدارة المخاطر	الاستراتيجية 1-4: معايير السلامة والتنظيم والاعتماد المتعلقة بها
3-4	أن يزود الدول الأعضاء بالدعم التقني، وخصوصاً منها البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، حسب الاقتضاء وعند اللزوم، لمساعدتها في بناء قدراتها الوطنية لدى سعيها إلى تقدير مدى صون سلامة المرضى وقياس معدلاتها وتحسينها، وذلك بالتعاون مع الرابطات المهنية، حسب الاقتضاء، وإرساء ثقافة السلامة وكذلك الوقاية بفعالية من الأضرار، بما فيها الالتهابات الناجمة عن الرعاية الصحية عن طريق بناء القدرات في مجالي القيادة والإدارة، والاستعانة بنظم مفتوحة وشفافة تحدد العوامل المسببة للضرر وتستخلص العبر من دراسة تلك العوامل	- الاستراتيجية 1-2: ثقافة الانفتاح والشفافية و"عدم اللوم" - الاستراتيجية 2-3: القدرة القيادية على أداء الوظائف السريرية والإدارية - الاستراتيجية 3-3: الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات - الاستراتيجية 2-6: ترصد سلامة المرضى ونظم المعلومات المتعلقة بها - الاستراتيجية 3-6: برامج تحسين سلامة المرضى
4-4	أن يزود الدول الأعضاء بالدعم، بناءً على طلبها، في مجال إنشاء نظم معنية بترصد سلامة المرضى و/أو تعزيز تلك النظم	الاستراتيجية 2-6: ترصد سلامة المرضى ونظم المعلومات المتعلقة بها
5-4	أن يعزز قدرة الشبكات العالمية المعنية بسلامة المرضى على تبادل أفضل الممارسات والتعلم من تجارب التعاون الدولي وتوثيق عراه، بوسائل منها الاستفادة من شبكة عالمية من المدربين على صون سلامة المرضى؛ وأن يعمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرضى والرابطات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث ودوائر الصناعة والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة على إنشاء نظم تقدم خدمات رعاية صحية أكثر مأمونية	- الاستراتيجية 1-7: إشراك أصحاب المصلحة - الاستراتيجية 2-7: الفهم الموحد والالتزام المشترك - الاستراتيجية 3-7: الشبكات والتعاون في مجال سلامة المرضى - الاستراتيجية 4-7: مبادرات شاملة لعدة قطاعات وفيما بين المناطق الجغرافية بشأن سلامة المرضى - الاستراتيجية 5-7: الروابط القائمة مع البرامج والمبادرات التقنية

الفقرة من المنطوق	البيان	الصلة مع الاستراتيجيات
6-4	أن يقدم الدعم التقني والإرشادات المعيارية، بناءً على الطلب، بشأن تنمية قدرات الموارد البشرية في الدول الأعضاء من خلال الاضطلاع بأنشطة تنقيف وتدريب مشتركة بين التخصصات المهنية وقائمة على الكفاءة ومبنية على المناهج الصادرة عن المنظمة بشأن سلامة المرضى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، وإنشاء برامج معنية بتدريب المدربين للتوعية والتدريب في مجال سلامة المرضى وشبكات عالمية وإقليمية من المجالس المهنية التعليمية من أجل تعزيز التوعية بشأن سلامة المرضى	- الاستراتيجية 5-1: سلامة المرضى في التعليم والتدريب المهنيين - الاستراتيجية 5-2: المراكز المتميزة المختصة بالتنقيف والتدريب في مجال سلامة المرضى
7-4	أن يضع بالتشاور مع الدول الأعضاء نظاماً معنية بالتبادل العالمي لخبرات التعلم المكتسبة من الأحداث المتعلقة بسلامة المرضى ويدير تلك النظم، وذلك بوسائل منها الإبلاغ المنهجي الموثوق، ونظم تحليل البيانات وبثها	الاستراتيجية 6-1: نظم الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى والتعلم منها
8-4	أن يصمم "التحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى" ويطلقها ويدعمها، وأن يضع الاستراتيجيات والإرشادات والأدوات وينفذها دعماً للدول الأعضاء في تنفيذ كل "تحدي" باستخدام أفضل البيئات المتاحة	الاستراتيجية 1-5: اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى
9-4	أن يعزز تطبيق التكنولوجيات الرقمية والبحوث ويدعم تطبيقها، بما فيها البحوث الانتقالية من أجل تحسين سلامة المرضى	الاستراتيجية 6-5: التكنولوجيا الرقمية المتعلقة بسلامة المرضى
10-4	تقديم الدعم للدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في وضع نظم لدعم المشاركة الفعالة في تقديم الرعاية الصحية الأكثر أماناً، والمشاركة فيها وتمكينها؛ وفي إنشاء وتعزيز شبكات لإشراك المرضى والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني وجمعيات المرضى	- الاستراتيجية 4-1: المشاركة في وضع السياسات والبرامج مع المرضى - الاستراتيجية 4-2: التعلم من تجربة المرضى لتحسين السلامة - الاستراتيجية 4-3: المدافعون عن المرضى والمناصرون لهم - الاستراتيجية 4-4: الإفصاح عن الحوادث المتعلقة بسلامة المرضى للضحايا - الاستراتيجية 4-5: إشراك المرضى في تنفيذ خطة العمل
11-4	أن يعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز اليوم العالمي لسلامة المرضى	الاستراتيجية 1-5: اليوم العالمي بشأن سلامة المرضى والتحديات العالمية المتعلقة بسلامة المرضى
12-4	أن يضع خطة عمل عالمية بشأن سلامة المرضى بالتشاور مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنتمون منهم إلى القطاع الخاص، كي تُعرض على جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين في عام 2021 من خلال المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة	
13-4	أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، لكي تنظر فيه جمعيات الصحة العالمية الرابعة والسبعون والسادسة والسبعون والثامنة والسبعون	

شكر وتقدير

فرقة العمل المعنية بالصياغة والاستعراض:

هيتوشي أكازاوا، اليابان؛ عبد الإله الحاسوي، المملكة العربية السعودية؛ ماهدافا بالاكريشنان، منظمة الصحة العالمية؛ ماري-شارلوت بويسو، منظمة الصحة العالمية؛ أندرو كارسون ستيفنز، المملكة المتحدة؛ نيلام دينغرا، منظمة الصحة العالمية؛ السير ليام دونالدسون، مبعوث منظمة الصحة العالمية المعني بسلامة المرضى؛ مايك دوركين، المملكة المتحدة؛ نيكيل غوبتا، منظمة الصحة العالمية؛ مينا هاكينين وو، منظمة الصحة العالمية؛ إنغو هارتيل، ألمانيا؛ هيلين هاسكل، الولايات المتحدة الأمريكية؛ مكي كاجيوارا، منظمة الصحة العالمية؛ إدوارد كيللي، منظمة الصحة العالمية؛ شليل كيسافان، المملكة المتحدة؛ مندر لطيف، منظمة الصحة العالمية؛ بياوان ليمبانيالرت، تايلاند؛ ألبانا مير، منظمة الصحة العالمية؛ كاتلين موزير، الولايات المتحدة الأمريكية؛ إيرينا بابيفا، منظمة الصحة العالمية؛ ماريانا ديل روزاريو بيريز، منظمة الصحة العالمية؛ عزيز شيخ، المملكة المتحدة؛ هارديب سينغ، الولايات المتحدة الأمريكية؛ عائدة طه، منظمة الصحة العالمية؛ كازومي تاناكا، اليابان؛ شين أوشيرو، اليابان؛ أدريانا فيلاسكيز، منظمة الصحة العالمية.

فريق التحرير الرئيسي: السير ليام دونالدسون ونيلام دينغرا ونيكيل غوبتا.

الخبراء الدوليون: إليزابيث آدامز، أيرلندا؛ يولاندا أغرا، إسبانيا؛ يعقوب سيمان أحمد، إثيوبيا؛ رشيد العبري، عمان؛ سارة ألبولينو، إيطاليا؛ عبد الإله الحاسوي، المملكة العربية السعودية؛ هدى عامر الكثيري، قطر؛ هداية الله النور، أفغانستان؛ قمر الصبري، عمان؛ كارلا أولهوا أندريه، البرازيل؛ إرنست كونادو أسيدو، غانا؛ هيثم محمد عوض الله، السودان؛ أونورجارغال أيورزانا، منغوليا؛ نور عائشة أبو بكر، ماليزيا؛ جوديث دياز بازان، الأرجنتين؛ نجوى بلكاب، المغرب؛ توماسو بيلاندي، إيطاليا؛ أندرو كارسون ستيفنز، المملكة المتحدة؛ الكسندر كارتر، المملكة المتحدة؛ بيردارشان

سينغ كاوسي، موريشيوس؛ جوليا دغليانا، إيطاليا؛ خافيير دافيل، المكسيك؛ جي سوداث ك دارماراتي، سريلانكا؛ مايك دوركين، المملكة المتحدة؛ إزيكويل جارسيا إلوريو، الأرجنتين؛ شارلوتا جورج، السويد؛ لينا جرافرسن، الدنمارك؛ إنغو هارتيل، ألمانيا؛ هيلين هاسكل، الولايات المتحدة الأمريكية؛ جيريمي هانت، المملكة المتحدة؛ سيد حسين جفري، باكستان؛ مريم ريجينا كاموجا، أوغندا؛ أرادهانا كوهلي، هولندا؛ ساندي كوسي، كندا؛ نورا كرونينغ، سويسرا؛ باسيا كوتريبا، بولندا؛ أندرو ليكاكا، ملاوي؛ بياوان ليمبانيالرت، تايلاند؛ جاسنا ميساريتش، كرواتيا؛ لو نيو، الصين؛ جوزيف أوكوير، أوغندا؛ نعومي بول، أستراليا؛ إيوانا كريستينا بوييسكو، كندا؛ إدوارد سالاخوف، سويسرا؛ الكسندر شو، المملكة المتحدة؛ عزيز شيخ، المملكة المتحدة؛ أنوبام سيبال، الهند؛ هارديب سينغ، الولايات المتحدة الأمريكية؛ ياولو سوزا، البرتغال؛ جيتندرا نات سريفاستافا، الهند؛ أنتوني ستينز، سويسرا؛ كوك هيان تان، سنغافورة؛ ليكلاي تيمه، ليبيريا؛ لوسيانا يومي أوي، البرازيل؛ شين أوشيرو، اليابان؛ إيفلين ويسانجولا، كينيا؛ ألبرت وو، الولايات المتحدة الأمريكية؛ جايسون يونغ، سويسرا؛ توماس زلتتر، سويسرا؛ وإسحاق زورشر، سويسرا.

المنظمات الدولية: سيلفيا باستريشيا، الاتحاد الدولي للمستشفيات؛ هوارد كاتون، المجلس الدولي للممرضات؛ ماري كوفي، الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي والأورام؛ مؤسسة كارين كوسي وغوردون وبيتي مور؛ جاي فريجا، الجمعية الأوروبية لطب الأشعة؛ مونيك هيراث، الجمعية الأوروبية لطب الأشعة؛ هيلين هيوز، التعلم في مجال سلامة المرضى؛ جو كياني، مؤسسة حركة سلامة المرضى؛ نيك كلاتينغا، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ سوزانا كوسينوف، المنظمة الدولية للمستحضرات الصيدلانية؛ بيتر لاكمان، الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية؛ كاري ماير، اللجنة الدولية المشتركة؛ باتريشيا ماكغافيجان، معهد تحسين الرعاية الصحية؛ ألكسندر ميخيا، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ جانكي ميلين-أولين، الاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير؛ ماريانا ماغدالينا ميهيلا، الجمعية

العالمي للإنتان، والتحالف الدولي لمنظمات المرضى، والمجلس الدولي للممرضات، والرابطة الدولية لبيئة العمل، والجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية، والخدمات العامة الدولية، والجمعية الدولية المعنية بالتجلط والتخثر، ومنظمة إنقاذ الطفولة – الدولية، والاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير، والجمعية الطبية العالمية، والمنظمة العالمية لأطباء الأسرة.

الدول الأعضاء التي أجرت استعراضاً وقدمت مساهمات موضوعية: الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرازيل، وبنغلاديش، وبولندا، وتايلند، وتركيا، وتونس، وتونغا، وجامايكا، وجمهورية كوريا، وسري لانكا، والسودان، وشيلي، والصين، وعمان، وغينيا – بيساو، والفلبين، وفنلندا، وكندا، وكينيا، وليبيريا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.

ونعرب عن تقديرنا وشكرنا لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، على مساهماتهم القيمة في وضع خطة العمل العالمية هذه.

وتعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها البالغ لقيادة الاستراتيجية العالمية والدعم التقني والمالي المقدم لوضع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى للفترة 2021-2030 من حكومات ألمانيا، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واليابان.

الطبية العالمية؛ كاثلين موزير، الرابطة الدولية لدراسات المهياة البيئية؛ نيامبورا موروكي، الجمعية الطبية العالمية؛ ماريا بيلار أستير بينا، المنظمة العالمية لأطباء الأسرة؛ جويس تشانغ برايس، اللجنة الدولية المشتركة؛ ليليان ريسر، الجمعية الدولية المعنية بالتجلط والتخثر؛ كارولين سامر، الاتحاد الدولي لعلم الصيدلة الأساسي والسريري؛ كوالديب سحمي، التحالف الدولي لمنظمات المرضى؛ سوزان شيريدان، جمعية تحسين التشخيص في الطب؛ ديفيد ويتاكر، الاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير.

منظمة الصحة العالمية: بينديتا أليغراني، جيرترود أفورتي، مادهافا بالاكريشنان، ماري شارلوت بويسو، أليساندرو كاسيني، كارين دانييلز، نيلام دينغرا، السير ليام دونالدسون، ستيفن أوزبورن، نورس فيندلاي، جوناثان غونسيث-غارسيا، آن ليز غيسكين، نيخيل جوبتا، ميننا وو، آن يوهانسن، ماكي كاجيوارا، بيير كلافير كاربو، إدوارد كيلي، منذر لطيف، ألبانا ماير، كين ليو، مارغريت مونتغمري، جان بوسكو نديهوكونو، سبيده باقري نجاد، إيرينا بابيفا، ماريا ديل روزاريو بيريز، كاتيانا أباريشيو ريس، نديب صفي الله، شمس ب. سيد، عائدة طه، كازومي تاناكا، ماساهيرو زاكوجي، ويفغيني زيليزنيكوف.

ووردت إسهامات مستفيضة من مختلف الأفرقة التقنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في المقر وكذلك من المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية.

المنظمات الدولية وغير الحكومية التي قدمت مساهمات موضوعية: الاتحاد الدولي للمستحضرات الصيدلانية، والتحالف

بيليوغرافيا

منظمة الصحة العالمية. 2011. الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2020-2011 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf?ua=1، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2017. خطة عمل عالمية بشأن مقاومة أدوية فيروس العوز المناعي البشري 2021-2017 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255883/9789241512848-eng.pdf?sequence=1>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2017. خطة العمل العالمية بشأن استجابة الصحة العامة للخرف 2025-2017 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259615/9789241513487-eng.pdf?sequence=1>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2017. الاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن الشيخوخة والصحة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (-WHO) (<https://www.who.int/ageing/WHO-GSAP-2017.pdf?ua=1>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2018. خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني 2030-2018: تعزيز نشاط الأشخاص من أجل عالم أوفر صحة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2019. توثيق عرى التعاون من أجل تحسين الصحة. خطة العمل العالمية بشأن تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327841/9789246516438-ara.pdf>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

القرار ج ص ع55-18. جودة الرعاية: سلامة المرضى. في: جمعية الصحة العالمية الخامسة والخمسون، جنيف، 13-18 أيار/مايو 2002 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2002 (https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ewha5518.pdf، اطلع عليه في 25 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2011. الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2020-2011 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf?ua=1، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2013. خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية في الفترة 2020-2013 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506021>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2013. خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2020-2013 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2013. استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 2023-2014 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/92455/9789241506090_eng.pdf?sequence=1، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2014. كل مولود جديد: خطة عمل لإنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/127938/9789241507448_eng.pdf?sequence=1، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2015. خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>، اطلع عليه في 28 آذار/مارس 2021).

منظمة الصحة العالمية. 2016. الاستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسي 2021-2016 [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV->

المصطلح	التعريف والمصدر المستخدمان في المسرد (انظر مراجع المسرد المستقلة أدناه)
اعتماد	عملية رسمية تُقيم من خلالها هيئة معترف بها - عادة ما تكون منظمة غير حكومية - مدى استيفاء منظمة من منظمات الرعاية الصحية للمعايير المعمول بها والمحددة مسبقاً والمنشورة، وتقر بذلك. وعادة ما تعتبر معايير الاعتماد معايير مثلى وقابلة للتحقيق، وهي مصممة لتشجيع جهود التحسين المستمر داخل المنظمات المعتمدة. ويُتخذ قرار الاعتماد المتعلق بمنظمة محددة من منظمات الرعاية الصحية بعد تقييم دوري في الموقع يجريه فريق من خبراء الاستعراض الأقران، ويُجرى هذا التقييم في العادة كل عامين أو ثلاثة أعوام. وغالباً ما يكون الاعتماد عملية طوعية تختار فيها المنظمات المشاركة، عوض أن تكون عملية ينص عليها القانون وتقتضيها اللوائح.(1)
حدث دوائي ضائر	أي إصابة ناتجة عن تدخلات طبية متصلة بأحد الأدوية. ويشمل ذلك كلا من التفاعلات الدوائية الضائرة التي لم يحدث فيها أي خطأ والمضاعفات الناتجة عن الأخطاء الدوائية.(2)
حدث ضائر	حادثة أدت إلى إلحاق الأذى بمرضى.(3)
مقدمو الرعاية	الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لفرد أو أفراد من أسرهم أو أصدقائهم أو مجتمعهم المحلي. وقد يقدمون رعاية منتظمة أو عرضية أو روتينية أو يشاركون في تنظيم الرعاية التي يقدمها آخرون.(4)
مضاعفات	مرض أو إصابة تنشأ بعد الإصابة بمرض آخر و/أو تدخل من تدخلات الرعاية الصحية).(3)
إنصاف	عدالة؛ توجه احتياجات الناس توزيع الفرص لتحقيق الرفاه. ويتمتع جميع الناس بفرصة متساوية لتحسين صحتهم والحفاظ عليها، من خلال الحصول المنصف والعادل على الموارد اللازمة للصحة.(5)
خطأ	عدم تنفيذ إجراء مخطط له على النحو المقصود أو تطبيق خطة غير صحيحة.(3)
أذى	ضعف في هيكل الجسم أو وظيفته و/أو أي أثر ضار ينشأ عن ذلك. وهو يشمل الأذى المرض والإصابة والمعاناة والإعاقة والوفاة.(3)
خطر	ظرف أو عامل أو إجراء بمقدوره أن يسبب الأذى.(3)

العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (يشار إليها أيضاً باسم "عدوى المستشفيات" أو "عدوى مستشفوية")

عدوى تصيب المريض أثناء عملية الرعاية في مستشفى أو مرفق رعاية صحية آخر، والتي لم تكن موجودة أو في فترة حضانة وقت الدخول. ويمكن أن تظهر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية أيضاً بعد التسريح.(6)

خدمة صحية

أي خدمة (لا تقتصر على الخدمات الطبية أو السريرية) تهدف إلى المساهمة في تحسين الصحة أو في تشخيص الحالة الصحية للأفراد والسكان وعلاجهم وإعادة تأهيلهم.(4)

نظام صحي

(1) جميع الأنشطة التي يتمثل غرضها الأساسي في تعزيز الصحة و/أو استعادتها و/أو الحفاظ عليها؛ (2) الأشخاص والمؤسسات والموارد، مرتبين معاً وفقاً للسياسات المعمول بها، من أجل تحسين صحة السكان الذين يتولون خدمتهم، مع الاستجابة لتطلعات الناس المشروعة وحمايتهم من تكلفة اعتلال الصحة من خلال طائفة متنوعة من الأنشطة التي تهدف أساساً إلى تحسين الصحة.(7)

عاملون صحيون

العاملون الصحيون هم جميع الأشخاص المشاركين في إجراءات عمل تهدف بشكل أساسي إلى تحسين الصحة. ويشمل ذلك مقدمي الخدمات الصحية، مثل الأطباء، والممرضين والممرضات، والقابلات، ومهنيي الصحة العامة، والتقنيين المختبريين والصحيين في المجال الطبي وغير الطبي، والعاملين في مجال الرعاية الشخصية، والعاملين في مجال الصحة المجتمعية، والمعالجين وممارسي الطب التقليدي. ويشمل ذلك أيضاً العاملين في مجال الإدارة الصحية والدعم الصحي، مثل عمال النظافة، والسائقين، ومسؤولي إدارة المستشفيات، والإداريين الصحيين في المقاطعات، والإخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من الفئات المهنية العاملة في الأنشطة ذات الصلة بالصحة. ولا يشمل العاملون الصحيون العاملين في مرافق الرعاية الحادة فحسب، بل أيضاً العاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل، والصحة العامة، والرعاية المجتمعية، والرعاية الاجتماعية، والرعاية المنزلية.(8)

عوامل بشرية

دراسة العلاقات المتبادلة بين البشر والأدوات والمعدات والأساليب التي يستخدمونها، والبيئات التي يعيشون ويعملون فيها.(3)

حادثة

أي انحراف عن الرعاية الطبية المعتادة يتسبب في إصابة المريض أو يعرضه للآذى. ويشمل الأخطاء والأحداث الضائرة التي يمكن تجنبها، والأخطار.(3)

ثقافة عادلة

بيئة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التعلم من الأخطاء والحاجة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.(3)

ترخيص

عملية تنظيمية معتمدة من الحكومة لمنح الإذن لفرد أو منظمة بممارسة الرعاية الصحية وتحديد نطاق هذه الممارسة، وعادة ما يسبق الترخيص الاعتماد.(9)

جهاز طبي

مادة أو أداة أو جهاز أو آلة تستخدم في الوقاية من اعتلال أو مرض أو تشخيصه أو علاجه، أو في الكشف عن هياكل الجسم أو وظائفه أو قياس أدائها أو استعادتها أو تصحيحها أو تعديلها تحقيقاً لأغراض صحية معينة. وعادة ما لا يتحقق الغرض المتوخى من الجهاز الطبي بالوسائل الدوائية أو المناعية أو الأيضية.(4)

خطأ طبي

حدث ضائر أو على وشك الوقوع يمكن الوقاية منه في ظل الحالة الراهنة للمعارف الطبية.(3)

خطأ في إعطاء الدواء

أي حدث يمكن الوقاية منه ومن شأنه أن يتسبب في استخدام غير مناسب للأدوية أو إلحاق الأذى بالمريض أو يؤدي إلى ذلك حينما يكون الدواء بيد أخصائي الرعاية الصحية أو المريض أو المستهلك. (2)

السياسة الوطنية لسلامة المرضى

بيان حكومي رسمي يحدد أولويات وبارامترات العمل استجابة لاحتياجات البلد والموارد المتاحة والاعتبارات السياسية، ويوضع بالتشاور الوثيق مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية (10)

وشيك الوقوع

حادثة لم تصب المريض. (3)

حدث لا ينبغي وقوعه

حادثة تتعلق بسلامة المرضى وتؤدي إلى أذى جسيم يلحق بالمريض أو إلى وفاته (ويشير ذلك إلى أخطاء طبية صادمة للغاية - مثل الجراحة في الموقع الخطأ، التي لا ينبغي أن تحدث أبداً). (11)

تمكين المرضى

عملية يفهم فيها المرضى دورهم، ويزودهم فيها مقدم الرعاية الصحية الذي يُعنى بهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهمة من المهام في بيئة تُقر بالاختلافات المجتمعية والثقافية وتشجع مشاركة المرضى. (12)

إشراك المرضى

تيسير وتعزيز دور الأشخاص الذي يستخدمون الخدمات كمشاركين في وضع السياسات والممارسات المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية. (13)

سلامة المرضى

سلامة المرضى هي إطار للأنشطة المنظمة التي تولّد ثقافات وعمليات وإجراءات وسلوكيات وتكنولوجيات وبيئات في مجال الرعاية الصحية التي تعمل على التقليل من المخاطر بشكل مستمر ومستدام، والحد من حدوث أذى يمكن تجنبه، وتجعل وقوع الخطأ أقل احتمالاً وتحد من تأثيره لدى حدوثه. (11)

يمكن الوقاية منه

ما يقبله المجتمع المحلي باعتباره وضعاً يمكن تجنبه في إطار مجموعة معينة من الظروف. (3)

رعاية أولية

عملية رئيسية في النظام الصحي تدعم الرعاية المتاحة والمستمرة والشاملة والمنسقة التي تركز على المريض عند الاتصال الأول. (4)

جودة

مدى زيادة احتمال تحقيق النتائج الصحية المرجوة عن طريق الخدمات الصحية المتاحة للأفراد والسكان واتساق هذه الخدمات مع المعارف المهنية الحالية. (3)

القدرة على الصمود

قدرة جميع الجهات الفاعلة والوظائف المتصلة بالصحة، على التخفيف من الحوادث المعطلة التي تترتب عليها آثار على الصحة العامة، والاستعداد والتصدي لها والتعافي منها جماعياً، مع المحافظة على توفير الوظائف والخدمات الأساسية، واستخدام الخبرات اللازمة لتكييف نظام التحسين وتغييره. (14)

مخاطر

احتمال وقوع خطر أو خسارة أو إصابة داخل نظام الرعاية الصحية. (3)

سبب جذري

السبب الأساسي لوقوع حدث من الأحداث. (3)

رعاية مأمونة

تستلزم الرعاية المأمونة اتخاذ قرارات سريرية قائمة على البيانات لتحقيق أقصى قدر ممكن من النتائج الصحية للفرد وتقليل احتمال وقوع الأذى إلى أدنى حد. (3)

ثقافة السلامة

ثقافة السلامة لمنظمة من المنظمات هي نتاج قيم ومواقف وتصورات وكفاءات وأنماط سلوك فردية وجماعية تحدد خصائص إدارة الصحة والسلامة في المنظمة. وتتميز المنظمات التي لديها ثقافة سلامة إيجابية بالاتصالات القائمة على الثقة المتبادلة، والتصورات المشتركة لأهمية السلامة، والثقة في فعالية التدابير الوقائية. (15)

إتقان

اختلال وظيفي للأعضاء يهدد الحياة وينجم عن استجابة المضيف بصورة غير مضبوطة للعدوى. (16)

نهج قائم على النظم

استخدام تحقيق سريع ومكثف يتبعه تحليل نظم متعددة التخصصات ... [للكشف] عن أسباب الخطأ القريبة والنظامية على حد سواء ... وهو يستند إلى مفهوم مفاده أنه على الرغم مما يرتكبه الأفراد من أخطاء، فإن خصائص النظم التي يعملون في إطارها قد تزيد من احتمال وقوع هذه الأخطاء، وتزيد كذلك من صعوبة اكتشافها وتصحيحها. وعلاوة على ذلك، فهو يتخذ موقفاً مفاده أن تحمل الأفراد مسؤولين للمسؤولية المتعلقة بالعمل الذي يقدمونه سيؤدي إلى تقادي المزيد من الأخطاء من خلال التركيز على النظم أكثر من التركيز على الأفراد. وهو يستعيض عن التحري عن يوجه إليه اللوم ويركز على الظروف وليس على الشخص. (3)

انتقال الرعاية

النقاط المختلفة التي ينتقل فيها المريض إلى مكان مادي معين أو يعود منه أو يتصل بأخصائي في مجال الرعاية الصحية لأغراض الحصول على هذه الرعاية. (17)

التغطية الصحية الشاملة

تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل جميع الأشخاص والمجتمعات المحلية على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا لضائقة مالية. وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بدءاً من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطفة طوال العمر. (18)

- 1- Rooney AL, van Ostenberg PR. Licensure, accreditation, and certification: approaches to health services quality. Bethesda (MD): United States Agency for International Development; 1999.
- 2- مأمونية الدواء في ظل تعدد الأدوية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/medication-safety-in-polypharmacy-technical-report>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 3- الإطار المفاهيمي للتصنيف الدولي لسلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2009 (<https://www.who.int/publications/i/item/the-conceptual-framework-for-the-international-classification-for-patient-safety-icps>)، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021.
- 4- الإطار التشغيلي للرعاية الصحية الأولية: تحويل الرؤية إلى عمل [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، 2020. (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240017832>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 5- خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة 2018-2030: تعزيز نشاط الأشخاص من أجل عالم أوفر صحة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/272722>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 6- مبادئ توجيهية بشأن العناصر الأساسية لبرامج الوقاية من حالات العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني ومستوى مرافق الرعاية الصحية للحالات المرضية الحادة [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549929>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 7- مسرد بشأن تعزيز النظم الصحية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011 (https://www.who.int/healthsystems/Glossary_January2011.pdf، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 8- ميثاق سلامة العاملين الصحيين: الأولوية لسلامة المرضى [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240011595>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 9- دليل لوضع سياسات واستراتيجية وطنية بشأن الجودة: نهج عملي لوضع السياسات والاستراتيجيات لتحسين نوعية الرعاية [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241565561>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 10- دليل بشأن وضع السياسات والخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بسلامة المرضى [بالإنكليزية]. برازافيل: مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا؛ 2014 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206546/9789290232070.pdf?sequence=1&isAllowed=y>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 11- نظم الإبلاغ والتعلم المتعلقة بالحوادث المتصلة بسلامة المرضى: تقرير تقني وإرشادات [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240010338>، اطلع عليه في 12 تموز/يوليو 2021).
- 12- منظمة الصحة العالمية، التحالف العالمي لسلامة المرضى. مبادئ توجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن نظافة الأيدي في مجال الرعاية الصحية: التحدي العالمي الأول بشأن سلامة المرضى - الرعاية النظيفة رعاية أكثر مأمونية [بالإنكليزية].

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801–10. <https://dx.doi.org/10.1001%2Fjama.2016.0287>

17- انتقال الرعاية: سلسلة تقنية عن الرعاية الأولية الأكثر أماناً [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 <https://www.who.int/publications-detail-redirect/transitions-of-care>؛ اطلع عليه في 12 تموز/ يوليو (2021).

18- صحيفة وقائع: التغطية الصحية الشاملة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021 [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc))؛ اطلع عليه في 12 تموز/ يوليو (2021).

جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2009 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906>)، اطلع عليه في 12 تموز/ يوليو (2021).

13- إشراك المرضى: سلسلة تقنية بشأن الرعاية الأولية الأكثر أماناً [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 <https://www.who.int/publications/i/item/patient-engagement>؛ اطلع عليه في 12 تموز/ يوليو (2021).

14- مجموعة أدوات بشأن قدرة النظم الصحية على الصمود [بالإنكليزية]. جنيف: منظمة الصحة العالمية (لم تنشر)

15- American College of Healthcare Executives and IHI/NPSF Lucian Leape Institute. Leading a Culture of Safety: A Blueprint for Success. Boston (MA): American College of Healthcare Executives and Institute for Healthcare Improvement; 2017 (<http://www.ihl.org/resources/Pages/Publications/Leading-a-Culture-of-Safety-A-Blueprint-for-Success.aspx>)؛ اطلع عليه في 12 تموز/ يوليو (2021).

